



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN TAHUNAN

KOMITE PMKP RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54,

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN TAHUNAN KOMITE MUTU
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Sukorejo, 31 Desember 2025

Telah Disetujui Oleh :

Direktur PT. Disa Prima Medika

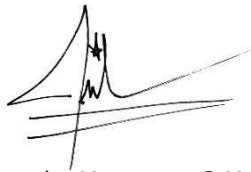


(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TAHUNAN KOMITE MUTU
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP, CHAE.)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Kinerja Komite PMKP Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Tahunan Komite PMKP Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada bulan berikutnya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.2 Dasar Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Ruang Lingkup 6

BAB II 8

2.1 Visi 8

2.2. Misi 8

2.3. Motto 8

2.4. 7 Nilai Budi Utama..... 8

BAB III 10

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI 10

3.1 SDM..... 10

3.2. Pengembangan Pelayanan 14

3.3. Hasil Kinerja Mutu RS..... 14

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional 18

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 31

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
36

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit..... 74

1. INSTALASI GAWAT DARURAT 74

2. INSTALASI RAWAT JALAN 76

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A..... 79

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B..... 83

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A..... 88

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B..... 91

7. INSTALASI KAMAR OPERASI 96

8. MATERNITAS 100

9. PONEK 104

10. NEONATOLOGI..... 106

11. ICU..... 108

12. RADIOLOGI..... 111

13. LABORATORIUM 113

14. REHAB MEDIS 115

15. FARMASI 117

16.	GIZI.....	118
17.	REKAM MEDIS.....	120
18.	LIMBAH – K3RS	122
19.	SDM.....	123
20.	KESEKRETARIATAN	124
21.	DRIVER.....	125
22.	PEMULASARAAN JENAZAH	126
23.	ATEM – IPSRS	126
24.	LAUNDRY.....	127
25.	CSSD	128
26.	CLEANING SERVICE	130
27.	KEAMANAN	131
28.	GUDANG UMUM.....	133
29.	PPI.....	133
30.	PKRS.....	135
31.	ASURANSI CENTER	137
32.	HUMAS & MARKETING	138
33.	CSO.....	138
34.	MOD-MPP-PIPP	139
35.	TB di IRJA.....	140
36.	KEUANGAN	140
37.	TIM HIV	141
38.	KB	141
39.	STUNTING	142
40.	IT - SIM RS.....	143
BAB IV.....		144
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KESELAMATAN PASIEN		144
4.1	Jumlah Ketidaksesuaian Diagnosis Praoperasi dan Pasca Operasi pada Tahun 2025	144
4.2	Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Berdasarkan Kejadian Reaksi Transfusi	146
Analisis:.....		147
Rekomendasi:		147
2.	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	148
3.	Phlebitis	148
4.	Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)	148
2.	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	148
3.	Phlebitis	148
•	Penggunaan Kateter dengan Bahan yang Lebih Ramah	148
•	Rotasi Lokasi Infus	148
4.	Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)	148

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di perlukan pendekatan secara komperhensif yang berdampak peningkatan mutu pada setiap aspek. Banyaknya aspek semua proses di Rumah Sakit dapat diukur dan diperbaiki secara bersamaan, untuk itu Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memilih proses dan hasil (outcome) praktek klinik dan manajemen yang harus dinilai (diukur) dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis serta sistem pelayanan.

Upaya pengukuran dan perbaikan/peningkatan mutu yang mempengaruhi aktivitas yang terdapat di berbagai unit pelayanan, termasuk pengukuran dan aktivitas yang berhubungan dengan kepatuhan penuh terhadap Sasaran Keselamatan Pasien. Penilaian seringkali terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, berbiaya tinggi, atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo bertanggung jawab menentukan pilihan terakhir dari topik prioritas pelayanan yang digunakan dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan secara komprehensif dan secara terus menerus.

Pemilihan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh dan dapat dilakukan di berbagai unit klinis maupun non klinis. Prioritas perbaikan tersebut harus dilakukan pengukuran dalam bentuk indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS). Komite dan melakukan koordinasi & integrasi pengukuran mutu di unit pelayanan prioritas serta melakukan supervisi dalam proses pengumpulan data.

Berikut merupakan dasar penentuan mutu prioritas Rumah sakit tahun 2025.

Tabel 1.1. Daftar 10 besar Penyakit di Rawat Jalan RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

NO	Code ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	Z50.1	Other physical therapy	8772
2	Z09.8^E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	7996
3	Z09.8^I11.9	Hypertensive heARV disease without (congestive) heARV failure	6534
4	Z09.0	Follow-up examination after surgery for other conditions	5527
5	Z09.8^I69.3	Sequelae of cerebral infarction	4015
6	Z09.8^M17.9	GonARVhrosis, unspecified	3246
7	Z48.0	Attention to surgical dressings and sutures	3089
8	Z09.8^J43.9	Emphysema, unspecified	3055
9	Z09.3	Follow-up examination after psychotherapy	2564
10	Z09.8^H25.9	Senile cataract, unspecified	2321

Tabel 1.2. Daftar 10 besar Penyakit di Rawat Inap RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

NO	Code ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	914

NO	Code ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
2	A01.0	Typhoid fever	819
3	J18.9	Pneumonia, unspecified	678
4	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	603
5	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	506
6	A90	Dengue fever [classical dengue]	481
7	K30	Dyspepsia	455
8	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	428
9	D36.7	Benign neoplasm, other specified sites	369
10	B34.9	Viral infection, unspecified	362

Tabel 1.3 Lembar Kerja Matrix Prioritas Perbaikan Mutu RS Tahun 2025 berdasarkan 8 kriteria

Area Prioritas	Resiko Tinggi			Jumlah Banyak			Merupakan masalah bagi RS			Kemudahan dalam pengukuran		
	Tidak / sedikit berisiko	Cukup berisiko	Berisiko sangat tinggi	Tidak ada / sedikit jumlahnya	Jumlahnya cukup banyak	Jumlahnya sangat banyak	Tidak ada / sedikit potensi masalah	Potensi masalah sedang	Potensi masalah besar	Sulit diukur	Cukup mudah diukur	Mudah diukur
	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)
Poliklinik		3				5		3			3	
IGD			4			5			4		3	
Rehabilitasi medik					3		2				3	
ICU			4		3			3				5
Kamar Operasi			5			4			5			4
Rawat Inap		3				4			4			4
Farmasi			4			5			4	2		

Area Prioritas	Resiko Tinggi			Jumlah Banyak			Merupakan masalah bagi RS			Kemudahan dalam pengukuran		
	Tidak / sedikit berisiko	Cukup berisiko tinggi	Berisiko sangat tinggi	Tidak ada / sedikit jumlahnya	Jumlahnya cukup banyak	Jumlahnya sangat banyak	Tidak ada / sedikit potensi masalah	Potensi masalah sedang	Potensi masalah besar	Sulit diukur	Cukup mudah diukur	Mudah diukur
	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)
Radiologi	2				3			3			3	
Laboratorium	2				3		2					4
Gizi	2				3		1					4
Maternitas		3			3			3			3	

Hubungan dengan ketidakpuasan pasien			Hubungan dengan ketentuan pemerintah			Sesuai dengan tujuan strategi RS			Memberikan pengalaman pasien lebih baik (patient experience)			Skor Prioritas
Tidak / sedikit hubungan	Cukup berhubungan	Sangat berhubungan	Tidak / sedikit hubungan	Cukup berhubungan	Sangat berhubungan	Tidak sesuai dengan tujuan	Cukup sesuai dengan tujuan	Sesuai dengan tujuan	Memberikan pengalaman lebih baik	Cukup memberikan pengalaman lebih baik	Sangat memberikan pengalaman	
(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	(1-2)	3	(4-5)	
		5			4			4			5	32
		5			4			4			5	34
	3			3			3				4	21
	3				4			4		3		29
		5			5			5			5	38
		5			4			5			5	34

		5			5			4			5	34
	3			3				4		3		24
2				3				4		3		23
	3			3				4		3		23
		4			5			4			4	29

Berdasarkan tabel 1.3 matrix tersebut dapat ditarik kesimpulan program PMKP mengambil area prioritas Rumah sakit untuk tahun 2025 adalah Unit Kamar operasi, dengan dasar pemilihan dilihat berdasarkan Risiko tinggi, jumlah banyak, masalah bagi RS, kemudahan pengukuran, hubungan ketidakpuasan pasien, hubungan dengan pemerintah, sesuai tujuan strategis Rumah Sakit dan memberikan pengalaman pasien lebih baik.

Pencapaian skor tertinggi pada unit kamar operasi mengindikasikan adanya kompleksitas tinggi yang harus diimbangi dengan kompetensi staf. Alasan pelaksanaan diklat meliputi :

- 1) Standarisasi kompetensi teksnis mengingat Kamar Operasi adalah area dengan *high risk* dan *high cost*. Diklat diperlukan untuk memastikan seluruh staf memiliki kompetensi seragam sesuai SPO terbaru untuk menekan angka KTD
- 2) Fokus pada implementasi SSC yang lebih disiplin untuk mengubah budaya kerja agar pengisian checklist bukan sekedar formalitas melainkan alat control keselamatan.
- 3) Manajemen risiko dan pencegahan infeksi
- 4) Optimalisasi penggunaan teknologi medik

Rencana strategi yang dilakukan di tahun 2025 antara lain pelaksanaan audit klinis dan telaah tekam medis yang dilakukan secara berkala pada kasus bedah dengan *high volume*, *high cost*, *high risk* untuk memastikan kesesuaian antara tindakan dengan panduan praktek klinis, digitalisasi monitoring mutu dan peningkatan *patient experience* melalui edukasi pre operatif.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 2) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3) Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

-
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
 - 15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Elektronik)
 - 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - 17) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - 18) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
 - 19) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 20) Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 463/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - 21) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
 - 22) Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/174 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Prioritas
 - 23) Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
 - 24) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - 25) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Mengevaluasi Kinerja Mutu
Untuk memberikan penilaian menyeluruh mengenai kinerja Komite Mutu selama periode tahun 2025. Evaluasi ini mencakup pencapaian target mutu, efektivitas strategi yang diterapkan, serta pengukuran keberhasilan dalam implementasi sistem manajemen mutu.
- 2) Mengidentifikasi Kendala dan Masalah
Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mutu. Identifikasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas sistem mutu.
- 3) Memberikan Rekomendasi Perbaikan
Untuk menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam merumuskan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk peningkatan mutu di masa mendatang.
- 4) Menyediakan Informasi kepada Stakeholder
Untuk menyajikan informasi yang transparan dan komprehensif kepada manajemen dan seluruh stakeholder mengenai upaya, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi oleh Komite Mutu. Informasi ini penting untuk

menjaga keterlibatan dan dukungan stakeholder terhadap upaya perbaikan mutu.

5) Menilai Implementasi dan Kepatuhan

Untuk menilai sejauh mana implementasi sistem manajemen mutu dan kepatuhan terhadap standar serta kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Penilaian ini juga meliputi audit internal dan eksternal yang dilakukan selama periode laporan.

6) Menyusun Strategi untuk Perbaikan Berkelanjutan

Untuk memberikan dasar dalam penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan yang akan diterapkan di semester berikutnya. Laporan ini bertujuan untuk membantu perencanaan dan pengembangan kebijakan mutu yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

7) Mengukur Dampak Inisiatif Mutu

Untuk mengevaluasi dampak dari inisiatif dan proyek-proyek mutu yang telah dilaksanakan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut memberikan manfaat yang signifikan dan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan mutu organisasi.

1.4. Ruang Lingkup

Laporan Komite Mutu Tahun 2025 mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1) Evaluasi Kinerja Kegiatan Mutu

Proses dan Metodologi: merupakan penilai efektivitas proses dan metodologi yang diterapkan oleh Komite Mutu, termasuk pelaksanaan sistem manajemen mutu, audit internal, dan kegiatan pemantauan mutu. Pencapaian Target: Evaluasi pencapaian target mutu yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, serta analisis terhadap pencapaian dan ketidaksesuaian.

2) Analisis dan Identifikasi Kendala

Masalah dan Hambatan merupakan identifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mutu, serta analisis penyebabnya. Solusi dan Tindakan Korektif: Penilaian terhadap solusi dan tindakan korektif yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah dan hambatan tersebut.

3) Audit dan Kepatuhan

Audit Internal merupakan laporan hasil audit internal yang mencakup penilaian kepatuhan terhadap prosedur dan standar mutu, serta tindak lanjut dari temuan audit. Audit eksternal merupakan evaluasi hasil audit eksternal (jika ada misal dari PT atau hasil PPS akre atau BPJS atau Dinkes) yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk rekomendasi yang diberikan dan tindak lanjutnya.

4) Program Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan Karyawan merupakan penilaian efektivitas program pelatihan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran karyawan mengenai mutu, serta hasil dari pelatihan tersebut. Pengembangan Kapasitas: Analisis terhadap pengembangan kapasitas dan keterampilan karyawan dalam mendukung pencapaian standar mutu.

5) Inisiatif dan Proyek Mutu

Inisiatif terbaru merupakan evaluasi terhadap inisiatif dan proyek mutu yang dilaksanakan selama satu tahun, termasuk penilaian dampaknya terhadap peningkatan mutu. Proyek Khusus: Laporan mengenai proyek-proyek khusus yang dijalankan untuk memperbaiki proses atau meningkatkan produk/layanan jika ada.

6) Feedback dan Kepuasan Pelanggan

Pengumpulan Data: Analisis data feedback dari pelanggan yang diperoleh selama periode laporan, serta penilaian terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan tren yang teridentifikasi. Tindakan Perbaikan merupakan penilaian terhadap tindakan perbaikan yang diambil berdasarkan feedback pelanggan dan efektivitas tindakan tersebut.

-
- 7) Kolaborasi dan Koordinasi
Kerjasama antar departemen merupakan evaluasi terhadap kerja sama dan koordinasi antar departemen dalam mendukung upaya peningkatan mutu, serta penilaian terhadap integrasi sistem dan proses. Komunikasi dan Integrasi adalah analisis efektivitas komunikasi dan integrasi antara Komite Mutu dan unit-unit lain dalam organisasi, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan mutu.
 - 8) Penilaian Terhadap Kebijakan dan Prosedur
Kebijakan Mutu merupakan evaluasi penerapan dan efektivitas kebijakan mutu yang ada, analisis terhadap kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan standar terkini. Prosedur Operasional: Penilaian terhadap prosedur operasional yang diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu dan efektivitasnya dalam implementasi.
 - 9) Laporan Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut
Laporan Kinerja merupakan ringkasan pencapaian kinerja Komite Mutu selama periode satu tahun dan keberhasilan dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rencana Tindak Lanjut: Usulan rencana dan strategi untuk periode berikutnya, berdasarkan temuan.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2. Misi

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
- 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

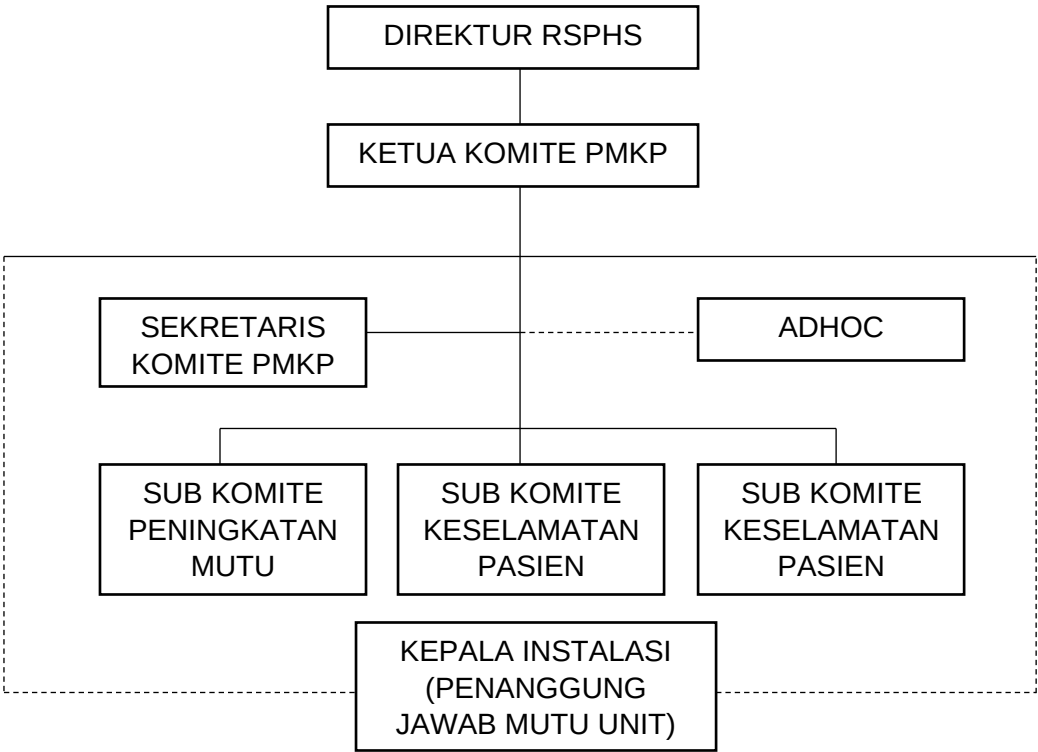
2.3. Motto

Motto kami adalah “**Sahabat Menuju Sehat**”, yang berARVi berperan sebagai sahabat kepada pasien (sahabat) dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menempatkan setiap pasien sebagai bagian keluarga, memposisikan diri kita sebagai pasien sehingga kami mengerti apa yang harus kami berikan kepada pasien

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1) Jujur
- 2) Dipercaya
- 3) Tanggungjawab
- 4) Visioner
- 5) Disiplin
- 6) Kerjasama
- 7) Adil
- 8) Peduli

2.5. SOTK Komite Mutu RS



Tabel 2.1 Susunan Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Rumah Sakit /Instalasi	Nama
I.	Penanggung Jawab	Direktur	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep
II.	Ketua	Staf	-
III.	Sekretaris	Staf	Lidia Puspita Kencana, S.K.M
Sub Komite Mutu			
IV.	Ketua	Kabid Pelayanan Medis	Ns. Sisca Puspita Sari, S.Kep., M.Kep
	Anggota	Bidan	Karunia Rizqi Nurandini, A.Md.Keb
		Verifikator	Rhizqita Julian Eka Rahmanda, Amd. PK., S.KM
		Perekam medik	Fina Fitriana Dwi Nur, Amd. RMIK
		Perawat	Lillo Palupi Armaidah, A.Md.Kep
Sub Komite Keselamatan Pasien			
V.	Ketua	Kabid Penunjang	Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep.
	Anggota	Perawat	Allamul Angga Gilang Nishvu Ramadhan, S. Kep., Ns
		MOD	Nuri Aini Izzah, S. Kep., Ns
		Bidan	Ninis Indrawati, S.Tr. Keb.
		PKRS	Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes
Sub Komite Manajemen Risiko			
VI.	Ketua	K3RS	Restu Kurniawati, S.KM
	Anggota	PPI	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns
		Farmasi	Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.
		Perawat	Sinta Olivia Rahayu., S.Kep Ns

BAB III

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM

3.1.1. Kebutuhan SDM

Merujuk pada PMK No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu, organisasi mutu harus dibentuk untuk menyelenggarakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dalam hal kualifikasi ideal Ketua Komite (Dokter dengan kompetensi tambahan) belum dapat terpenuhi, faskes mengambil kebijakan mitigasi agar fungsi tata kelola mutu tetap berjalan tanpa melanggar prinsip regulasi.

Sepanjang tahun 2025 operasional Komite PMKP dilaksanakan oleh tim transisi. Hal ini disebabkan oleh kekosongan posisi Ketua Komite PMKP yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam PMK No. 80 Tahun 2020 untuk Rumah Sakit di mana posisi tersebut seharusnya diisi oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi tambahan di bidang manajemen mutu. Saat ini, tidak ada tenaga medis (dokter) di lingkungan RS Prima Husada Sukorejo yang memiliki sertifikasi atau kualifikasi formal di bidang PMKP.

Dampak terhadap kinerja terkait ketiadaan ketua dengan kualifikasi spesifik ini berdampak pada proses analisis data RCA (*Root Cause Analysis*), *Clinical Pathway* serta dalam FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*) memerlukan supervisi medis yang mendalam dan potensi temuan ketidaksesuaian (*non-conformity*) pada elemen penilaian Tata Kelola Mutu dan Keselamatan Pasien.

Berdasarkan evaluasi kinerja di atas, maka dalam rencana kerja tahun 2026, Komite PMKP Memohon kepada Direktur dan Manajemen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan bagi minimal 2 (dua) orang Dokter dan staf untuk mengikuti Pelatihan PMKP/Manajemen Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersertifikasi secara nasional. Hal ini bertujuan agar syarat kualifikasi Ketua Komite sesuai regulasi Kemenkes dapat terpenuhi. Jika pelatihan internal belum memungkinkan dalam jangka pendek, direkomendasikan untuk melakukan rekrutmen tenaga medis dengan kontrak kerja yang mencakup peran tata kelola mutu, atau menunjuk Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang ada dengan pemberian insentif manajerial yang sesuai untuk menjalankan fungsi ini.

3.1.2. Orientasi (pengisian Mutu untuk orientasi staf baru)

Telah dilaksanakan orientasi pada 30 Desember 2025 kepada 50 staf baru yang meliputi unit security, perawat, farmasi dan sebagainya.

Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi Umum Bagi Karyawan baru
RSPH Sukorejo Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta Orientasi	Rincian	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	
					Pre Test	Post Test
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	50	36 hadir (72%), 14 orang (28%) tidak hadir	36 orang	53,15	92,50
Total		50	36 hadir (72%), 14 orang (28%) tidak hadir	36 orang	53,15	92,50

3.1.3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Mutu:)

1. Peserta Yang Mengikuti Tes Teori

No	Sasaran	Jumlah				Presentasi peserta
		Peserta Diundang	Peserta yang Mengerjakan		Peserta yang tidak mengerjakan pre & post	
			Pre Test	Post Test		
1	Cleaning Service	41	32	32	9	78,05%
2	Pantry	4	4	4	0	100%
3	Security	11	11	9	0	100%
4	Pendaftaran	19	17	17	2	89,47%
5	Driver	7	4	1	3	57,14%
6	Atem	2	2	2	0	100%
7	IPSRS	4	3	3	1	75%
8	Rekam Medis	9	8	8	1	88,89%
9	Asuransi Center	12	12	12	0	100%
10	Kasir	10	10	9	0	100%
11	Dapur	10	9	8	1	90%
12	Laundry	6	5	3	1	83,33%
13	CSSD	4	4	4	0	100%
14	Radiologi	7	4	3	3	57,14%
15	Gizi	6	6	6	0	100%

No	Sasaran	Jumlah				Presentasi peserta
		Peserta Diundang	Peserta yang Mengerjakan		Peserta yang tidak mengerjakan pre & post	
			Pre Test	Post Test		
16	Farmasi	47	43	43	4	91,49%
17	Laboratorium	12	10	10	2	83,33%
18	Gudang Umum	1	1	1	0	100%
19	IT & SIMRS	3	3	3	0	100%
20	Humas & Marketing	2	2	2	0	100%
21	IKO	13	6	3	7	46,15%
22	IRJA	29	18	15	11	62,07%
23	IGD	30	11	8	19	36,67%
24	IRNA 2A	26	20	18	6	76,92%
25	IRNA 2B	24	11	10	13	45,83%
26	MOD-MPP-PIPP	5	5	5	0	100%
27	IRNA 3A	21	19	16	2	90,48%
28	IRNA 3B	17	17	12	0	100%
29	ICU	12	11	11	1	91,67%
30	Neonatologi & NICU	12	12	12	0	100%
31	Maternitas	14	13	11	1	92,86%
32	Sekretariat	7	6	6	1	85,71%
Total		427	339	307	88	85,07%

Tes teori pelatihan PMKP dilakukan melalui kuesioner dengan media google formulir. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Tahun 2025 diikuti oleh berbagai unit kerja di rumah sakit dengan total peserta yang diundang sebanyak 427 orang. Dari total 427 peserta yang diundang, hanya 339 peserta (79,39%) yang mengikuti pre test dan 307 peserta (71,89%) yang menyelesaikan post test. Sebanyak 88 peserta (20,61%) tidak mengikuti pre maupun post test, yang berpotensi menurunkan capaian evaluasi pelatihan secara keseluruhan.

Beberapa unit yang menunjukkan partisipasi 100% yaitu pantry, security, atem, Asuransi center, CSSD, Gizi, Gudang Umum, IT, Humas & Marketing, MOD, IRNA 3B dan Neonatologi-NICU. Unit-unit ini menunjukkan komitmen penuh terhadap program pelatihan, dan dapat dijadikan contoh pengelolaan SDM yang baik dalam mendukung mutu dan keselamatan pasien.

Adapun unit dengan partisipasi rendah seperti IGD 36,67%, IKO 46,15%, IRNA 2B 45,83%, IRJA 62,07%. Unit-unit ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim manajemen untuk mengevaluasi hambatan partisipasi seperti jadwal, dan beban kerja.

2. Peserta Yang Megikuti Tes Praktek

No	Sasaran	Jumlah			Presenatasi Kehadiran
		Peserta Diundang	Peserta Hadir	Peserta Tidak Hadir	
1	Cleaning Service	41	41	0	100%
2	Pantry	4	4	0	100%
3	Security	11	10	1	90,91%
4	Pendaftaran	19	15	4	78,95%
5	Driver	7	1	6	14,29%
6	Atem	2	2	0	100%
7	IPSRS	4	4	0	100%
8	Rekam Medis	9	8	1	88,89%
9	Asuransi Center	12	12	0	100%
10	Kasir	10	10	0	100%
11	Dapur	10	1	9	10%
12	Laundry	6	4	2	66,67%
13	CSSD	4	4	0	100%
14	Radiologi	7	2	5	28,57%
15	Gizi	6	6	0	100%
16	Farmasi	47	40	7	85,11%
17	Laboratorium	12	10	2	83,33%
18	Gudang Umum	1	1	0	100%
19	IT & SIMRS	3	3	0	100%
20	Humas & Marketing	1	1	0	100%
21	IKO	13	12	1	92,31%
22	IRJA	29	13	16	44,83%
23	IGD	30	15	15	50%
24	IRNA 2A	26	22	4	84,62%
25	IRNA 2B	24	16	8	66,67%
26	MOD-MPP-PIPP	5	5	0	100%
27	IRNA 3A	21	18	3	85,71%
28	IRNA 3B	17	11	6	64,71%
29	ICU	12	8	4	66,67%
30	Neonatologi & NICU	12	12	0	100%
31	Maternitas	14	10	4	71,43%
32	Sekretariat	7	6	1	85,71%
Total		426	327	99	76,76%

Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Tahun 2025 diikuti oleh berbagai unit kerja di rumah sakit dengan total peserta yang diundang sebanyak 426 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 327 peserta hadir, sedangkan 99 peserta tidak hadir, dengan tingkat kehadiran keseluruhan mencapai 76,76%.

Unit dengan Kehadiran 100% yakni Cleaning Service, Pantry, Atem IPSRS, Asuransi Center, Kasir, CSSD, Gizi, Gudang Umum, IT & SIMRS, Humas & Marketing, MOD-MPP-PIPP dan Neonatologi-NICU. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dari unit-unit tersebut terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Unit dengan kehadiran <50% yang perlu menjadi perhatian untuk kegiatan pelatihan berikutnya yakni Dapur 10%, Driver 14,29%, Radiologi 28,57%, IRJA 44,83%, dan IGD 50%. Rendahnya kehadiran dari beberapa unit ini dapat disebabkan oleh faktor operasional atau jadwal kerja yang padat dan perlu dikaji lebih lanjut untuk perbaikan pada pelatihan mendatang.

Secara umum, pelatihan ini mendapatkan respon yang cukup baik yakni 76,76% peserta yang hadir. Adapun 23,24% peserta yang tidak hadir akan dijadwalkan ulang. Meskipun begitu, beberapa unit masih perlu peningkatan dalam hal partisipasi, agar pelatihan dapat merata dan berdampak optimal di seluruh unit pelayanan rumah sakit.

3. Hasil Pre Dan Post Test

a. Hasil Pre dan Post Test Teori

No	Skor Nilai		Jumlah Peserta			
	Kategori	Nilai	Pre Test	Presentase	Post Test	Presentase
1	Lulus	80 – 100	209	61,65%	271	88,27%
2	Tidak Lulus	<80	130	38,35%	36	11,73%
Jumlah			339	100%	307	100%

Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman teori setelah dilakukan intervensi atau pelatihan. Jumlah peserta lulus meningkat sebanyak 62 orang (dari 209 ke 271) dan Persentase kelulusan meningkat sebesar 26,62%. Jumlah peserta tidak lulus menurun sebanyak 94 orang (dari 130 ke 36) dan Persentase tidak lulus menurun sebesar 26,62%. Metode pembelajaran atau pelatihan yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan capaian pengetahuan peserta. Tingginya angka kelulusan pada post-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menyerap materi dengan baik.

b. Hasil Pre dan Post Test Praktek

No	Skor Nilai		Jumlah Peserta			
	Kategori	Nilai	Pre Test	Presentase	Post Test	Presentase
1	Lulus	80 – 100	146	44,65%	313	95,72%
2	Tidak Lulus	<80	181	55,35%	14	4,28%
Jumlah			327	100%	327	100%

Terdapat peningkatan kelulusan peserta setelah pelatihan, kenaikan jumlah peserta yang lulus dari 146 menjadi 313 orang (naik 167 orang atau 114,38%). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan efektif meningkatkan pengetahuan peserta, yang tercermin dari meningkatnya presentase kelulusan setelah pelatihan berlangsung

3.2. Pengembangan Pelayanan

3.3. Hasil Kinerja Mutu RS

- 1. Pencapaian Indikator Mutu Nasional
Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

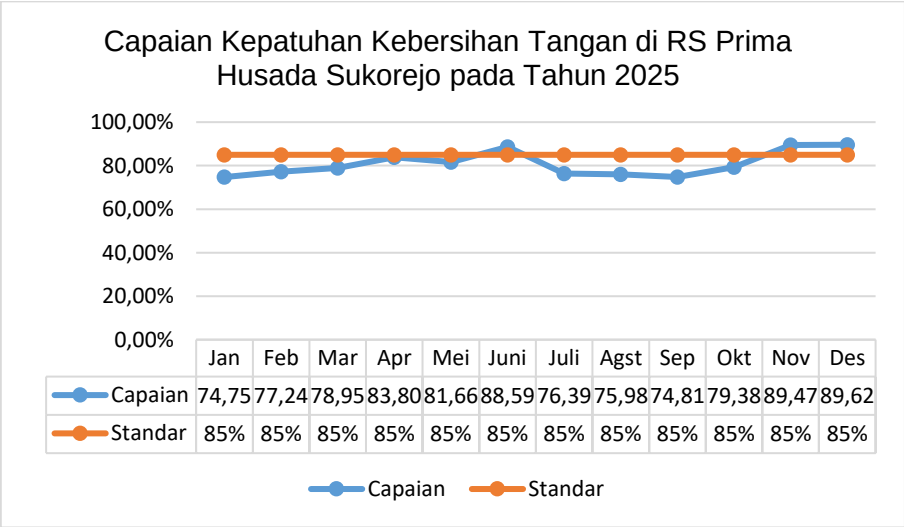
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%	76,39%	75,98%	74,81%	79,38%	89,47%	89,62%	≥85%	80,89%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	89,64%	89,87%	84,84%	97,92%	98,07%	93,83%	92,01%	83,84%	83,55%	91,48%	97,28%	92,31%	100%	97,66%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	98,30%	99,76%	99,66%	99,65%	99,73%	98,97%	99,80%	99,56%	99,68%	99,70%	99,72%	99,71%	100%	99,52%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	95,45%	92,31%	100%	96,77%	85,71%	100%	100%	97,30%	100%	95,00%	80,95%	82,35%	≥80%	93,82%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	71,25%	68,24%	45,81%	74,78%	70,14%	79,70%	64,29%	77,96%	61,67%	98,48%	85,19%	98,12%	≥80%	75,75%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	0%	3,43%	1,08%	4,52%	1,37%	3,84%	3,68%	3,98%	2,36%	4,05%	3,17%	2,83%	≤5%	2,86%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,77%	72,57%	76,56%	71,19%	74,97%	77,96%	80,09%	77,28%	76,10%	71,64%	73,62%	67,75%	≥80%	74,29%	PDSA
8	Waktu Laporan Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Formularium Nasional															
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,70%	96,98%	98,70%	98,44%	98,84%	98,75%	99,19%	98,99%	100%	99,02%	100%	100%	≥80%	99,05%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	95,95%	96,65%	96,25%	97,44%	97,99%	98,75%	98,63%	97,68%	98,55%	98,35%	97,84%	97,84%	100%	97,66%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	95,00%	88,10%	93,10%	87,50%	96,23%	90,74%	≥76.61%	93,52%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Tahun 2025 yakni mencapai 80,89% masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu > 85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Bulan Desember Tahun 2025

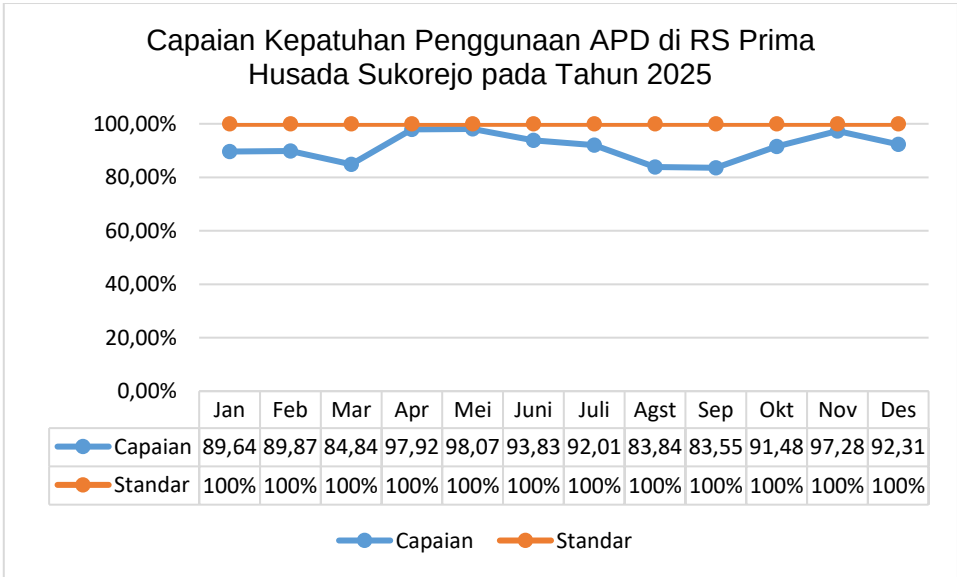
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2025 yakni 80,89% belum mencapai target 85%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Kepatuhan kebersihan tangan pada tahun 2025 yakni 80,09% belum mencapai target 85% b. Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. c. Pengawasan langsung tidak bisa maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga 2. Tujuan: a. Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan 85% b. Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan 3. Rencana Aksi: a. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Menambah dan memastikan ketersediaan handrub di seluruh titik pelayanan pasien
Do	1. Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dengan pembinaan langsung kepada petugas yang tidak patuh, disertai pencatatan tindak lanjut di buku unit

	pemantauan 2. Melibatkan PIC promkes/IPCLN dalam memberikan edukasi singkat tentang “5 Momen & 6 Langkah Kebersihan Tangan” saat briefing mingguan
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2025 yaitu 80,89% 2. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO
Action	1. Kepala unit wajib melakukan kebersihan tangan sesuai 5 momen di depan staf sebagai teladan. 2. Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dengan pembinaan langsung kepada petugas yang tidak patuh, disertai pencatatan tindak lanjut di buku unit pemantauan 3. Mengintegrasikan hasil audit dan pembinaan ke dalam rapat mutasi bulanan sebagai bagian dari evaluasi program PPI.

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Kepala unit wajib melakukan kebersihan tangan sesuai 5 <i>momen</i> di depan staf sebagai teladan.	Menumbuhkan budaya teladan dan kepemimpinan dalam penerapan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di unit kerja.	<i>Pendekatan role model</i> : kepala unit memperagakan langsung pemenuhan kebersihan tangan di setiap shift	Kepala Unit, Seluruh Staf Unit	Setiap awal shift
2	Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dan melakukan pelatihan langsung kepada petugas yang tidak patuh, serta mencatat tindak lanjut di buku unit pemantauan.	Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan melalui pelatihan langsung dan pemantauan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh terhadap kebersihan tangan.	<i>Pendekatan coaching on the spot</i> berdasarkan hasil audit harian untuk koreksi perilaku secara real time.	Kepala Unit, IPCN/IPCLN	Harian
3	Mengintegrasikan hasil audit dan pembinaan ke dalam rapat mutasi bulanan sebagai bagian dari evaluasi program PPI.	Menjamin keinginan monitoring dan evaluasi pemenuhan kebersihan tangan.	Manajemen RS, Komite PPI, Kepala Unit.	Integrasi hasil audit dan pelatihan dalam agenda rapat mutual sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.	Komite PPI, Manajemen Mutu, Kepala Unit	Bulan

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:
Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Tahun 2025 yakni mencapai 91,22% dan belum mencapai standar 100%.

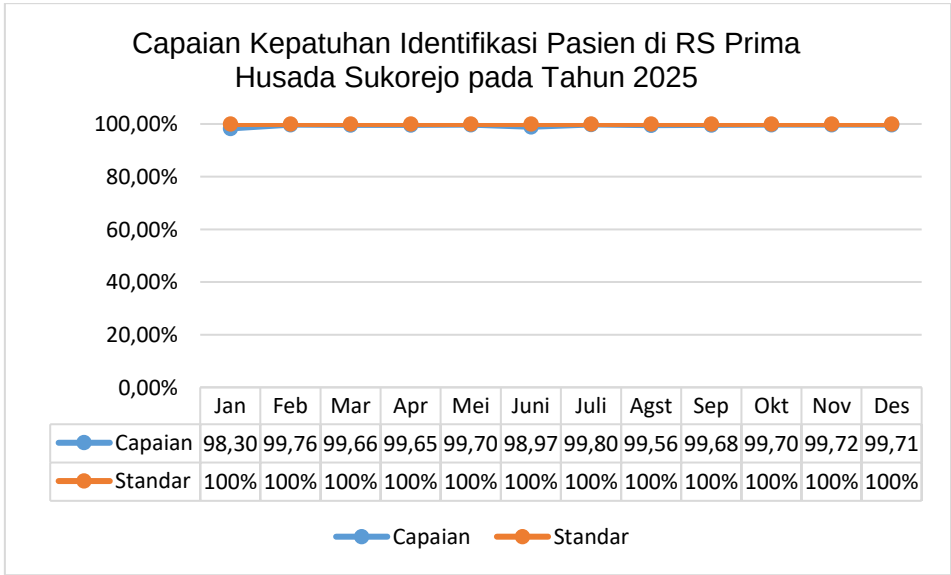
Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 91,22%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 91,22%. b. Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. 2. Tujuan: a. Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. 3. Rencana Aksi: a. Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD hingga ≥95% dalam 1–2 bulan berikutnya b. Fokus pada unit dan pergeseran dengan kepatuhan <90%.
Do	1. Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur. 2. Pelaporan hasil audit secara rutin di grup PPI untuk transparansi dan pembelajaran antarunit.
Study	1. Capaian pada tahun 2025 yakni 91,22% 2. Pelaporan di grup PPI meningkatkan kesadaran, namun belum sepenuhnya konsisten untuk semua unit.
Action	1. Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan 2. Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. 3. Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. 4. Menyertakan pencapaian APD dalam rapat umum bulanan sebagai indikator evaluasi kinerja unit.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	• Observasi langsung • Pembinaan di tempat (real-time coaching) • Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	1 Bulan
2	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	• SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja • Poster visual dipasang di area kerja • Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	1 Bulan
3	Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk mengoordinasikan dan melaporkan ketidaksesuaian harian	Pengawasan berkelanjutan dan penegakan disiplin penggunaan APD	Kepala ruangan (Karu)	• Pemantauan harian • Pencatatan ketidaksesuaian • Pelaporan ke kepala unit atau grup PPI.	Kepala Ruang, IPCN, IPCLN	Harian
4	Menyertakan pencapaian APD dalam rapat umum bulanan sebagai indikator evaluasi kinerja unit	Terwujudnya APD sebagai indikator saling menguntungkan dan keselamatan pasien, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan	Manajemen RS, Komite PPI, Kepala Unit, seluruh staf	• Presentasi pencapaian bulanan dan analisis tren kepatuhan, diikuti rekomendasi perbaikan.	Kepala Ruang	1 Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 mencapai 99,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2025

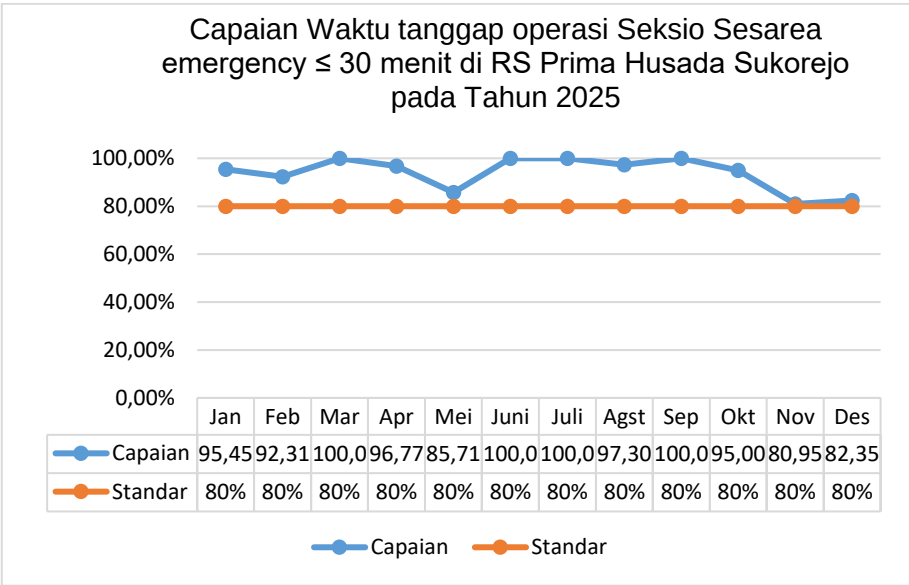
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,52%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, dan Maternitas. Akar Masalah yang teridentifikasi: 1. Beberapa tindakan pasien tidak melakukan pengecekan gelang identitas (TL / Tidak Cek Gelang) 2. Meskipun rata-rata terpenuhinya keseluruhan 99,72%, ada unit tertentu (misal Maternitas, IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A) yang masih muncul kasus ketidakpatuhan. 3. Risiko kesalahan identitas pasien tetap ada meskipun jumlah kasus kecil. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : 1. Menjaga kepatuhan $\geq 99\%$ di semua unit. 2. Fokus perbaikan pada kasus TL atau tidak cek gelang.
Do	1. Pengumpulan data yang menyertakan pasien dari SIMRS dan manual audit. 2. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A dan Maternitas. 2. Indikator menunjukkan tren stabil dan sangat baik, namun ada peluang perbaikan kecil pada prosedur pengecekan gelang.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan Desember tahun 2025 mencapai 99,52%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Menetapkan <i>bedside coaching</i> bagi petugas di unit dengan kasus TL atau tidak cek gelang. 2. Memberikan apresiasi kepada unit/staf yang 100% patuh. 3. Supervisi langsung harian

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menetapkan <i>Bedside Coaching</i> bagi petugas di unit dengan kasus TL atau tidak cek gelang	Meningkatkan kompetensi dan kepatuhan petugas secara langsung di area kerja.	Petugas di unit dengan insiden ketidakpatuhan (kasus TL / tidak cek gelang).	Pelatihan personal (satu-satu) dan praktik langsung di samping pasien untuk koreksi teknik yang tepat.	Kepala Unit & Tim Mutu	Satu bulan.
2	Memberikan apresiasi kepada unit/staf	Mendorong dan mempertahankan budaya kepatuhan serta	Unit dan staf yang mencapai tingkat	Pengakuan publik (misalnya,	Staf SDM.	Triwulanan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	yang 100% patuh	memberikan motivasi positif.	kepatuhan 100% terhadap Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) tertentu.	<i>Reward of the Month)</i>		
3	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

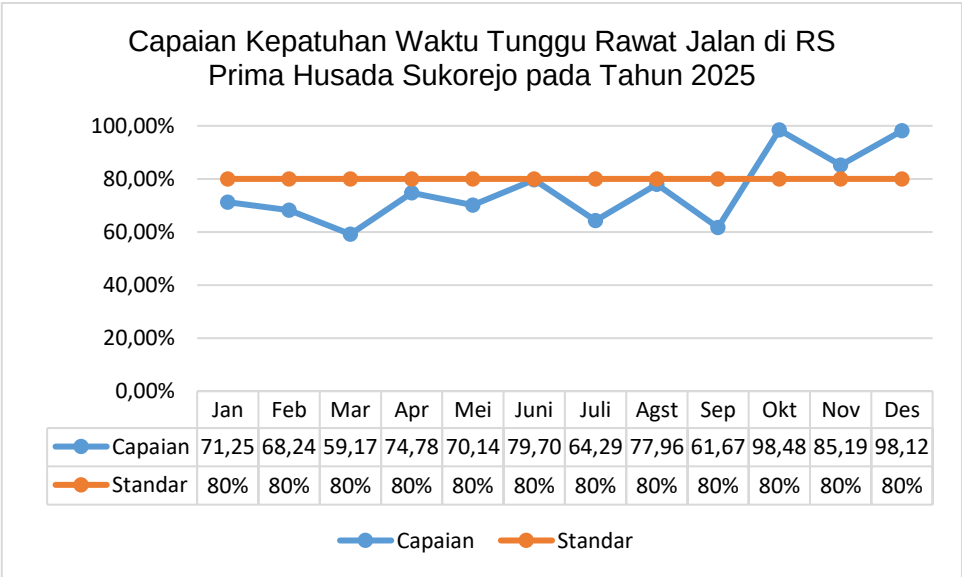


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 93,82%. Dari pasien yang diobservasi, pasien telah mendapatkan pelayanan tanggap SC Emergency lebih dari 60 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



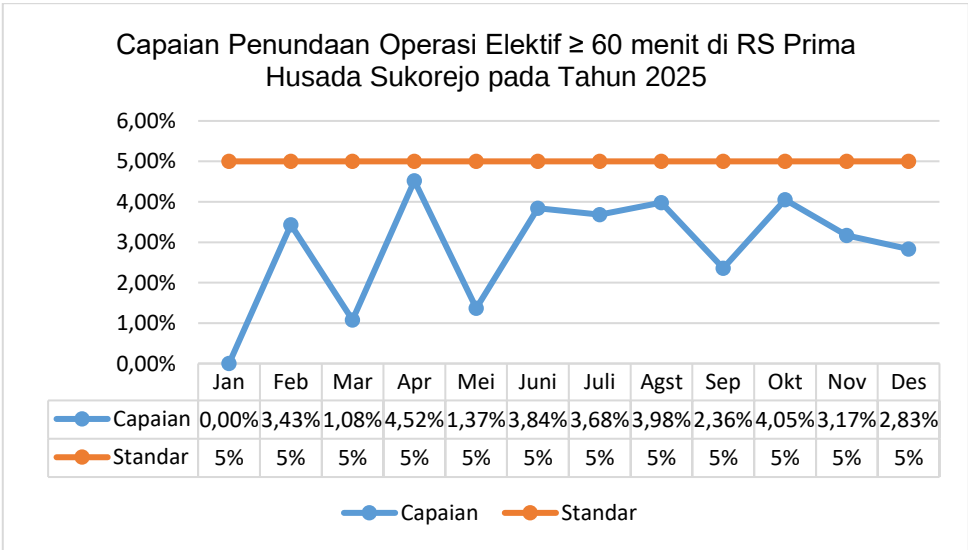
Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 mencapai 75,75% dan belum mencapai standar 80%. Tetapi pada Bulan Oktober sampai Desember 2025 telah melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan, yaitu $\geq 80\%$. Data ini diambil dalam fitur Antrian *Online* dari Mobile JKN.

Capaian selama Bulan Oktober sampai Desember Tahun 2025 mengartikan rumah sakit memanfaatkan fitur Antrian *Online* dari Mobile JKN secara maksimal, sehingga pasien datang sudah terdaftar dan siap dilayani (mengurangi *waiting time* di loket). Dan juga data yang diambil langsung dari *database* BPJS lebih akurat, mengurangi waktu yang terbuang untuk koreksi data administrasi.

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

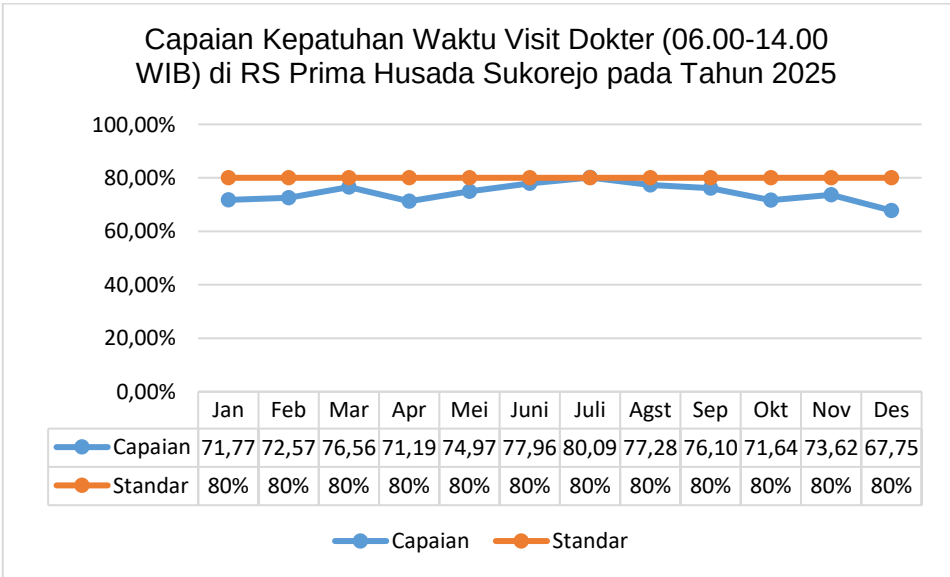


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada tahun 2025 yakni 2,86%. Capaian ini sudah mencapai standar $< 5\%$.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 74,29% belum memenuhi standar minimal $\geq 80\%$. Capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu, sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Tahun 2025

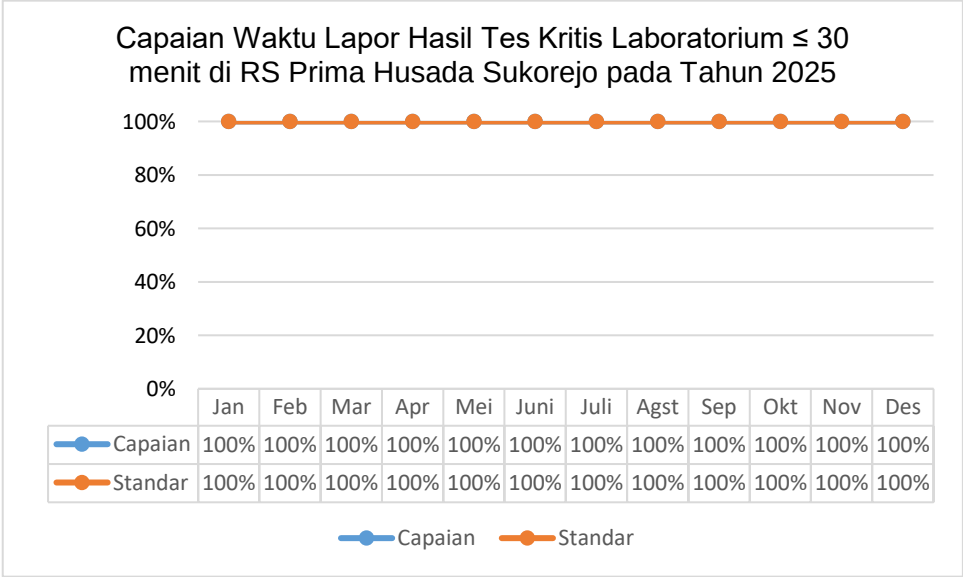
Problem	Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 74,29% belum mencapai standar 80%
Step	Analisa kepatuhan waktu visite dilakukan setiap bulan melalui monitoring dan rekap data visite dokter dari unit rawat inap, dengan membandingkan waktu kunjungan aktual terhadap waktu yang ditentukan
Plan	Identifikasi Masalah : - Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. Tidak sesuai dengan ketentuan waktu kunjungan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan (<14.00). - Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah dokter home base, serta adanya jadwal praktik lintas rumah sakit yang menyebabkan dokter tidak selalu dapat melakukan kunjungan pada jam kerja RS. - Selain itu, masih terdapat dokter spesialis yang belum melaksanakan kunjungan secara tepat waktu dan teratur, sesuai standar pelayanan medik dan kebijakan rumah sakit. Tujuan : - Meningkatkan Capaian <i>Visit</i> Dokter 06.00-14.00 WIB dengan target 80%
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? - Pendelegasian ICU: Meminta DPJP yang sibuk untuk mengonsultasikan/menitipkan instruksi pasien ICU kepada Dokter Jaga secara terstruktur sebelum pukul 14.00 WIB. <i>Tele-Consult</i>: Mendorong penggunaan komunikasi jarak jauh (telepon/aplikasi terintegrasi) untuk <i>visit</i> awal (sebelum dokter tiba) jika memungkinkan
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Tahun 2025 yakni 74,29% belum mencapai standar. Namun, sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Ketidaktepatan waktu ini berisiko menyebabkan keterlambatan dalam: - Pengambilan keputusan medis - Pelaksanaan terapi - Perencanaan pemulangan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut dan pengawasan rutin untuk meningkatkan mutu pelayanan medik
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Tahun 2025 yakni 74,29%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan - Buat Formulir <i>Handover</i>/Pendelegasian Terstruktur untuk instruksi pasien yang dititipkan ke Dokter Jaga, lengkap dengan tanda tangan DPJP dan Dokter Jaga sebagai bukti tanggung jawab bersama. - Khusus untuk pasien ICU yang membutuhkan <i>visit</i> harian, Manajemen (Komite Medis) perlu bernegosiasi dengan DPJP untuk menetapkan waktu <i>on-call standby</i> minimal pada jam tertentu (12.00-14.00) untuk kasus ICU.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penyusunan dan Implementasi Formulir <i>Handover</i> /Pendel	Menjamin keselamatan pasien dan akuntabilitas instruksi	Menghilang kan risiko kesalahan komunikasi (missed	1. Tim Mutu/Komite Medis merancang formulir yang	Komite Medis, Komite Keperawatan , Manajer	1-2 Minggu (Peny usuna

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	egasian Terstruktur	medis pada kasus yang dititipkan (didelegasikan) ke Dokter Jaga.	instruction s) dan memastikan <i>visit</i> 06.00-14.00 terdokumen tasi, meskipun DPJP tidak hadir secara fisik	mencakup: Identitas Pasien, Alasan Pendelegasian, Instruksi Baru, Instruksi Lama, dan Kolom Tanda Tangan DPJP dan Dokter Jaga. 2. Sosialisasi intensif kepada DPJP dan Dokter Jaga.	Pelayanan, Tim Mutu	n dan Sosial isasi).
2	Negosiasi Penetapan Waktu <i>On-Call Standby</i> Minimal DPJP ICU (Jam 12.00-14.00 WIB)	Memastikan ketersediaan DPJP minimal pada jam kritis untuk pasien ICU yang memerlukan <i>assessment</i> langsung atau keputusan cepat.	Meningkatkan kualitas <i>visit</i> harian ICU dan mengurangi risiko keterlambatan penanganan kasus kritis yang tidak bisa didelegasikan.	Ketua Komite Medis/Direktur Pelayanan bernegosiasi langsung dengan DPJP ICU untuk alokasi waktu <i>standby</i> harian pada jam 12.00-14.00 WIB (minimal <i>standby</i> untuk dihubungi/datang jika mendesak).	Komite Medis, Kepala Unit ICU.	1 bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

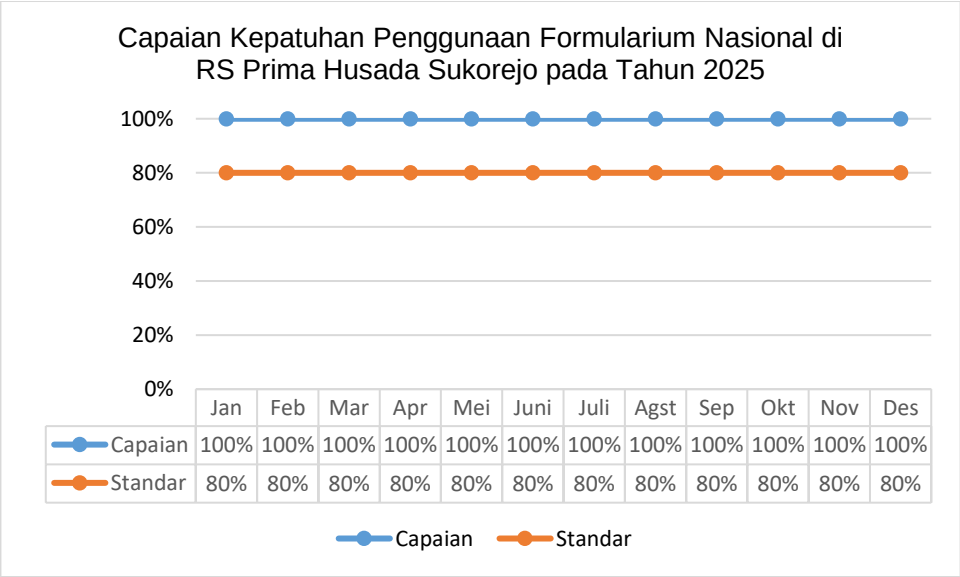


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

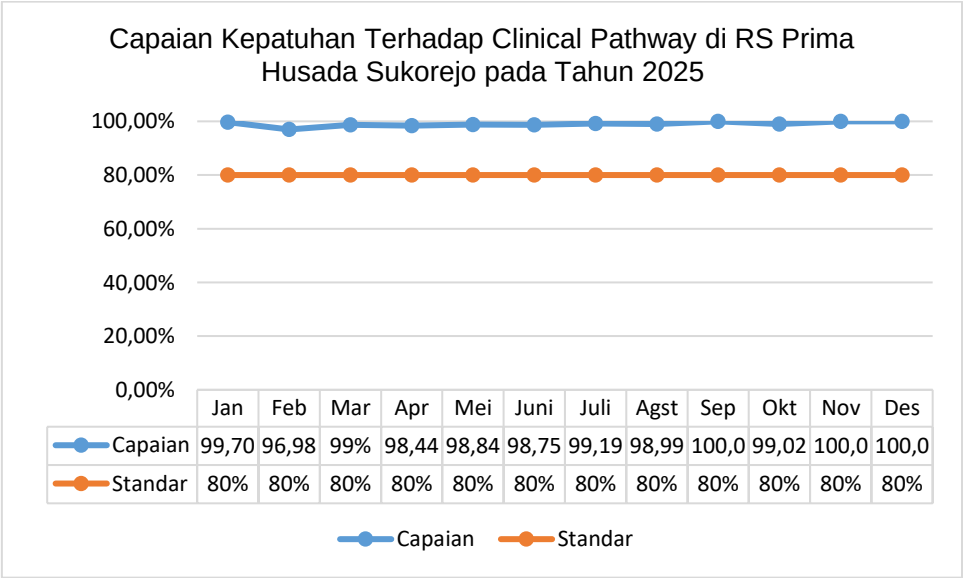


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan peresepan obat hanya dari Formularium Nasional.

10.Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

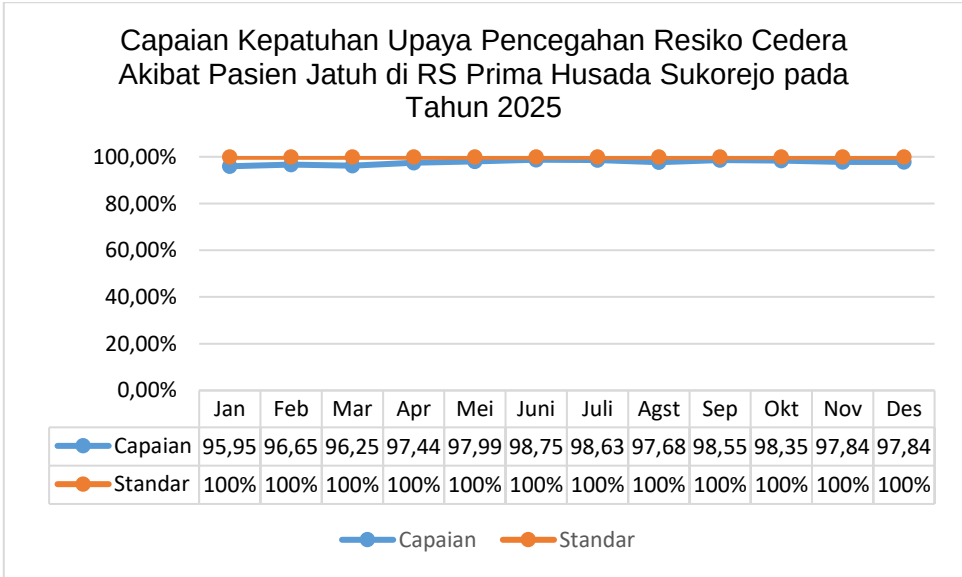


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,05%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Desember didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2025 adalah 97,66%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

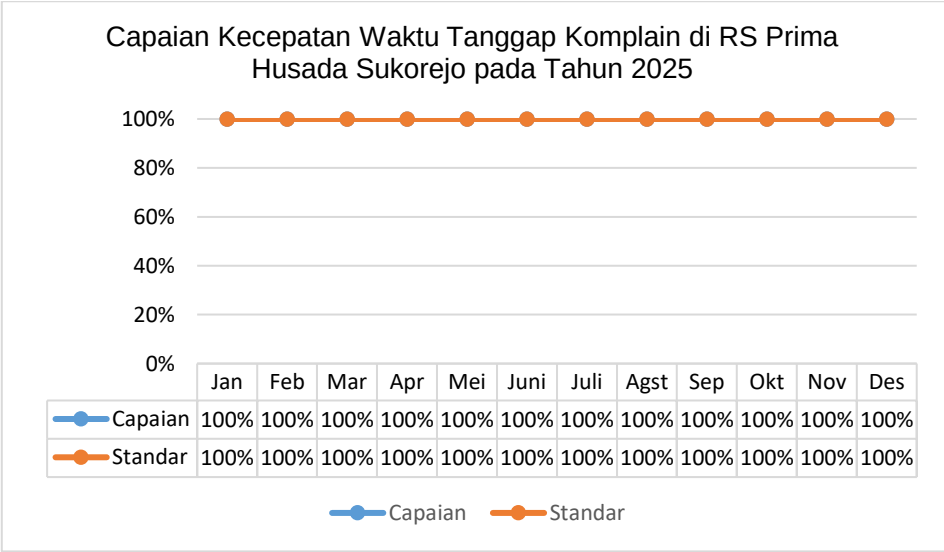
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025 adalah 97,66%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan risiko jatuh
Plan	Masalah : - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 97,66% - Ini dikarenakan handrail tidak terpasang atau terkunci dengan baik dan tidak terpasang stiker risiko jatuh Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : - Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing - Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh - Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten - Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar - Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal risiko jatuh pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi risiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 97,66% - Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur.

	3. kasus Stiker Tidak Terpasang terjadi pada pasien baru yang <i>assessment</i> -nya selesai di luar jam sibuk dan penundaan pemasangan stiker.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 97,66% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	• Ceklist ketersediaan hand rail per shift • Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	• Standarisasi label risiko jatuh • Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	• Laporan hasil audit dibagikan tiap unit • Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

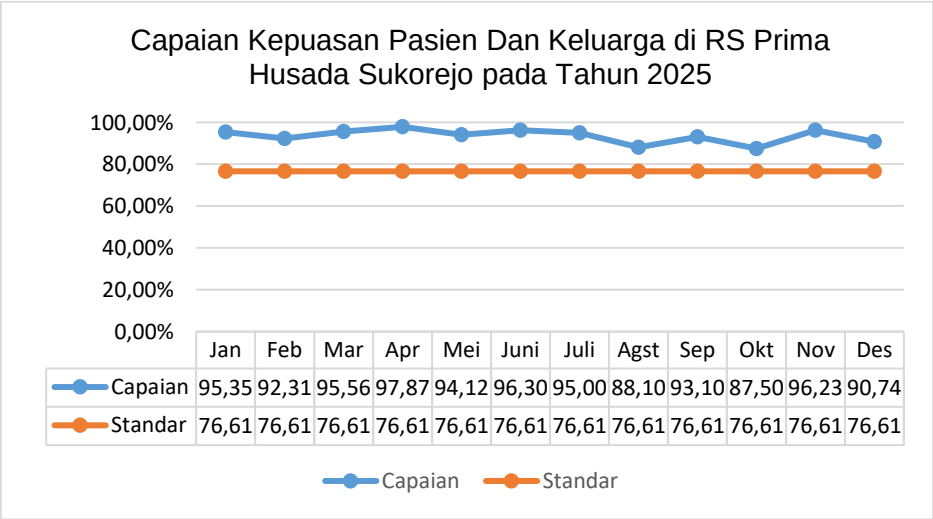


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 93,52%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.13 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Tahun 2025

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	98,30%	99,76%	99,66%	99,65%	99,70%	98,97%	99,80%	99,56%	99,68%	99,70%	99,72%	99,71%	100%	99,52%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	93,10%	96,31%	96,35%	97,40%	97,67%	97,56%	97,05%	97,82%	98,35%	98,93%	99,24%	96,33%	100%	97,18 %	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Obat Sisa Anestesi
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist															
		b. Kejadian tidak dilakukannya penandaan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%	76,39%	75,98%	74,81%	79,38%	89,47%	89,62%	85%	80,09%	PDSA
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,95%	96,65%	96,28%	97,92%	97,99%	98,75%	98,63%	97,68%	98,55%	98,35%	97,84%	97,84%	100%	97,66%	PDSA

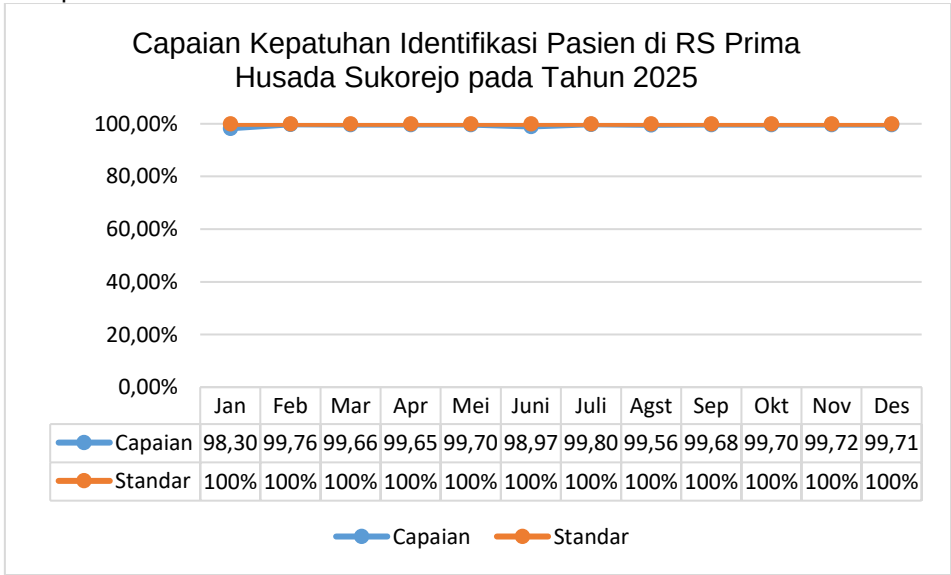
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Ketepatan pemberian MgSO ₄ Pada Pasien PEB	100%	85,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.81%	PDSA
		2. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	98,82%	100%	88,71%	97,96%	95%	97,22%	100%	100%	98,78%	100%	95,12%	-	100%	97.42%	PDSA
		3. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 90%	100.00%	Dipertahankan
		4. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 95%	100.00%	Dipertahankan

N o	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata- rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		atau konfirmasi laboratorium															
		5. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	2,63%	0%	0%	4,00%	2,94%	≤5%	1.46%	Dipertahankan
		6. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 95%	100.00%	Dipertahankan
		7. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	33,33%	33,33%	23,08%	28,57%	18,18%	40,00%	18,18%	28,57%	33,33%	27,27%	0%	25%	≥ 70%	25.74%	PDSA
		8. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)	25,00%	100%	100%	100%	33,33%	75,00%	75,00%	100%	100%	91,67%	100%	66,67%	≥ 95%	80.56%	PDSA
		9. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 90 %	100.00%	Dipertahankan
		10. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis	30,36%	31,58%	52,00%	38,33%	33,96%	32,79%	30,77%	49,15%	36,11%	36,36%	38,46%	39,39%	≥ 75 %	37.44%	PDSA

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3	Renstra RS	1. Kepuasan pasien	95,35%	92,31%	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	95,00%	88,10%	93,10%	87,50%	96,23%	90,74%	≥ 76,61%	93,77%	Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 kejadian	PDSA
		2. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	99,79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	1. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	17 Kejadian	7 kejadian	4 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- 1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 mencapai 99,52%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

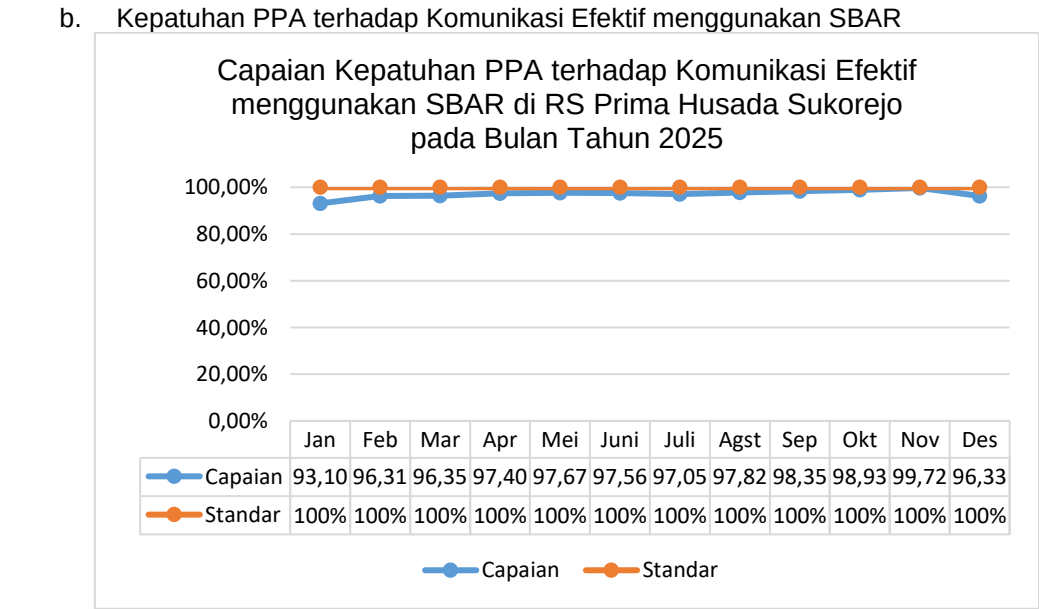
Tabel 3.14 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,52%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, dan Maternitas. Akar Masalah yang teridentifikasi: - Beberapa tindakan pasien tidak melakukan pengecekan gelang identitas (TL / Tidak Cek Gelang) - Meskipun rata-rata terpenuhinya keseluruhan 99,72%, ada unit tertentu (misal Maternitas, IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A) yang masih muncul kasus ketidakpatuhan. - Risiko kesalahan identitas pasien tetap ada meskipun jumlah kasus kecil. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : - Menjaga kepatuhan ≥99% di semua unit. - Fokus perbaikan pada kasus TL atau tidak cek gelang.
Do	- Pengumpulan data yang menyertakan pasien dari SIMRS dan manual audit. - Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	- Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A dan Maternitas. - Semua ketidakpatuhan bersifat sporadis, sebagian besar terkait tindakan TTV dan injeksi di unit tertentu. - Indikator menunjukkan tren stabil dan sangat baik, namun ada peluang perbaikan kecil pada prosedur pengecekan gelang.

Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan Desember tahun 2025 mencapai 99,52%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Menetapkan <i>bedside coaching</i> bagi petugas di unit dengan kasus TL atau tidak cek gelang. 2. Memberikan apresiasi kepada unit/staf yang 100% patuh. 3. Supervisi langsung harian

Tabel 3.15 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menetapkan <i>Bedside Coaching</i> bagi petugas di unit dengan kasus TL atau tidak cek gelang	Meningkatkan kompetensi dan kepatuhan petugas secara langsung di area kerja.	Petugas di unit dengan insiden ketidakpatuhan (kasus TL / tidak cek gelang).	Pelatihan personal (satu-satu) dan praktik langsung di samping pasien untuk koreksi teknik yang tepat.	Kepala Unit & Tim Mutu	Satu bulan.
2	Memberikan apresiasi kepada unit/staf yang 100% patuh	Mendorong dan mempertahankan budaya kepatuhan serta memberikan motivasi positif.	Unit dan staf yang mencapai tingkat kepatuhan 100% terhadap Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) tertentu.	Pengakuan publik (misalnya, <i>Reward of the Month</i>)	Staf SDM.	Triwulanan
3	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Tahun 2025 yakni 97,22%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Tahun 2025

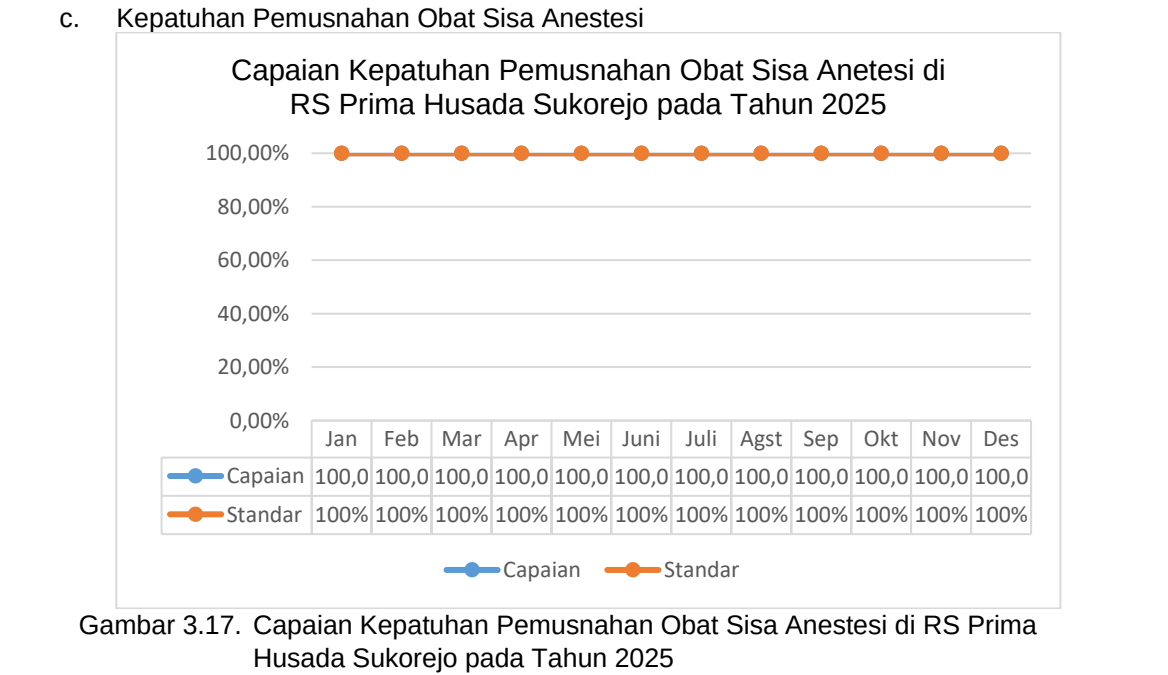
Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,22%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Identifikasi Masalah: Tingkat kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) terhadap penggunaan komunikasi efektif dengan format SBAR belum mencapai standar 100%. Hasil monitoring menunjukkan adanya variasi dalam penerapan, terutama pada bagian TTD Penerima pesan pada SBAR, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap penggunaan komunikasi SBAR hingga mencapai 100% pada seluruh unit pelayanan, khususnya pada proses serah terima pasien dan komunikasi antar-profesi 3. Rencana Aksi: a. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. c. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. d. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

	2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. 3. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. 4. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap
--	---

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Supervisi Pelaksanaan Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya.	Supervisi, pemberian umpan balik langsung dan edukasi singkat kepada petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	PKRS, Tim SKP, dan Tim Mutu	1 minggu
2	Monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya	Monitoring dan evaluasi petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	Kepala Ruangan	1 bulan
3	Penyediaan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi SBAR melalui akses mudah terhadap	Seluruh PPA (perawat, bidan, tenaga medis) di seluruh unit pelayanan, khususnya yang melakukan serah terima pasien, komunikasi antar shift, dan	Menyusun beberapa contoh SBAR yang baik dan lengkap yakni dalam bentuk dokumentasi tertulis	Tim SKP, PKRS	1 bulan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
		contoh-contoh praktik baik (best practice) yang tersedia secara digital.	komunikasi antar profesi.			
4	Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap	Memberikan pembinaan dan perbaikan langsung kepada tenaga kesehatan yang tidak mengisi form SBAR secara lengkap	Seluruh tenaga kesehatan (perawat, bidan, atau tenaga lainnya) yang form SBAR tidak lengkap dan pengisian SBAR tetapi tidak terdokumentasi dengan benar	4. Menunjukkan bagian yang tidak terisi dan jelaskan dampaknya terhadap keselamatan pasien. 5. Berikan contoh pengisian yang benar dan arahkan untuk perbaikan ke depan	Tim SKP, PKRS	1 bulan

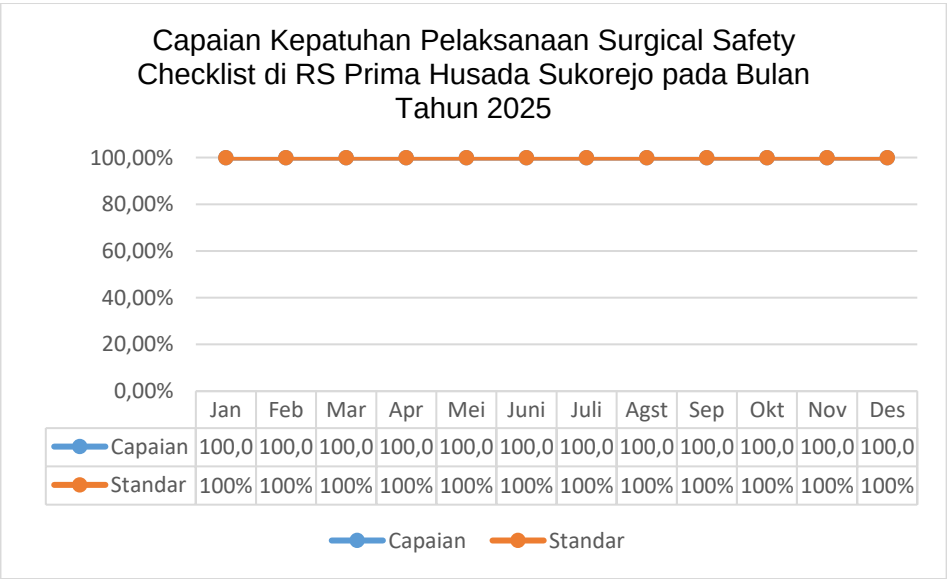


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemusnahan obat sisa anestesi di rumah sakit sudah berjalan sesuai prosedur, dan kontrol terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan anestesi sudah diterapkan secara maksimal.

d. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist

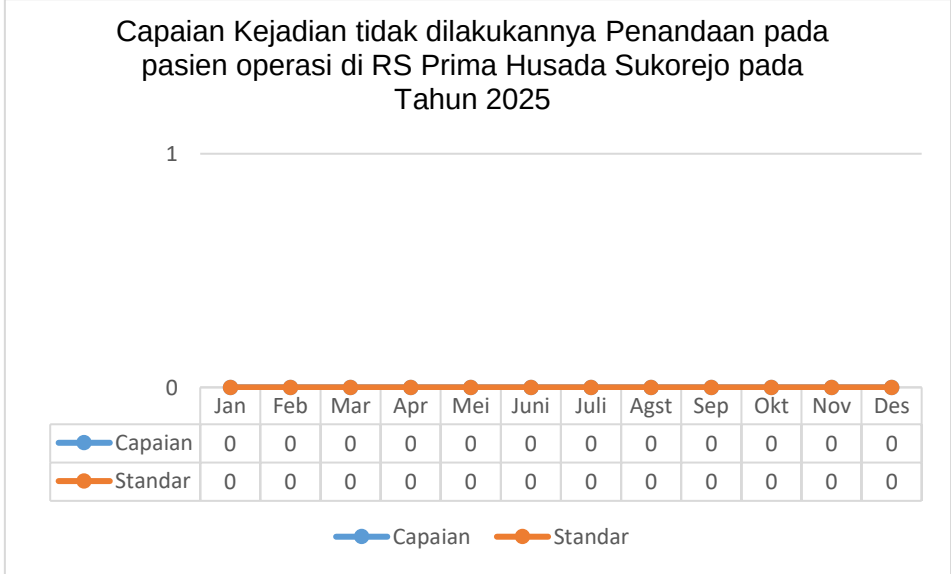


Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Sfety Checklist di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Kepatuhan pelaksanaan Surgical Safety Checklist (SSC) mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keselamatan pasien pra, saat, dan pasca operasi telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai standar WHO.

e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi

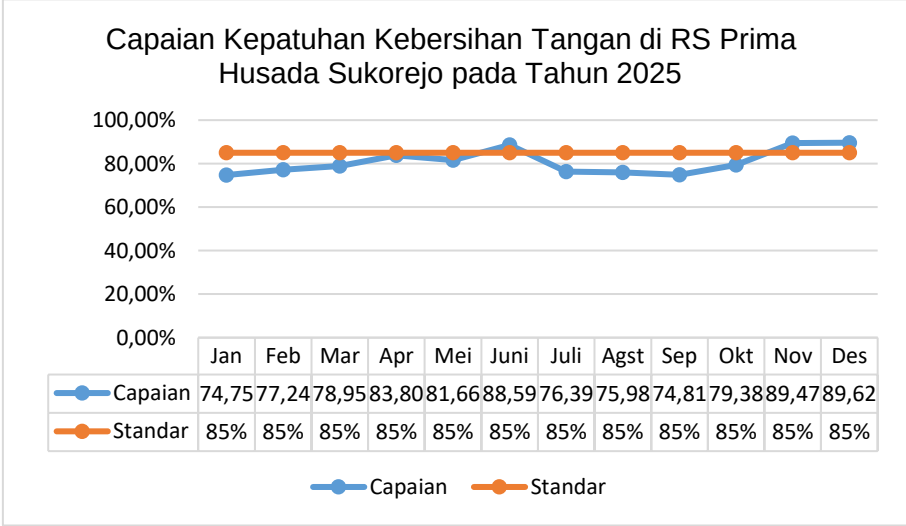


Gambar 3.19. Capaian Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Desember Tahun 2025 mencapai target 0 kejadian. Angka kejadian tercatat nol (0) dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada tahun 2025 yakni mencapai 80,89% dan sudah mencapai target. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 80,89%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Tahun 2025

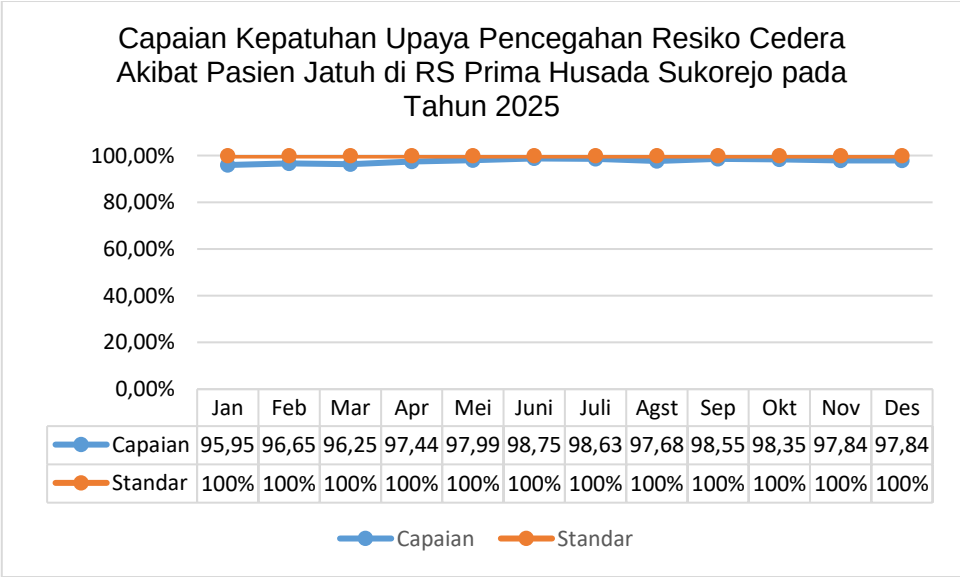
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Tahun 2025 hanya mencapai 80,89% belum mencapai target 85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Kepatuhan kebersihan tangan pada tahun 2025 yakni 80,89% belum mencapai target 85% b. Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. c. Pengawasan langsung tidak bisa maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga 2. Tujuan: a. Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan 85% b. Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan 3. Rencana Aksi: a. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Menambah dan memastikan ketersediaan handrub di seluruh titik pelayanan pasien
Do	1. Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dengan pembinaan langsung kepada petugas yang tidak patuh, disertai pencatatan tindak lanjut di buku unit pemantauan 2. Melibatkan PIC promkes/IPCLN dalam memberikan edukasi singkat tentang “5

	<i>Momen & 6 Langkah Kebersihan Tangan”</i> saat briefing mingguan
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Tahun 2025 yaitu 80,89%
Action	1. Kepala unit wajib melakukan kebersihan tangan sesuai 5 momen di depan staf sebagai teladan. 2. Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dengan pembinaan langsung kepada petugas yang tidak patuh, disertai pencatatan tindak lanjut di buku unit pemantauan 3. Mengintegrasikan hasil audit dan pembinaan ke dalam rapat mutasi bulanan sebagai bagian dari evaluasi program PPI.

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Kepala unit wajib melakukan kebersihan tangan sesuai 5 momen di depan staf sebagai teladan.	Menumbuhka n budaya teladan dan kepemimpina n dalam penerapan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di unit kerja.	<i>Pendekatan role model</i> : kepala unit memperaga kan langsung pemenuhan kebersihan tangan di setiap shift	Kepala Unit, Seluruh Staf Unit	Setia p awal shift
2	Kepala unit memverifikasi hasil observasi harian dan melakukan pelatihan langsung kepada petugas yang tidak patuh, serta mencatat tindak lanjut di buku unit pemantauan.	Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan melalui pelatihan langsung dan pemantauan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh terhadap kebersihan tangan.	<i>Pendekatan coaching on the spot</i> berdasarkan hasil audit harian untuk koreksi perilaku secara real time.	Kepala Unit, IPCN/IPCLN	Haria n
3	Mengintegrasikan hasil audit dan pembinaan ke dalam rapat mutasi bulanan sebagai bagian dari evaluasi program PPI.	Menjamin keinginan monitoring dan evaluasi pemenuhan kebersihan tangan.	Manajemen RS, Komite PPI, Kepala Unit.	Integrasi hasil audit dan pelatihan dalam agenda rapat mutual sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.	Komite PPI, Manajemen Mutu, Kepala Unit	Bulan an

g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.21. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :
Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada tahun 2025 adalah 97,66%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

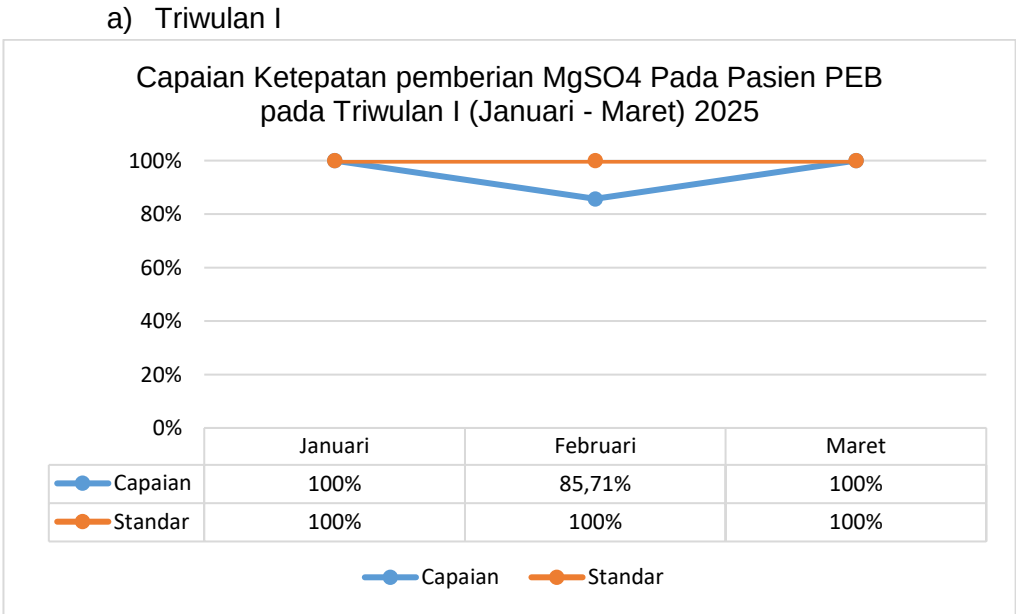
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Desember Tahun 2025 adalah 97,66%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 97,66% - Ini dikarenakan handrail tidak terpasang atau terkunci dengan baik dan tidak terpasang stiker resiko jatuh Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : - Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing - Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh - Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten - Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar - Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 97,66% - Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur.

	3. kasus Stiker Tidak Terpasang terjadi pada pasien baru yang <i>assessment</i> -nya selesai di luar jam sibuk dan penundaan pemasangan stiker.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 97,66% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	• Ceklist ketersediaan hand rail per shift • Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	• Standarisasi label risiko jatuh • Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	• Laporan hasil audit dibagikan tiap unit • Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
- a. Klinis
- 1) Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB



Gambar 3.21. Capaian Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

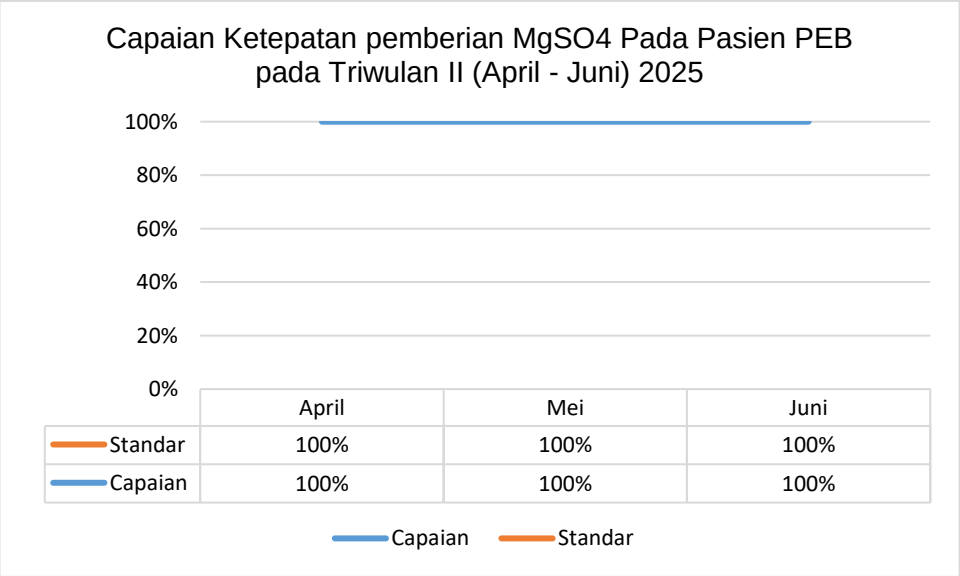
Berdasarkan capaian ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB pada Triwulan I (Januari - Maret) 2025. Pada Bulan Januari 2025, kepatuhan mencapai 100%, yang menunjukkan efektivitas tindak lanjut dari audit kasus bulan November 2024 masih terjaga. Namun, pada Februari 2025, terjadi penurunan menjadi 85,71%. Penurunan ini disebabkan oleh 1 kasus pasien PEB yang tidak mendapatkan MgSO4. Setelah dilakukan intervensi segera, capaian kembali pulih ke 100% pada bulan Maret 2025.

Tabel 3.1 PDSA Capaian ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025

Problem	Belum tercapainya standar 100% pemberian MgSO4 pada pasien PEB secara konsisten. Terdapat penurunan capaian pada bulan Februari 2025 menjadi 85,71% karena 1 pasien tidak mendapatkan terapi sesuai standar yang ditetapkan pada audit kasus November 2024
Step	Siklus 1: Sosialisasi ulang dan penguatan kepatuhan pemberian MgSO4 sesuai hasil audit November 2024
Plan	1. Tujuan: Memastikan 100% pasien PEB mendapatkan MgSO4 tanpa kecuali, sesuai instruksi hasil audit kasus November 2024. 2. Target: Capaian kembali ke 100% pada bulan Maret 2025. 3. Rencana Tindakan: a. Melakukan <i>refreshing</i> (sosialisasi ulang) kepada staf medis dan kebidanan mengenai kebijakan "Semua pasien PEB wajib MgSO4". b. Memastikan ketersediaan stok MgSO4 di troli emergensi IGD Ponek/Kamar Bersalin.
Do	4. Melaksanakan sosialisasi hasil audit Oktober 2024 pada saat <i>operan</i> shift dan rapat rutin unit.
Study	4. Berdasarkan data capaian hasil di Bulan Januari yakni capaian 100% dan sesuai standar yang ditetapkan 5. Berdasarkan data capaian hasil di Bulan Februari yakni capaian turun ke 85,71% (Terdapat 1 gap pasien)

	6. Berdasarkan data capaian hasil di Bulan Maret capaian kembali naik menjadi 100% pada saat <i>operan</i> shift dan rapat rutin unit.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Melanjutkan prosedur pemberian MgSO4 sesuai standar yang sudah kembali mencapai 100% di bulan Maret 2025. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan audit internal berkala setiap bulan untuk mencegah penurunan motivasi atau kelalaian staf di masa mendatang.

b) Triwulan II

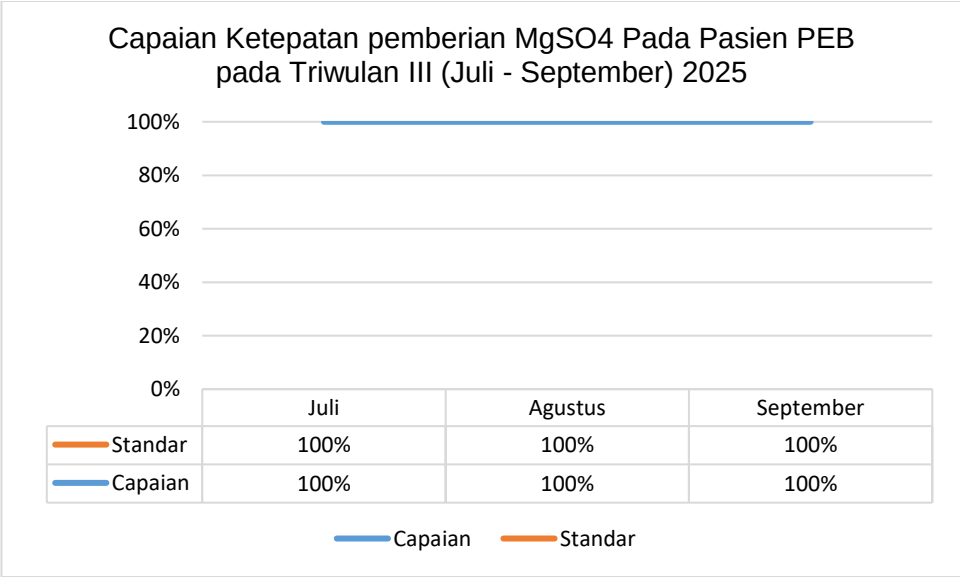


Gambar 3.22. Capaian Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB pada Triwulan II (April - Juni) 2025 telah mencapai standar 100%. Dimana semua pasien PEB sudah mendapatkan MgSO4. Faktor keberhasilan ini dikarenakan kegagalan 85,71% di bulan Februari dijadikan pembelajaran (*lesson learned*), sehingga tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama. Kepala Unit IGD dan Maternitas juga sudah berkoordinasi dengan dengan DPJP Obgyn untuk seluruh pasien PEB diberikan MgSO4 ketika pertama masuk di RS.

c) Triwulan III

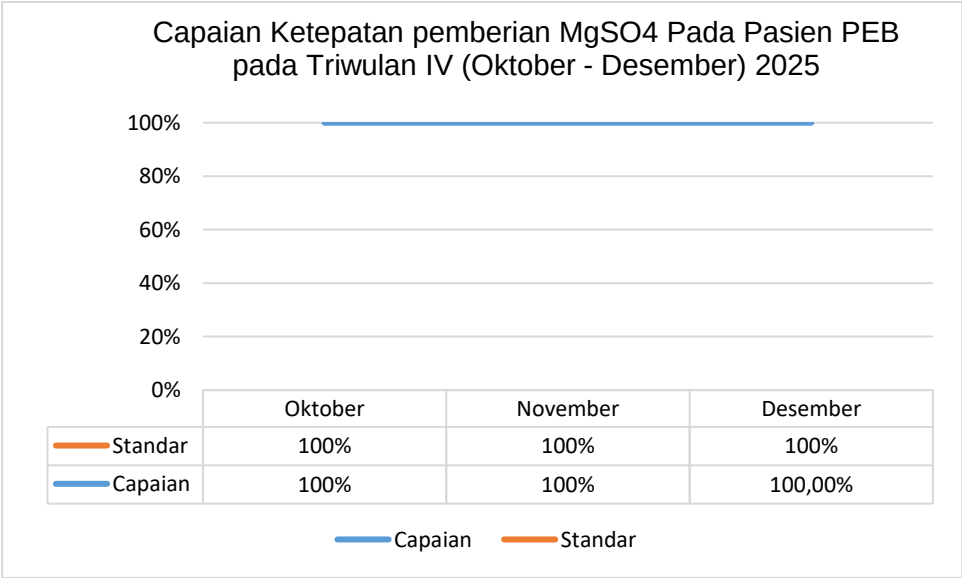


Gambar 3.23. Capaian Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB pada Triwulan III (Juli - September) tahun 2025, capaian ketepatan pemberian MgSO4 pada pasien PEB secara konsisten bertahan di angka 100%. Seluruh pasien dengan diagnosa Preeklampsia Berat yang masuk ke RS Prima Husada Sukorejo telah mendapatkan terapi MgSO4 sesuai dengan standar klinis yang ditetapkan. Konsistensi ini membuktikan bahwa sistem perbaikan yang diinisiasi pada siklus-siklus sebelumnya telah berjalan dengan stabil.

d) Triwulan IV



Gambar 3.24. Capaian Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan IV Tahun 2025

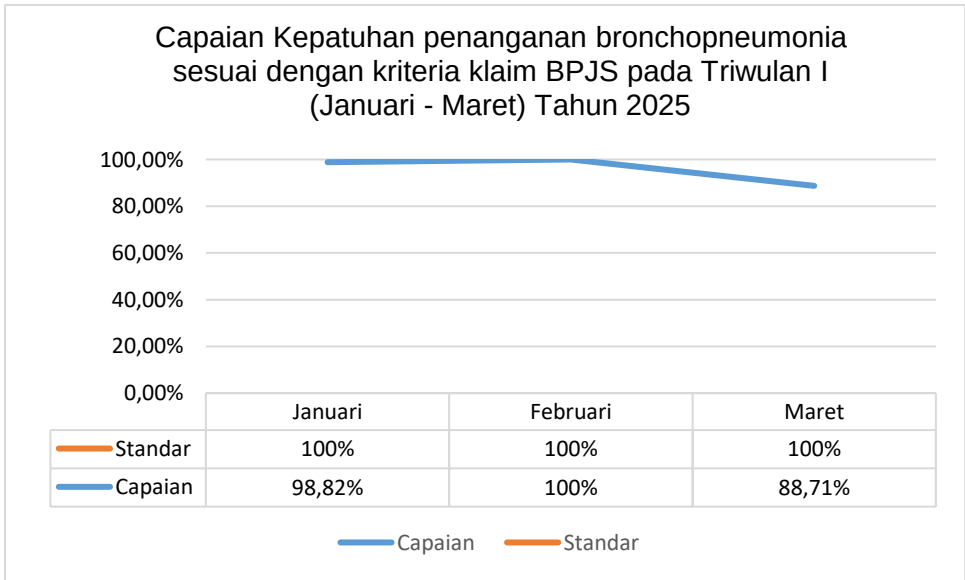
Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2025, capaian ketepatan pemberian MgSO4 pada pasien PEB secara konsisten bertahan di angka 100%. Seluruh pasien dengan diagnosa Preeklampsia Berat yang masuk ke RS Prima Husada Sukorejo telah mendapatkan terapi MgSO4 sesuai dengan standar klinis yang

ditetapkan. Konsistensi ini membuktikan bahwa sistem perbaikan yang diinisiasi pada siklus-siklus sebelumnya telah berjalan dengan stabil.

2) **Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS**

a) Triwulan I



Gambar 3.25. Capaian Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025

Hasil Capaian:

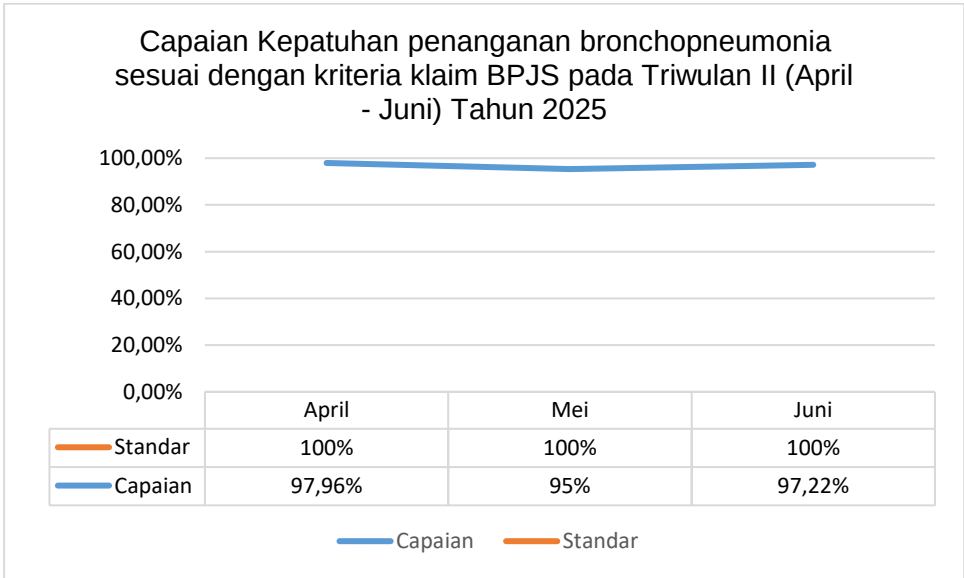
Berdasarkan capaian kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025 terdapat dinamika kepatuhan dimana pada bulan pada bulan Januari adalah 98,82%, meningkat menjadi 100% di bulan Februari, namun turun drastis menjadi 88,71% pada bulan Maret.

Tabel 3. PDSA Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025

Problem	Capaian kepatuhan tidak stabil dan gagal mencapai standar 100% pada bulan Januari (98,82%) serta Maret (88,71%).
Step	Siklus 1: Perbaikan sistem pendokumentasian Asesmen IGD dan standardisasi durasi perawatan (<i>Length of Stay</i>).
Plan	1. Tujuan: Memastikan seluruh klaim Bronchopneumonia layak bayar dengan kepatuhan standar 100%. 2. Akar Masalah Januari: Ditemukan berkas "Tidak Layak" karena tidak sesuai standar pelayanan dan tidak adanya lembar asesmen IGD. 3. Akar Masalah Maret: Ditemukan ketidaksesuaian kriteria klaim akibat masa rawat (<i>Length of Stay</i>) yang hanya 3 hari. 4. Rencana Tindakan: Sosialisasi ulang pengisian berkas rekam medis lengkap di IGD.
Do	1. Melakukan supervisi harian di IGD untuk memastikan lembar asesmen terisi sebelum pasien dipindahkan ke ruang rawat inap. 2. Mewajibkan konfirmasi kepada DPJP jika pasien direncanakan pulang dalam waktu 3 hari untuk memastikan kriteria medis telah terpenuhi secara dokumentasi. 3. Mengaktifkan peran verifikator internal untuk menyisir berkas tidak lengkap sebelum dikirim ke bagian klaim.

Study	1. Januari: Capaian 98,82% menunjukkan adanya <i>human error</i> dalam kelengkapan administrasi (Asesmen IGD). 2. Februari: Capaian berhasil mencapai 100%, membuktikan sistem sempat berjalan dengan baik. 3. Maret: Capaian turun drastis ke 88,71% karena kendala durasi rawat (LOS) yang dianggap terlalu singkat bagi kriteria klaim BPJS tertentu. 4. Masalah administrasi (Januari) dan masalah klinis/durasi rawat (Maret) memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari Kepala Unit dan Komite Medis.
Action	1. Pengajuan pengaktifan komite medis terkait audit medis dengan mengajukan ke Manajemen

b) Triwulan II



Gambar 3.26. Capaian Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II (April - Juni) Tahun 2025

Hasil Capaian:

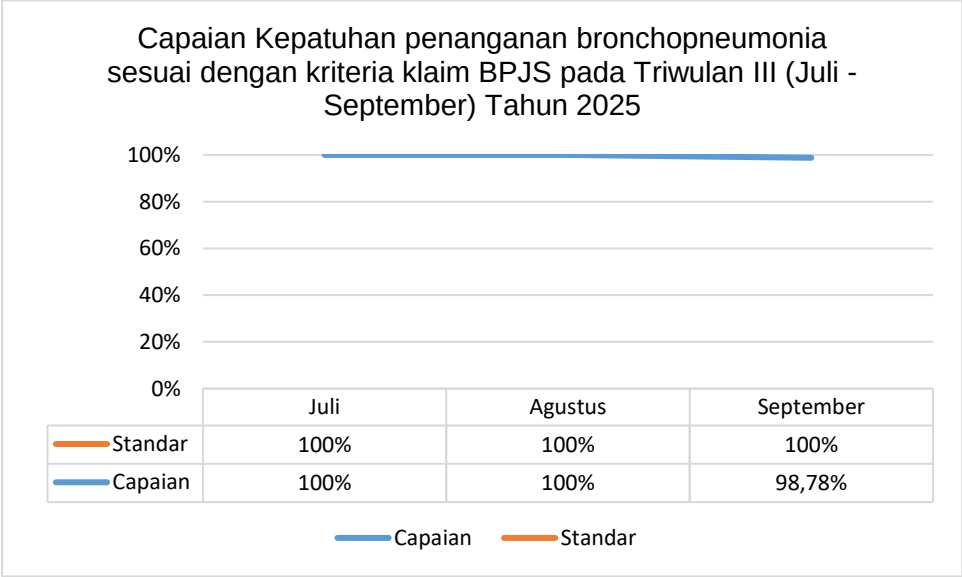
Berdasarkan capaian kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS pada Triwulan II (April - Juni) Tahun 2025 menunjukkan fluktuasi namun tetap berada di atas 95%, meskipun belum berhasil mencapai target standar 100% secara konsisten dimana pada bulan april 2025 capaian mencapai 97,96% (48 dari 49 pasien sesuai kriteria). Pada Bulan Mei 2025 Terjadi penurunan capaian menjadi 95,35% atau dibulatkan menjadi 95% (41 dari 43 pasien sesuai kriteria). Dan di Bulan Juni 2025 Mengalami kenaikan kembali menjadi 97,22% (36 dari 35 pasien sesuai kriteria).

Tabel 3. PDSA Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS pada Triwulan II (April - Juni) Tahun 2025

Problem	Belum tercapainya target 100% secara konsisten pada Triwulan II: April (97,96%), Mei (95%), dan Juni (97,22%). Masalah utama yang berulang adalah klaim dianggap tidak layak karena durasi perawatan (LOS) hanya 3 hari.
Step	Siklus 2: Implementasi sistem "Real-time Correction" (Perbaikan Langsung oleh Unit Terkait).

Plan	1. Tujuan: Memastikan <i>Zero Pending</i> klaim dengan cara memperbaiki kesalahan dokumentasi segera setelah ditemukan oleh verifikator internal. 2. Rencana Tindakan: a. Verifikator internal langsung mengembalikan berkas ke DPJP jika kurangnya justifikasi LOS 3 hari.
Do	1. Setiap hari, tim Casemix menyisir berkas pasien pulang. Jika ada pasien pulang hari ke-3 tanpa catatan klinis yang kuat, berkas langsung dibawa kembali ke ruangan/poliklinik
Study	1. Capaian pada Triwulan II menunjukkan angka yang fluktuatif dan belum mencapai target 100%: April (97,96%), Mei (95%), dan Juni (97,22%). 2. Meskipun sudah dilakukan upaya perbaikan, penurunan terdalam terjadi pada bulan Mei (95%), yang mengindikasikan bahwa masalah belum tertangani secara sistemik
Action	1. Rapat koordinasi rutin bulanan yang dihadiri oleh Manajemen (Manajer Medis/Kepala Bidang Yanmed) dan Verifikator Internal (Casemix) terkait klaim BPJS

c) Triwulan III



Gambar 3.27. Capaian Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III (Juli - September) Tahun 2025

Hasil Capaian:

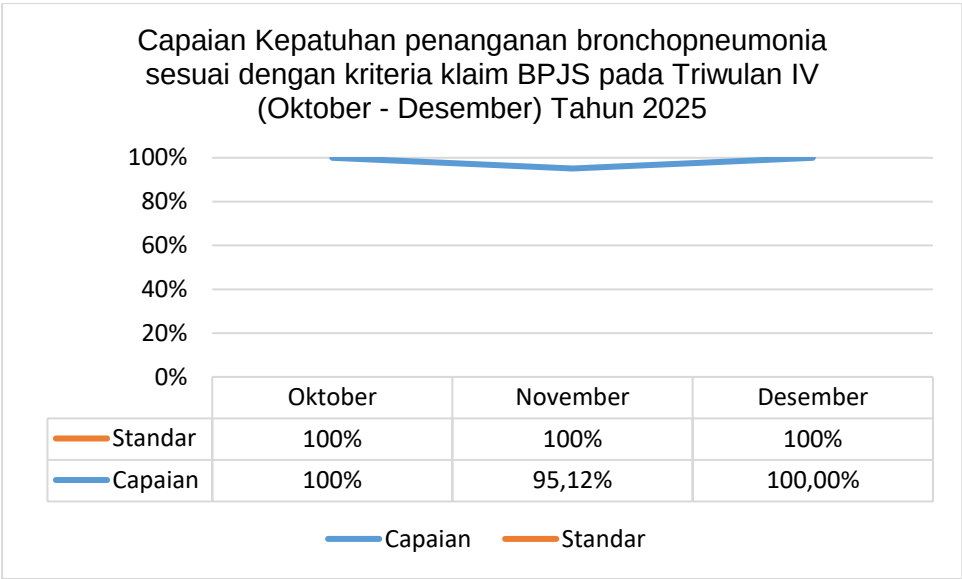
Capaian kepatuhan penanganan bronchopneumonia pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan stabilitas yang sangat baik dan berhasil mempertahankan tren positif dari triwulan sebelumnya. Target standar 100% hampir tercapai sepenuhnya secara konsisten yakni pada bulan juli dan agustus mencapai standar 100%. Tetapi Pada Bulan September mencapai 98,78% dari 82 pasien yang memenuhi kriteria klaim yakni 81 pasien.

Tabel 3. PDSA Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS pada Triwulan III (Juli - September) Tahun 2025

Problem	Capaian pada bulan September 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,78%. Masalah yang ditemukan kembali berulang, yaitu adanya pasien dengan durasi perawatan (Length of Stay/LOS) hanya 3 hari yang berisiko pada kelayakan klaim.
Step	Siklus 3: Penguatan monitoring kepulangan pasien dan konsistensi pendokumentasian justifikasi medis untuk masa rawat pendek.

Plan	1. Tujuan: Mempertahankan kestabilan capaian di angka 100% dan memastikan seluruh berkas pasien dengan masa rawat pendek memiliki dasar medis yang kuat agar layak klaim. 2. Akar Masalah: Meskipun pada bulan Juli dan Agustus tercapai 100%, pada bulan September masih ditemukan 1 kasus pasien pulang dengan LOS 3 hari tanpa dokumentasi pendukung yang mencukupi untuk kriteria BPJS. 3. Rencana Tindakan: a. Melanjutkan rapat koordinasi rutin bulanan antara tim verifikator dan manajemen untuk mengevaluasi setiap temuan <i>pending</i>. b. Meningkatkan peran MPP (<i>Case Manager</i>) untuk memvalidasi kriteria kepulangan pasien pneumonia secara harian.
Do	1. Setiap hari, tim Casemix menyisir berkas pasien pulang. Jika ada pasien pulang hari ke-3 tanpa catatan klinis yang kuat, berkas langsung dibawa kembali ke ruangan/poliklinik
Study	1. Hasil Capaian pada Triwulan III menunjukkan: a. Pada Bulan Juli Tahun 2025 mencapai 100% (32 pasien sesuai dengan kriteria) b. Pada Bulan Agustus Tahun 2025 mencapai 100% (50 pasien sesuai dengan kriteria) c. Pada Bulan September Tahun 2025 mencapai 98,78% (82 pasien yang sesuai kriteria yakni 81 pasien) 2. Sistem pengawasan sudah berjalan sangat baik pada dua bulan pertama Triwulan III. Namun, temuan di bulan September menunjukkan bahwa terdapat pasien Bronchopneumonia dengan LOS 3 hari
Action	1. Rapat koordinasi rutin bulanan yang dihadiri oleh Manajemen (Manajer Medis/Kepala Bidang Yanmed) dan Verifikator Internal (Casemix) terkait klaim BPJS

d) Triwulan IV



Gambar 3.28. Capaian Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2025

Hasil Capaian:

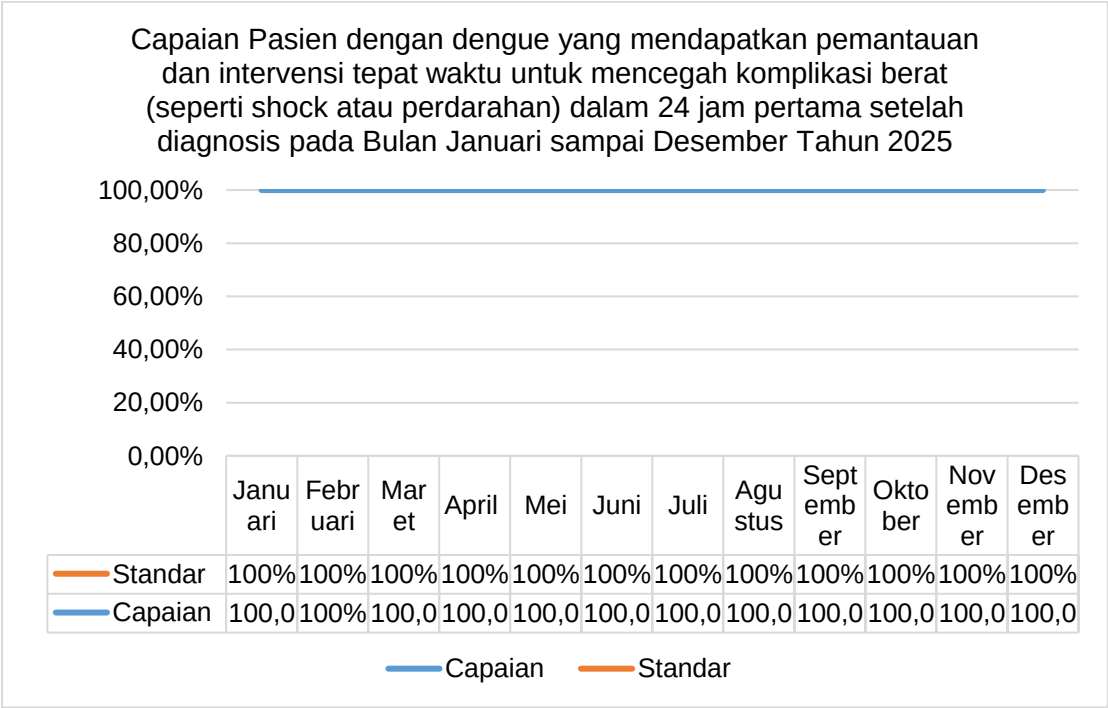
Capaian kepatuhan penanganan bronchopneumonia pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan stabilitas yang sangat baik dan berhasil mempertahankan tren positif dari triwulan sebelumnya. Target standar 100% hampir tercapai sepenuhnya secara konsisten yakni pada bulan Oktober Tahun 2025 yakni mencapai 100%, di mana seluruh pasien yang ditangani telah memenuhi kriteria klaim BPJS dan standar pelayanan medis. Tetapi pada Bulan November mengalami penurunan signifikan menjadi 95,12% (dari 82 pasien yang masuk kriteria yakni 78 pasien) dan Bulan Desember kembali pulih mencapai target 100%.

Tabel 3. PDSA Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS pada Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2025

Problem	Capaian pada bulan November Tahun 2025 yakni 95,12%. %. Masalah yang ditemukan kembali berulang, yaitu adanya pasien dengan durasi perawatan (Length of Stay/LOS) hanya 3 hari yang berisiko pada kelayakan klaim.
Step	Siklus 4: Penguatan kendali durasi perawatan (LOS) dan validasi tatalaksana klinis sesuai standar pelayanan (PNPK) untuk mempertahankan target 100%.
Plan	1. Tujuan: Mengembalikan dan mempertahankan konsistensi capaian 100% pada akhir tahun 2025. 2. Akar Masalah: Meskipun target 100% tercapai di Oktober dan Desember, pada November ditemukan kendala berupa pasien pulang dengan LOS 3 hari. 3. Rencana Tindakan: a. Melakukan sosialisasi ulang mengenai standar tatalaksana antibiotik pneumonia minimal 72 jam sesuai PNPk. b. Mewajibkan DPJP memberikan justifikasi klinis tertulis bagi pasien yang dipulangkan dengan masa rawat 3 hari.
Do	1. Mengaktifkan sistem "perbaikan langsung" di mana berkas yang terdeteksi <i>pending</i> (tidak sesuai PNPk atau LOS singkat) segera dikembalikan ke DPJP untuk dilengkapi dokumen pendukungnya. 2. Menyelenggarakan rapat bulanan bersama jajaran manajemen

Study	1. Hasil Capaian: Oktober mencapai 100%, November turun ke 95,12%, dan Desember kembali pulih ke 100%. 2. Analisis: Penurunan di bulan November menunjukkan bahwa masalah durasi rawat (LOS 3 hari) tetap menjadi risiko yang muncul kembali jika monitoring melonggar. 3. Evaluasi Tindakan: Koordinasi cepat antara tim verifikator dan manajemen terbukti mampu mengembalikan performa ke angka 100% pada bulan Desember.
Action	1. Rapat koordinasi rutin bulanan yang dihadiri oleh Manajemen (Manajer Medis/Kepala Bidang Yanmed) dan Verifikator Internal (Casemix) terkait klaim BPJS 2. Pengusulan untuk pengaktifan Komite medik dalam melakukan audit klinis rutin terhadap kasus-kasus <i>high volume</i> dan <i>high risk</i> seperti Bronchopneumonia. 3. Komite Medik menyusun jadwal audit bulanan untuk meninjau kesesuaian tatalaksana DPJP terhadap PNPK, terutama fokus pada durasi pemberian antibiotik dan dasar klinis pemulangan pasien (LOS)

3) Pasien dengan DHF yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.



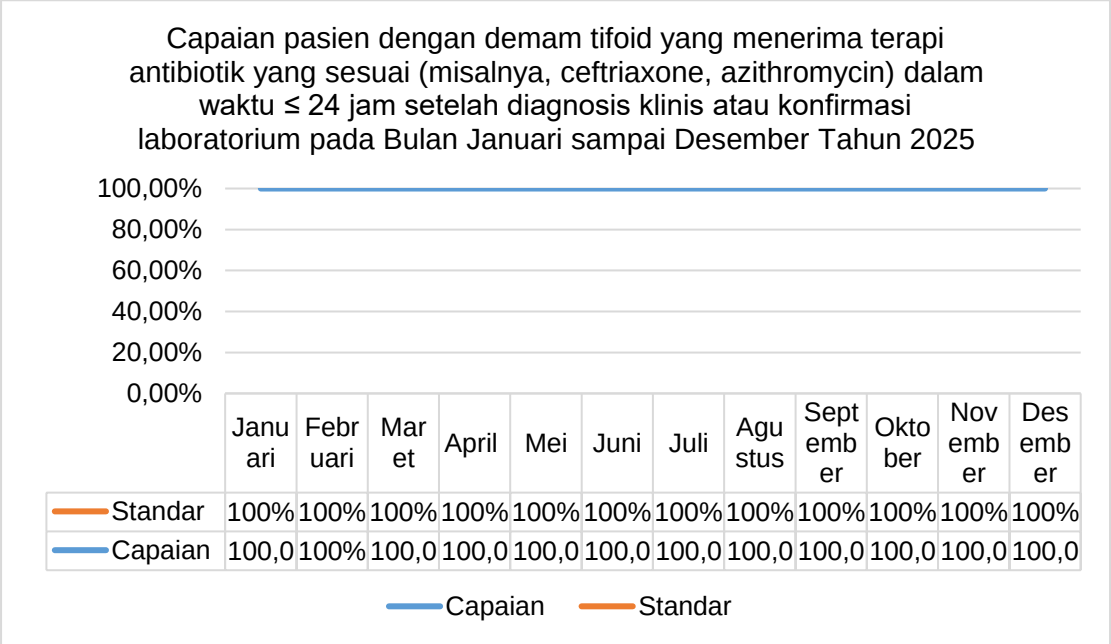
Gambar 3.29.Capaian Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis pada Bulan Januari sampai Desember Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data observasi selama periode Januari hingga Desember 2025, total pasien DBD IRNA (Instalasi Rawat Inap) yang terdata berjumlah 109 pasien. Dari total tersebut, seluruh pasien mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu dalam 24 jam pertama setelah diagnosis ditegakkan. Tingkat kepatuhan pelayanan terhadap standar pencegahan komplikasi berat (seperti *Dengue Shock Syndrome* atau perdarahan) mencapai 100% secara konsisten setiap bulan. Termasuk pada bulan September yang meskipun memiliki 0 pasien, secara sistem tetap menunjukkan kesiapan pelayanan yang optimal.

Pencapaian target 100% ini menunjukkan beberapa poin keberhasilan utama yakni tenaga medis mampu mengidentifikasi risiko komplikasi dengan cepat sejak pasien masuk. Alur kerja (SOP) penanganan DBD berjalan sangat efektif, di mana intervensi diberikan sebelum jendela kritis 24 jam terlampaui. Fasilitas pendukung dan ketersediaan cairan/obat-obatan pendukung pemantauan dalam kondisi yang selalu siap.

4) **Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium.**

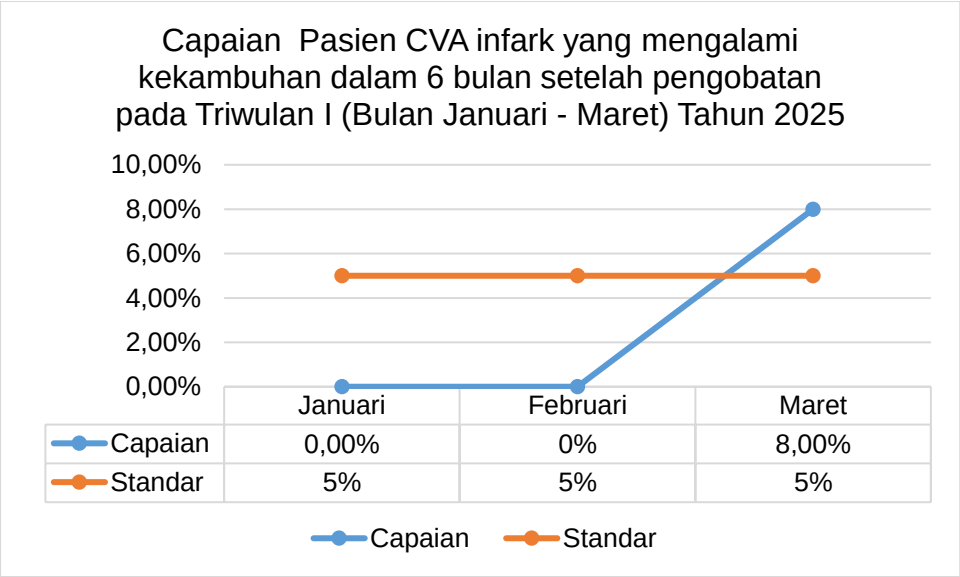


Gambar 3.30. Capaian pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium pada Bulan Januari sampai Desember Tahun 2025

Hasil Capaian:

Selama periode tahun 2025, indikator mutu pelayanan bagi pasien Demam Tifoid menunjukkan hasil yang sempurna. Sebanyak **100% pasien** yang terdiagnosa secara klinis maupun laboratorium telah menerima terapi antibiotik lini pertama yang sesuai (seperti *Ceftriaxone* atau *Azithromycin*) dalam waktu kurang dari atau sama dengan 24 jam sejak diagnosis ditegakkan. Keberhasilan mencapai angka 100% ini memiliki implikasi klinis yang sangat penting dikarenakan Pemberian antibiotik yang tepat dalam <24 jam secara signifikan mempercepat eradikasi bakteri *Salmonella typhi*, sehingga memperpendek masa demam dan lama rawat inap (*Length of Stay*).

5) **Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan**
a) Triwulan 1



Gambar 3.31. Capaian Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan pada Triwulan I (Bulan Januari - Maret) Tahun 2025

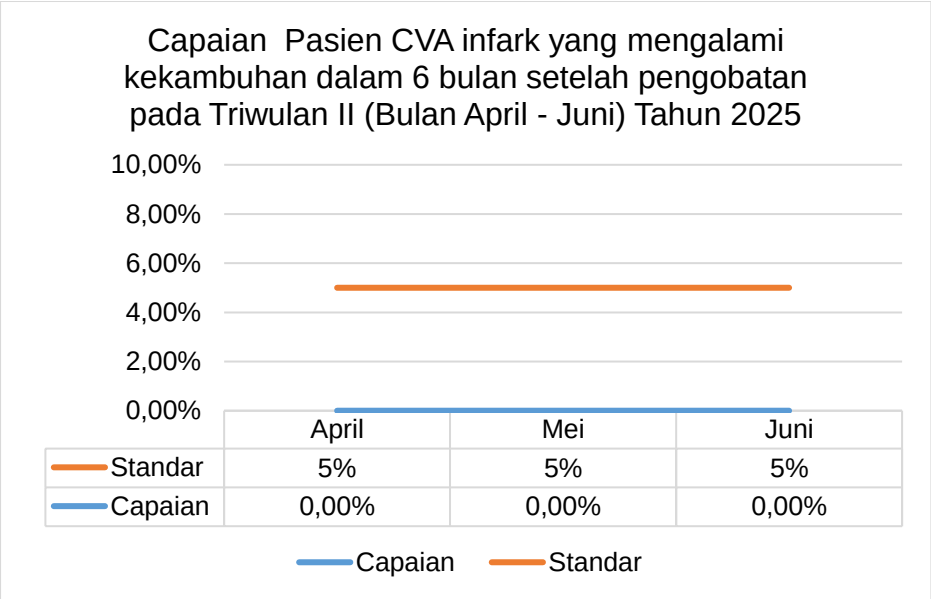
Hasil Capaian:

Berdasarkan data yang terkumpul pada Triwulan I (Januari - Maret) 2025, tercatat total pasien CVA Infark sebanyak 98 pasien. Adapun pada bulan Januari Januari dari 38 pasien tidak terdapat kekambuhan. Bulan Februari dari 35 pasien tidak mengalami kekambuhan tetapi pada bulan Maret Tahun 2025 dari 25 pasien terdapat 2 pasien yang mengalami kekambuhan.

Tabel 3. PDSA Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan pada Triwulan I (Bulan Januari - Maret) Tahun 2025

Problem	Munculnya angka kekambuhan pasien CVA Infark sebesar 8.00% (2 dari 25 pasien) pada bulan Maret 2025
Step	Menurunkan angka kekambuhan pasien CVA Infark menjadi 0%
Plan	Menjalankan prosedur pelayanan pasien CVA Infark sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada di rumah sakit.
Do	Melakukan perawatan pasien, pemberian obat, dan edukasi pemulangan standar oleh perawat ruangan
Study	Ditemukan bahwa pada bulan Januari dan Februari angka kekambuhan memang 0%, namun pada bulan Maret muncul 2 kasus kekambuhan (8%).
Action	Memastikan setiap pasien mendapatkan jadwal kontrol yang pasti, sebagai upaya mitigasi risiko kekambuhan jangka pendek

b) Triwulan 2

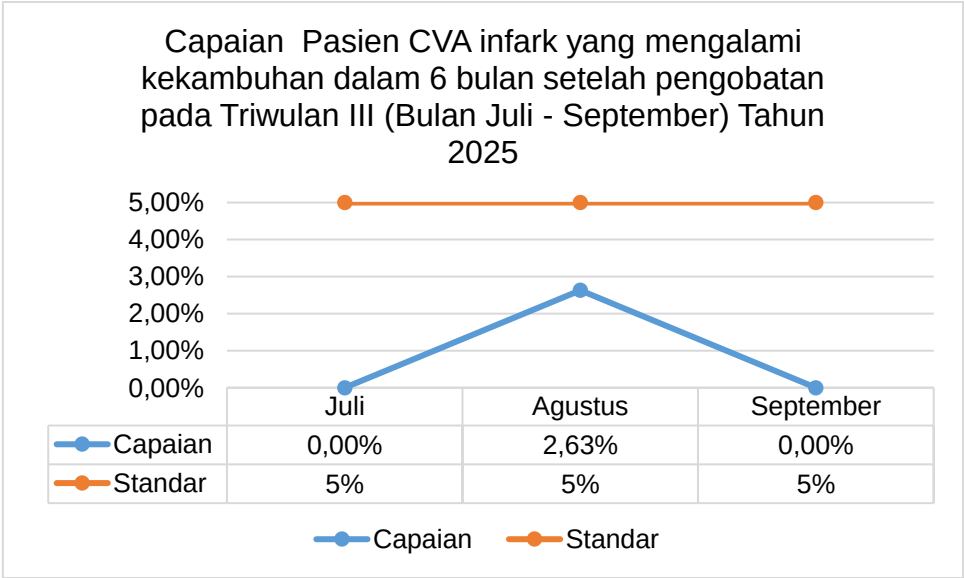


Gambar 3.32. Capaian Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan pada Triwulan II (Bulan April - Juni) Tahun 2025

Hasil Capaian:

Hasil pada Triwulan II menunjukkan performa yang sangat positif di mana tingkat kekambuhan pasien mencapai target standar 0% secara konsisten selama tiga bulan berturut-turut. Jika dibandingkan dengan Triwulan I, terdapat peningkatan mutu pelayanan yang signifikan, mengingat pada bulan Maret sebelumnya sempat terjadi lonjakan kekambuhan sebesar 8.00%. Munculnya angka 0% di bulan April, Mei, dan Juni menunjukkan bahwa tindakan memastikan jadwal kontrol sebelum pasien pulang adalah langkah yang efektif dan tepat sasaran.

c) Triwulan III



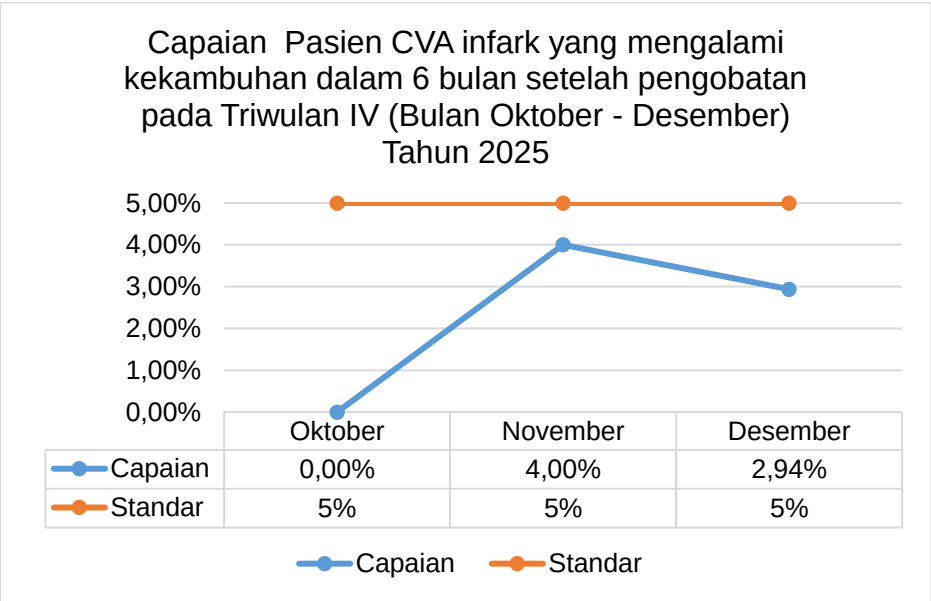
Gambar 3.33. Capaian Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan pada Triwulan III (Bulan Juli - September) Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data pemantauan pada Triwulan III, angka kekambuhan pasien CVA Infark dalam 6 bulan setelah pengobatan menunjukkan performa yang stabil dan tetap berada di bawah ambang batas standar yang ditetapkan, yaitu 5%. Pada bulan Juli, rumah sakit berhasil mencatat angka kekambuhan sebesar 0.00%. Memasuki bulan Agustus, terdapat kenaikan angka kekambuhan menjadi 2.63%, namun capaian ini masih dinyatakan memenuhi standar karena tidak melampaui batas maksimal 5%. Performa kembali membaik pada bulan September dengan capaian 0.00%.

Keberhasilan mempertahankan angka di bawah standar pada triwulan ini didorong oleh inovasi pemberian edukasi melalui media visual berupa video edukasi dari Dokter Spesialis Saraf. Penggunaan video ini membantu memperkuat retensi informasi bagi pasien dan keluarga mengenai pentingnya kepatuhan minum obat antiplatelet dan kontrol rutin, sehingga fluktuasi yang terjadi di bulan Agustus dapat segera diredam pada bulan berikutnya.

d) Triwulan IV

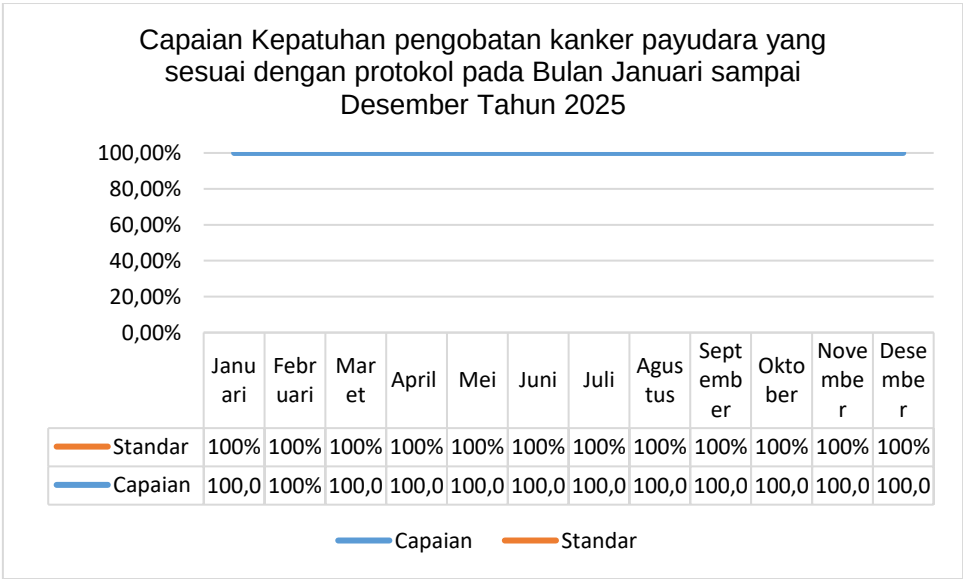


Gambar 3.34. Capaian Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan pada Triwulan IV (Bulan Oktober – Desember) Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian pada Triwulan IV, pemantauan indikator mutu menunjukkan tren peningkatan angka kekambuhan, namun secara keseluruhan masih berada dalam batas toleransi standar 5%. Meskipun terjadi kenaikan pada bulan November dan Desember, seluruh capaian tersebut masih memenuhi standar mutu karena tidak ada yang melebihi angka 5%.

6) Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol

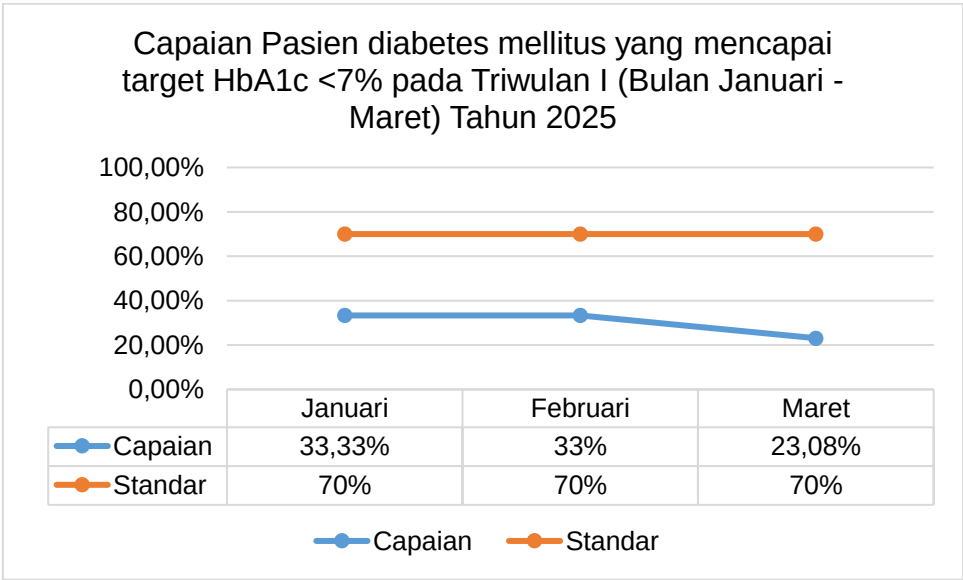


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protocol pada Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2025

Hasil Capaian:

Data pemantauan selama periode Januari hingga Desember 2025 menunjukkan bahwa kepatuhan pengobatan pasien kanker payudara sesuai protokol berhasil dipertahankan pada angka 100%. Mengingat rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis onkologi dan pelayanan kemoterapi, capaian 100% ini membuktikan bahwa prosedur rujukan pasca-diagnosa berjalan sangat efektif. Pasien dengan diagnosa *Ca Mammae* langsung difasilitasi untuk mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap segera setelah hasil pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) keluar, sehingga protokol pengobatan tetap terjaga tanpa adanya penundaan.

7) Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%
a) Triwulan I



Gambar 3.36. Capaian Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan I (Bulan Januari - Maret) Tahun 2025

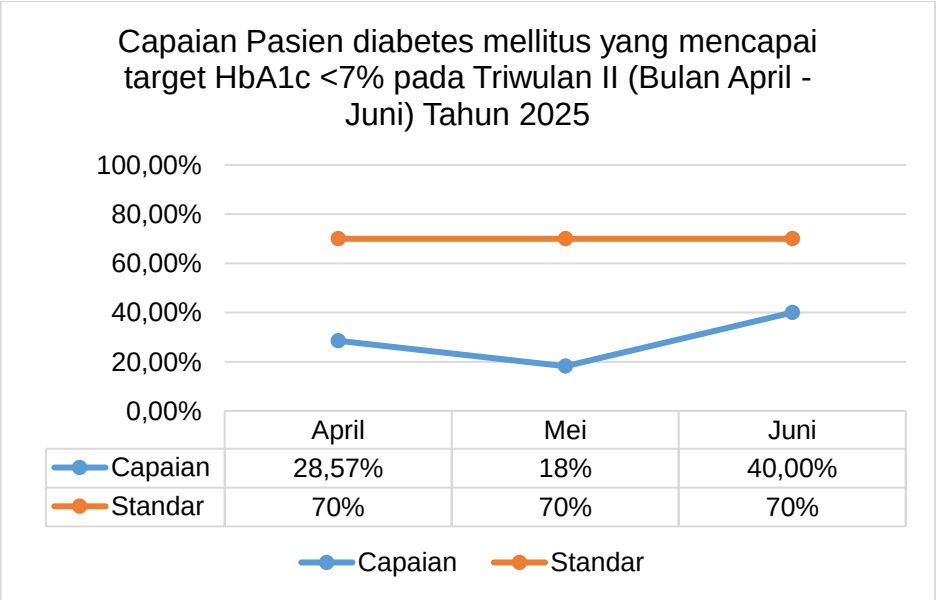
Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian pada Triwulan I yakni pada Bulan Januari sampai bulan Maret Tahun 2025, secara keseluruhan capaian pada Triwulan I menunjukkan tren yang menurun dan masih berada jauh di bawah target standar (70%). Pada Bulan Januari dan Februari stabil di angka 33,33%, terjadi penurunan signifikan pada bulan Maret menjadi 23,08%.

Tabel 3. PDSA Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan I (Bulan Januari - Maret) Tahun 2025

Problem	Capaian HbA1c < 7% rendah (23-33%) dan terdapat keterbatasan frekuensi pemeriksaan HbA1c (hanya 6 bulan sekali), sehingga sulit mendeteksi kegagalan terapi secara dini sebelum hasil lab 6 bulanan keluar.
Step	Siklus 1: Implementasi Monitoring Glukosa Darah Puasa (GDP) sebagai prediktor keberhasilan HbA1c
Plan	Masalah: Sulit memantau progres perbaikan HbA1c secara <i>real-time</i> setiap bulan karena pemeriksaan hanya bisa dilakukan 2 kali setahun per pasien Strategi untuk ini: Menggunakan GDS (Gula Darah Sewaktu) atau GDP (Gula Darah Puasa) bulanan sebagai <i>indikator antara</i> (proxy indicator) untuk memprediksi hasil HbA1c berikutnya.
Do	1. Melakukan pemantauan gula darah mandiri secara lebih ketat setiap bulan saat pasien mengambil obat prolansis. 2. Mengedukasi pasien bahwa pemeriksaan 6 bulan sekali ini sangat krusial, sehingga mereka harus benar-benar menjaga pola makan agar tidak "gagal" saat tes berikutnya.
Study	Menganalisis data grafik: Penurunan di bulan Maret (23.08%) dianalisis apakah berhubungan dengan lonjakan konsumsi makanan tertentu (misal: periode hari raya) atau karena pasien tersebut memang tidak terkontrol GDP-nya di bulan Januari-Februari.
Action	Jika dalam pantauan bulanan Gula Darah Puasa (GDP) pasien tetap tinggi (>130 mg/dL), dokter harus segera melakukan penyesuaian dosis tanpa menunggu hasil HbA1c 6 bulan mendatang keluar.

b) Triwulan II



Gambar 3.37. Capaian Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan II (Bulan April - Juni) Tahun 2025

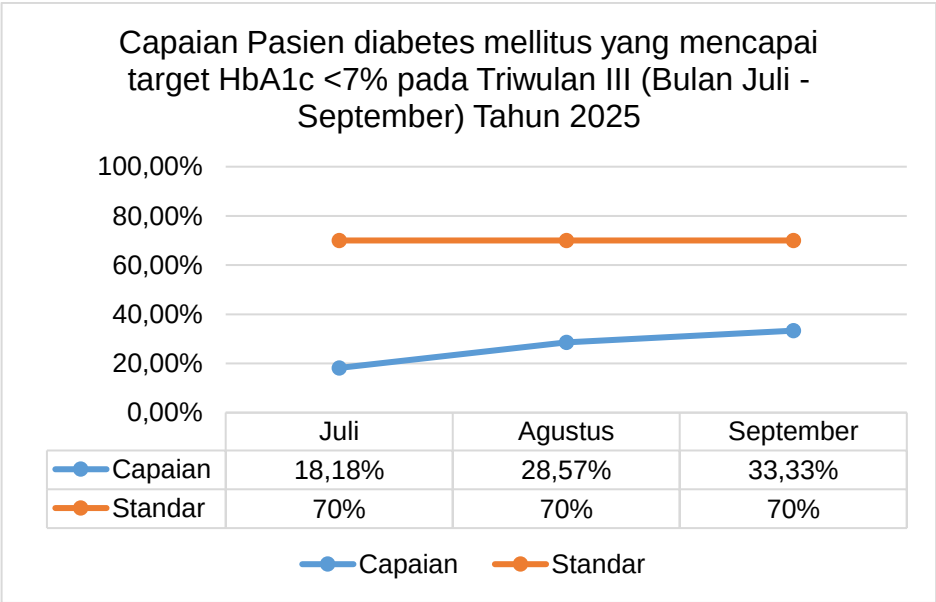
Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian pada Triwulan II yakni pada Bulan April sampai Juni Tahun 2025. Capaian pada bulan Juni melonjak signifikan hingga mencapai 40,00%. Ini merupakan angka tertinggi dibandingkan seluruh bulan di Triwulan I dan II. Meskipun ada kenaikan di Juni, seluruh capaian di Triwulan II masih berada jauh di bawah standar target 70,00%.

Tabel 3. PDSA Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan II (Bulan April - Juni) Tahun 2025

Problem	Capaian HbA1c masih fluktuatif (turun tajam di bulan Mei hingga 18,00%) dan secara keseluruhan masih jauh dari target standar 70%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pola hidup pasien di luar pantauan klinik.
Step	Siklus 2: Optimalisasi Dukungan Keluarga (<i>Family Support</i>) dan Edukasi Pola Makan Berkelanjutan.
Plan	Mengalihkan fokus dari edukasi individu ke pemberdayaan pendamping keluarga sebagai "pengawas" harian di rumah untuk mencegah lonjakan gula darah (seperti yang terjadi pada penurunan capaian di bulan Mei).
Do	Melibatkan pendamping (anak/pasangan) saat pengambilan obat untuk memastikan mereka memahami pola makan pasien di rumah.
Study	Identifikasi Keberhasilan Juni: Menilai apakah kenaikan ke 40% di bulan Juni berkorelasi dengan mulai aktifnya peran keluarga dalam mengingatkan jadwal obat dan diet.
Action	Pemberian Edukasi Pola Makan ke keluarga pasien di setiap jadwal pengambilan obat bulanan.

c) Triwulan III



Gambar 3.38. Capaian Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan III (Bulan Juli – September) Tahun 2025

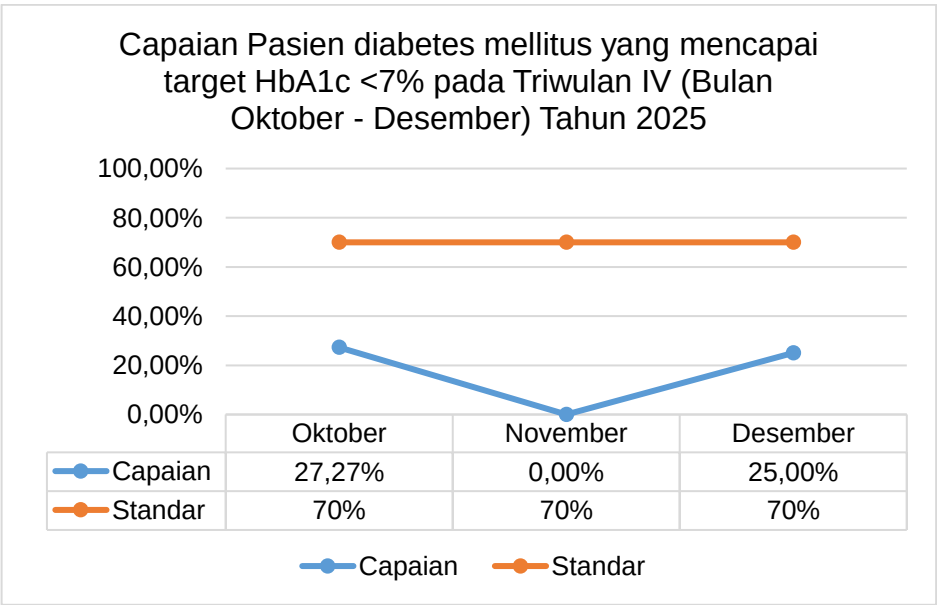
Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian HbA1c dari Januari hingga September 2025, terlihat tren yang belum stabil dan konsisten berada di bawah target standar 70%. Meskipun sempat menyentuh angka 40% di bulan Juni, capaian kembali menurun drastis menjadi 18,18% di bulan Juli sebelum merangkak naik perlahan di bulan Agustus dan September.

Tabel 3. PDSA Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan III (Bulan Juli sampai September) Tahun 2025

Problem	Capaian HbA1c kembali anjlok di bulan Juli (18,18%) setelah sempat naik di Juni (40%). Meskipun naik perlahan di Agustus (28,57%) dan September (33,33%), angka ini tetap jauh di bawah standar 70%.
Step	Siklus 3: Identifikasi Komorbiditas dan Penilaian Risiko Klinis.
Plan	1. Strategi: Melakukan audit terhadap profil pasien yang gagal mencapai target untuk melihat adanya faktor penyerta (komorbid) seperti penyakit jantung, ginjal, atau usia lanjut. 2. Target: Memetakan alasan medis mengapa target 7% sulit dicapai secara massal.
Do	Mendata komorbiditas pasien DM yang rutin kontrol.
Study	Ditemukan bahwa rendahnya capaian bukan hanya karena perilaku, tetapi karena kondisi klinis pasien (lansia dengan banyak komorbid) yang membuat target HbA1c < 7% terlalu berisiko (risiko hipoglikemia) dan secara medis sulit dicapai.
Action	Memutuskan untuk meninjau ulang kelayakan indikator HbA1c < 7% sebagai standar mutu tunggal karena tidak sesuai dengan profil risiko pasien yang ada.

d) Triwulan IV



Gambar 3.39. Capaian Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan IV (Bulan Oktober - Desember) Tahun 2025

Hasil capaian:

Capaian pasien DM yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan 4 menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan dan tidak stabil dengan rincian sebagai berikut capai bulan oktober yakni 27,27%, bulan november yakni 0% idak ada pasien yang mencapai target dan bulan desember yakni 25%.

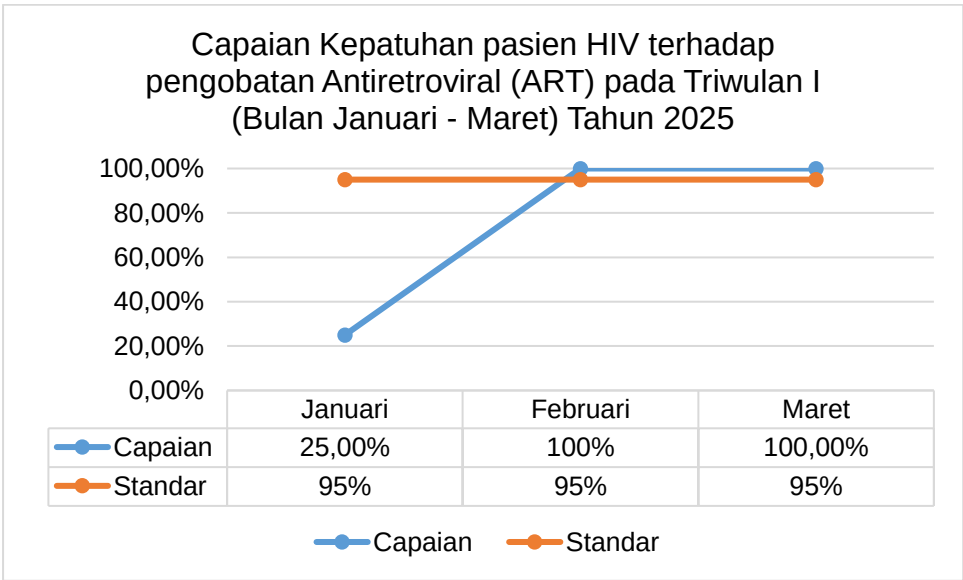
Tabel 3. PDSA Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7% pada Triwulan IV (Bulan Oktober sampai Desember) Tahun 2025

Problem	Capaian akhir tahun menunjukkan kegagalan sistemik mencapai target: 27,27% (Oktober), 0,00% (November), dan 25,00% (Desember).
---------	--

	Standar 70% terbukti tidak <i>achievable</i> bagi pasien DM dengan faktor penyerta kompleks
Step	Siklus 4: Penghapusan indikator mutu HbA1c <7%
Plan	Strategi: Mengajukan penghapusan indikator HbA1c <7% kepada Tim Mutu karena alasan klinis (faktor penyerta)
Do	1. Menyusun laporan akhir tahun yang menunjukkan bahwa kegagalan target disebabkan oleh faktor biologis/komorbid, bukan sekadar ketidakpatuhan pasien.
Study	Evaluasi: Menilai respon manajemen; disepakati bahwa memaksakan target 7% pada pasien dengan banyak faktor penyerta dapat menurunkan kualitas keselamatan pasien (risiko komplikasi lain)
Action	1. Menghapus indikator HbA1c <7% dari profil mutu layanan.

8) Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ARV)

a. Triwulan I



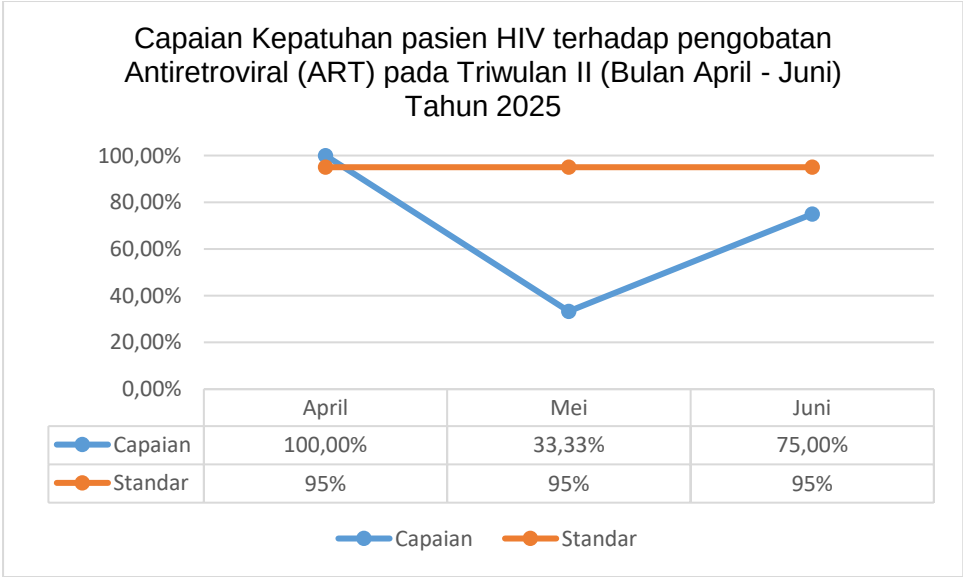
Gambar 3.40. Capaian Kepatuhan Pasien HIV terhadap pengobatan Antiretrovial (ARV) pada Triwulan I (Bulan Januari - Maret) Tahun 2025

Hasil Capaian:

Tabel 3. PDSA Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ARV) pada Triwulan I (Bulan Januari sampai Maret) Tahun 2025

Problem	Rendahnya kepatuhan pada bulan Januari (25,00%) disebabkan adanya pasien yang gagal <i>follow up</i> , sehingga berisiko terjadi putus obat
Step	Siklus 1: Pelacakan (<i>Tracing</i>) Pasien Gagal <i>Follow Up</i>
Plan	Melakukan pelacakan segera terhadap 3 pasien yang gagal <i>follow up</i> agar kembali mengakses layanan pengobatan ARV
Do	Menghubungi via telepon bagi pasien yang tidak datang kontrol.
Study	Intervensi pelacakan terbukti sangat efektif karena capaian kepatuhan meningkat drastis menjadi 100% pada bulan Februari dan Maret. Hal ini menunjukkan pasien kembali patuh menjalani pengobatan.
Action	Mengirimkan <i>feedback</i> rujukan atau notifikasi secara resmi kepada Puskesmas domisili pasien melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) jika pasien sulit dihubungi secara mandiri oleh pihak RS.

b. Triwulan II

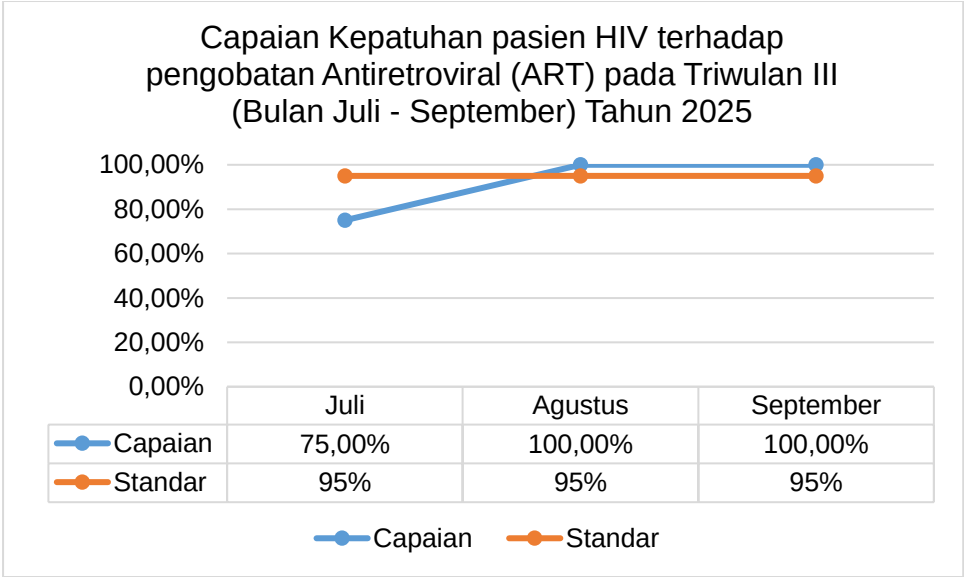


Gambar 3.41. Capaian Kepatuhan Pasien HIV terhadap pengobatan Antiretrovial (ARV) pada Triwulan II (Bulan April - Juni) Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ARV) pada Triwulan II (Bulan April sampai Juni) Tahun 2025

Problem	Capaian kepatuhan kembali fluktuatif dan anjlok hingga 33,33% pada bulan Mei. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengingat mandiri dari RS belum cukup kuat untuk mencegah pasien mangkir berulang.
Step	Siklus 1 Lanjutan: Pelacakan (<i>Tracing</i>) Pasien Gagal <i>Follow Up</i>
Plan	Melakukan pelacakan segera terhadap pasien yang gagal <i>follow up</i> agar kembali mengakses layanan pengobatan ARV di RS Rujukan.
Do	1. Menghubungi via telepon bagi pasien yang tidak datang kontrol. 2. Admin SIHA RS melakukan verifikasi data harian pasien yang mangkir. 3. Mengirimkan notifikasi resmi kepada Puskesmas domisili melalui aplikasi SIHA agar petugas lapangan segera melakukan pelacakan (<i>tracing</i>).
Study	1. Intervensi pelacakan melalui SIHA menunjukkan hasil yang beragam: pada bulan April berhasil mencapai 100,00%, namun jatuh ke 33,33% di bulan Mei. 2. Peningkatan kembali ke angka 75,00% di bulan Juni menunjukkan bahwa respon notifikasi SIHA mulai berdampak, namun belum mencapai standar minimal 95%.
Action	Mengirimkan <i>feedback</i> rujukan atau notifikasi secara resmi kepada Puskesmas domisili pasien melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) jika pasien sulit dihubungi secara mandiri oleh pihak RS.

c. Triwulan III

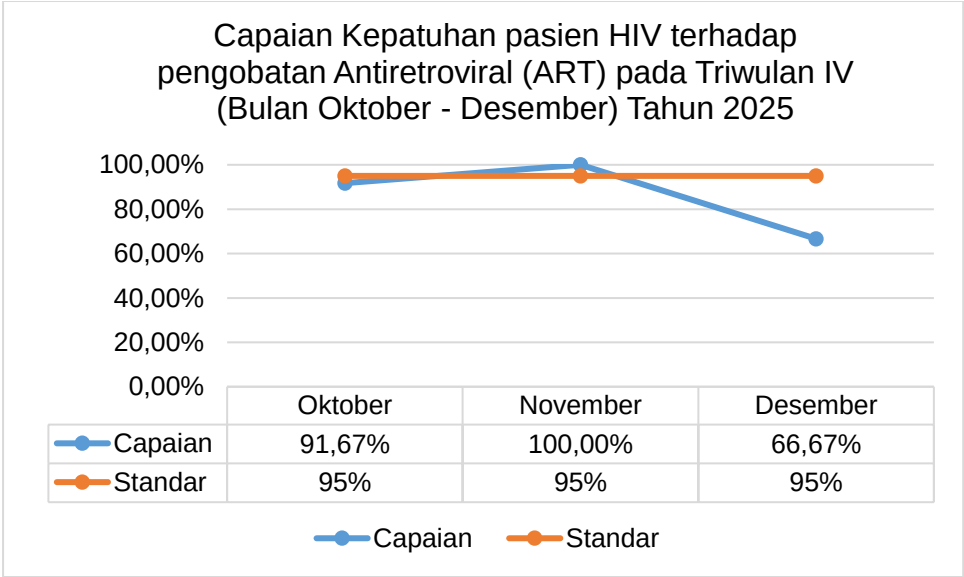


Gambar 3.42. Capaian Kepatuhan Pasien HIV terhadap pengobatan Antiretrovial (ARV) pada Triwulan III (Bulan Juli - September) Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ARV) pada Triwulan III (Bulan Juli sampai September) Tahun 2025

Problem	Capaian pada bulan Juli (75,00%) masih belum memenuhi standar minimal 95%. Hal ini menunjukkan masih adanya sisa kasus pasien mangkir yang memerlukan pelacakan intensif dari periode sebelumnya.
Step	Siklus 1 (Lanjutan): Pelacakan (<i>Tracing</i>) Pasien Gagal <i>Follow Up</i> melalui Koordinasi Jejaring.
Plan	Melakukan pelacakan segera terhadap pasien yang gagal <i>follow up</i> agar kembali mengakses layanan pengobatan ARV di RS Rujukan.
Do	1. Menghubungi via telepon bagi pasien yang tidak datang kontrol. 2. Admin SIHA RS melakukan verifikasi data harian pasien yang mangkir. 3. Mengirimkan notifikasi resmi kepada Puskesmas domisili melalui aplikasi SIHA agar petugas lapangan segera melakukan pelacakan (<i>tracing</i>).
Study	1. Intervensi melalui SIHA pada triwulan ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana kepatuhan meningkat dari 75,00% (Juli) menjadi 100,00% pada Agustus dan September. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi dengan Puskesmas melalui SIHA sangat efektif untuk mengembalikan pasien ke pengobatan.
Action	Mengirimkan <i>feedback</i> rujukan atau notifikasi secara resmi kepada Puskesmas domisili pasien melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) jika pasien sulit dihubungi secara mandiri oleh pihak RS. Sistem ini dipertahankan karena terbukti berhasil mencapai target 100%.

d. Triwulan IV

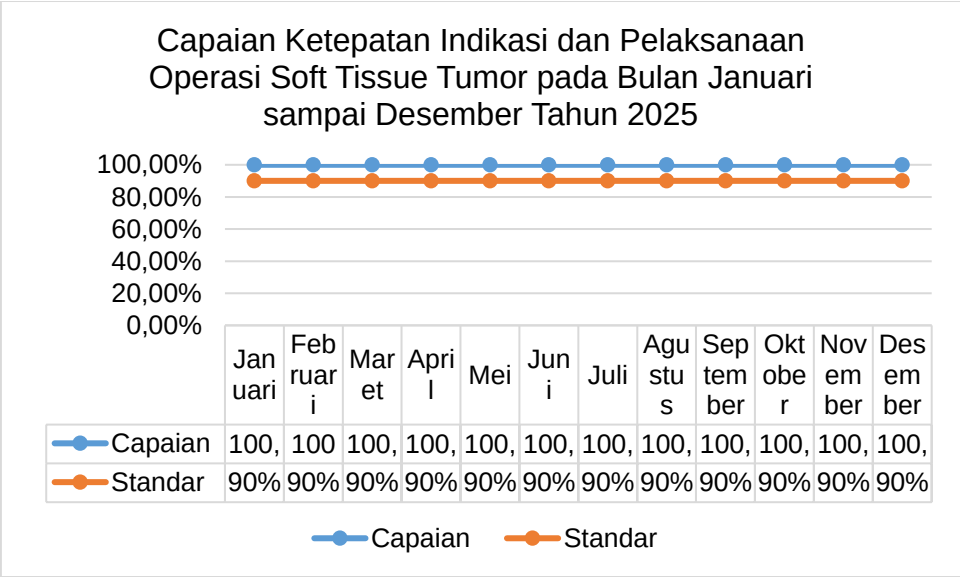


Gambar 3.43. Capaian Kepatuhan Pasien HIV terhadap pengobatan Antiretrovial (ARV) pada Triwulan IV (Bulan Oktober – Desember)Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ARV) pada Triwulan IV (Bulan Oktober sampai Desember) Tahun 2025

Problem	Terjadi penurunan kepatuhan yang sangat signifikan di akhir tahun, yaitu sebesar 66,67% pada bulan Desember, setelah sempat mencapai 100,00% pada bulan November. Kondisi ini meningkatkan risiko putus obat (<i>Lost to Follow Up</i>) massal di akhir tahun.
Step	Siklus 1 (Lanjutan): Pelacakan (<i>Tracing</i>) Pasien Gagal <i>Follow Up</i> melalui Koordinasi Jejaring.
Plan	Melakukan pelacakan segera terhadap pasien yang gagal <i>follow up</i> agar kembali mengakses layanan pengobatan ARV di RS Rujukan.
Do	1. Menghubungi via telepon bagi pasien yang tidak datang kontrol. 2. Admin SIHA RS melakukan verifikasi data harian pasien yang mangkir. 3. Mengirimkan notifikasi resmi kepada Puskesmas domisili melalui aplikasi SIHA agar petugas lapangan segera melakukan pelacakan (<i>tracing</i>).
Study	1. Sistem notifikasi SIHA berhasil menjaga kepatuhan di angka 91,67% (Oktober) dan 100,00% (November). 2. Namun, angka 66,67% pada Desember menunjukkan bahwa sistem notifikasi saja tidak cukup kuat melawan hambatan akses layanan di akhir tahun, sehingga memerlukan evaluasi respon Puskesmas yang lebih cepat.
Action	Mengirimkan <i>feedback</i> rujukan atau notifikasi secara resmi kepada Puskesmas domisili pasien melalui aplikasi SIHA jika pasien sulit dihubungi secara mandiri oleh pihak RS. Aksi ini tetap menjadi fondasi utama RS Rujukan untuk memastikan pasien yang mangkir di Desember terlacak dan kembali berobat pada awal tahun 2026.

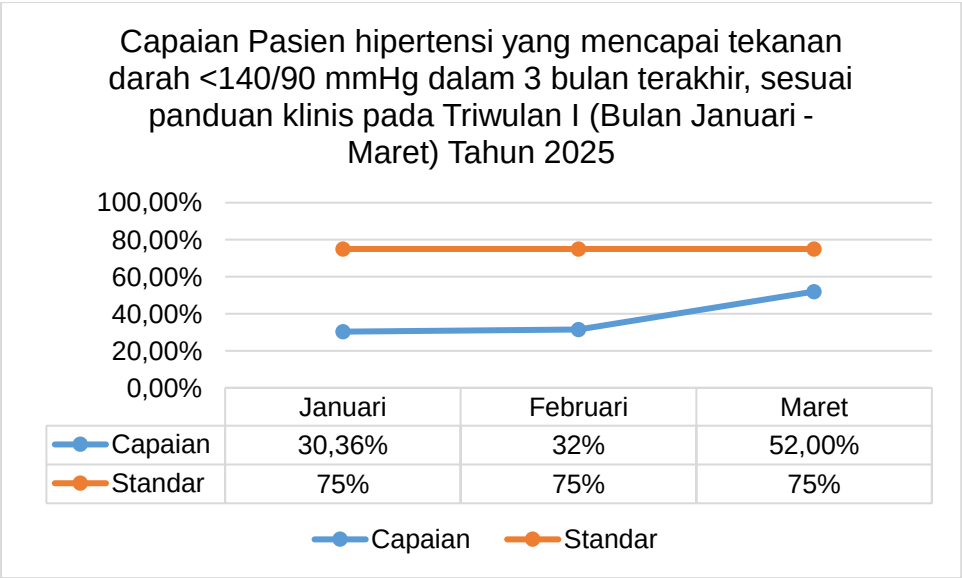
9) Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor



Gambar 3.44. Capaian Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor pada Bulan Januari sampai Desember Tahun 2025

Hasil Capaian:
Berdasarkan data capaian Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor pada Bulan Januari sampai Desember Tahun 2025 yakni 100% dan memenuhi standar yang ditetapkan. Angka 100% yang konsisten menunjukkan bahwa seluruh tindakan operasi tumor jaringan lunak yang dilakukan di Rumah Sakit telah melalui prosedur diagnosis yang tepat, indikasi medis yang sesuai, dan pelaksanaan operasi yang mengikuti standar operasional prosedur (SOP) bedah.

10) **Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis**
a) Triwulan I

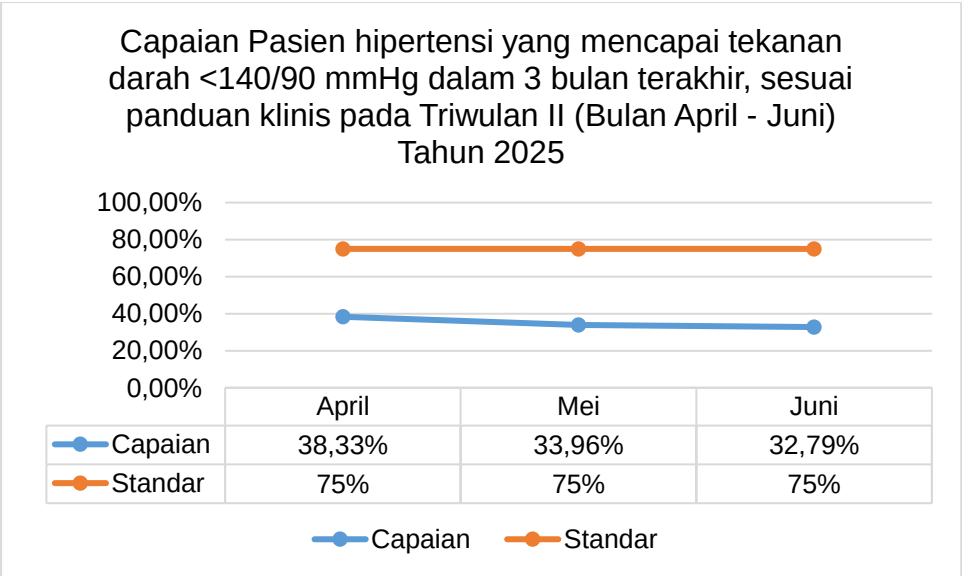


Gambar 3.45. Capaian Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis pada Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis

Problem	Capaian pada bulan Januari dan Februari masih sangat rendah (kisaran 30-31%), menunjukkan lebih dari 60% pasien hipertensi belum mencapai target tekanan darah yang aman.
Step	Siklus 1: Implementasi Paket Intervensi Terpadu (Edukasi, Monitoring Mandiri, dan Manajemen Komorbid).
Plan	Strategi: Meningkatkan jumlah pasien yang mencapai target <140/90 mmHg dengan cara mengintegrasikan edukasi gaya hidup, kepatuhan obat, dan koordinasi antar dokter spesialis untuk pasien dengan penyakit penyerta.
Do	1. Kepatuhan Terapi: Farmasi melakukan rekonsiliasi dan pemberian label jadwal minum obat yang jelas pada setiap kunjungan. 2. Pasien dapat melakukan monitoring mandiri di rumah untuk mencapai tekanan darah <140/90 3. Memberikan leaflet terkait Cara mengontrol tekanan darah untuk pasien Hipertensi
Study	1. Hasil pemantauan menunjukkan kenaikan drastis pada bulan Maret menjadi 52,00% (26 dari 50 pasien). 2. Hal ini menunjukkan bahwa gabungan antara edukasi gaya hidup dan manajemen komorbid mulai memberikan dampak nyata bagi pasien.
Action	Menetapkan paket edukasi terpadu dan monitoring mandiri sebagai standar pelayanan di poliklinik penyakit dalam.

b) Triwulan II



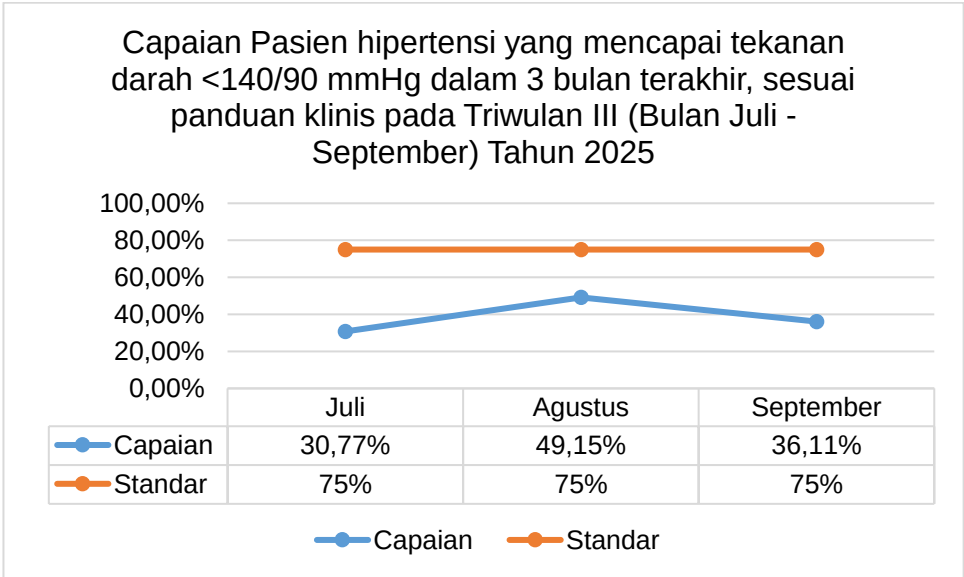
Gambar 3.46. Capaian Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis pada Bulan April sampai Juni Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis

Problem	Capaian pada Triwulan II menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yaitu dari 38,33% di bulan April turun menjadi 32,79% di bulan Juni. Hal ini menunjukkan adanya risiko kegagalan kontrol tekanan darah jangka panjang bagi pasien hipertensi.
Step	Siklus 2: Penguatan Kembali Paket Intervensi Terpadu (Edukasi, Monitoring Mandiri, dan Manajemen Komorbid).
Plan	Strategi: Berupaya menaikkan kembali angka capaian target < 140/90 mmHg dengan memperbaiki kedisiplinan pasien dalam kepatuhan obat, monitoring mandiri, gaya hidup, dan koordinasi penanganan komorbid.
Do	1. Kepatuhan Terapi: Farmasi melakukan rekonsiliasi dan pemberian label jadwal minum obat yang jelas pada setiap kunjungan.

	2. Pasien dapat melakukan monitoring mandiri di rumah untuk mencapai tekanan darah <140/90 3. Memberikan leaflet terkait Cara mengontrol tekanan darah untuk pasien Hipertensi
Study	1. Meskipun intervensi (rekonsiliasi obat dan leaflet) sudah dijalankan, angka capaian tetap menurun dari 38,33% (April) ke 32,79% (Juni). 2. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar memberikan leaflet dan label obat belum cukup efektif jika tidak dibarengi dengan pengawasan aktif dari pihak keluarga atau tenaga kesehatan, mengingat jumlah pasien di bulan Juni adalah yang tertinggi (61 pasien).
Action	Mengubah pendekatan dari sekadar edukasi pasif (leaflet) menjadi edukasi aktif dengan melibatkan pendamping minum obat (keluarga)

c) Triwulan III

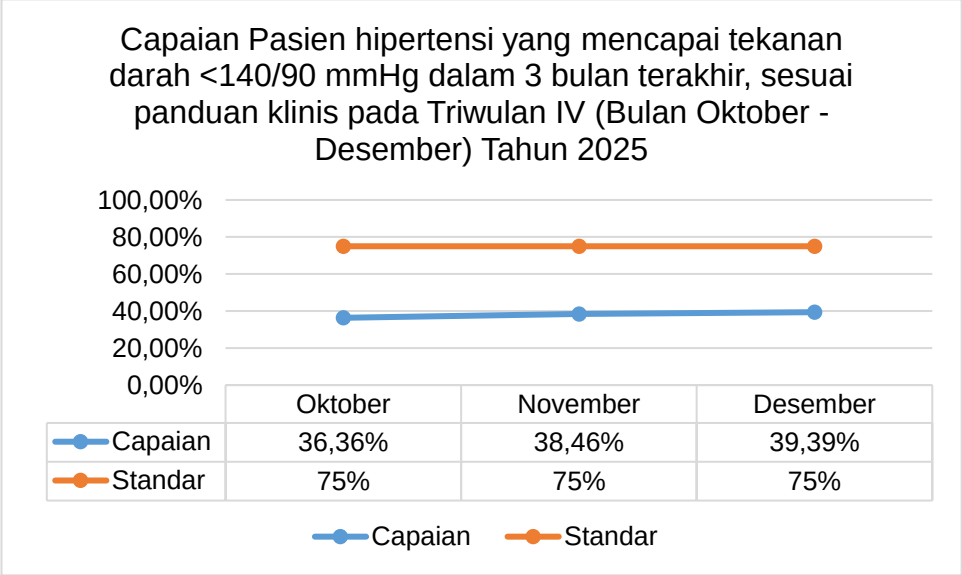


Gambar 3.47. Capaian Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis pada Bulan Juli sampai September Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis

Problem	Capaian pada bulan Juli menyentuh angka terendah (30,77%) seiring dengan melonjaknya jumlah pasien (78 orang). Meskipun sempat membaik di bulan Agustus, angka kembali turun di September, menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga belum konsisten memberikan hasil stabil
Step	Siklus 3: Penguatan Peran Pengawas Minum Obat (PMO) Keluarga dan Monitoring Ketat Pasien Komorbid.
Plan	Strategi: Meningkatkan kepatuhan pasien melalui pemberdayaan keluarga sebagai Pengawas Minum Obat (PMO).
Do	1. Kepatuhan Terapi: Farmasi melakukan rekonsiliasi dan pemberian label jadwal minum obat yang jelas pada setiap kunjungan. 2. Pasien dapat melakukan monitoring mandiri di rumah untuk mencapai tekanan darah <140/90 3. Memberikan leaflet terkait Cara mengontrol tekanan darah untuk pasien Hipertensi
Study	1. Kenaikan di bulan Agustus ke 49,15% membuktikan bahwa pelibatan aktif keluarga sangat membantu menekan angka tekanan darah pasien.
Action	Mengubah pendekatan dari sekadar edukasi pasif (leaflet) menjadi edukasi aktif dengan melibatkan pendamping minum obat (keluarga)

d) Triwulan IV

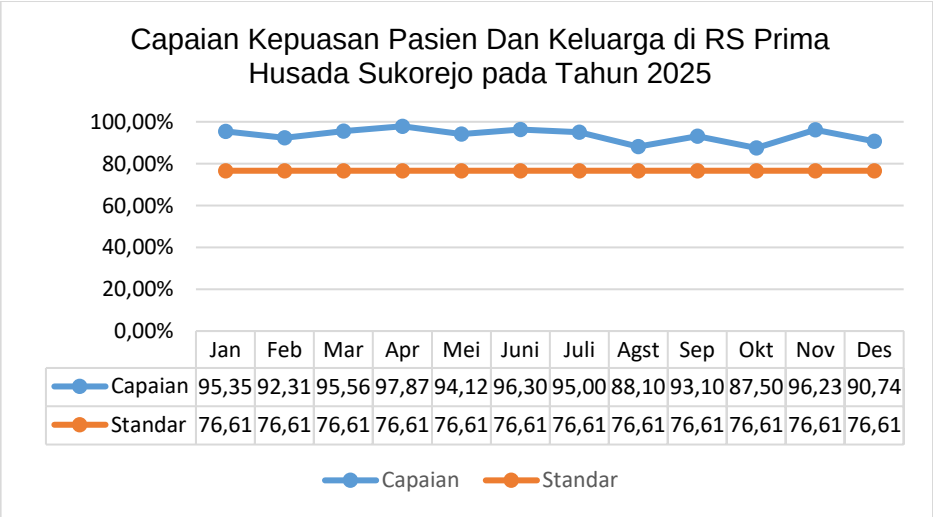


Gambar 3.48. Capaian Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis pada Bulan Oktober sampai Desember Tahun 2025

Tabel 3. PDSA Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis

Problem	Capaian pada bulan Oktober (36,36%) masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target optimal, meskipun menunjukkan perbaikan dari bulan September (36,11%). Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan jangka panjang pasien masih perlu diperkuat di akhir tahun.
Step	Siklus 4: Keberlanjutan Pengawasan Aktif melalui Pemberdayaan Keluarga sebagai Pengawas Minum Obat (PMO).
Plan	Strategi: Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pasien melalui pemberdayaan keluarga sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) untuk menjaga kestabilan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg
Do	1. Kepatuhan Terapi: Farmasi melakukan rekonsiliasi dan pemberian label jadwal minum obat yang jelas pada setiap kunjungan. 2. Pasien dapat melakukan monitoring mandiri di rumah untuk mencapai tekanan darah <140/90 3. Memberikan leaflet terkait Cara mengontrol tekanan darah untuk pasien Hipertensi
Study	1. Terdapat tren peningkatan yang stabil selama Triwulan 4, yaitu dari 36,36% pada Oktober, naik menjadi 38,46% pada November, dan mencapai 39,39% pada Desember
Action	Mengubah pendekatan dari sekadar edukasi pasif (leaflet) menjadi edukasi aktif dengan melibatkan pendamping minum obat (keluarga). Mengingat tren yang terus meningkat secara stabil hingga akhir tahun (39,39%)

- b. Terkait Renstra
- 1) Kepuasan Pasien

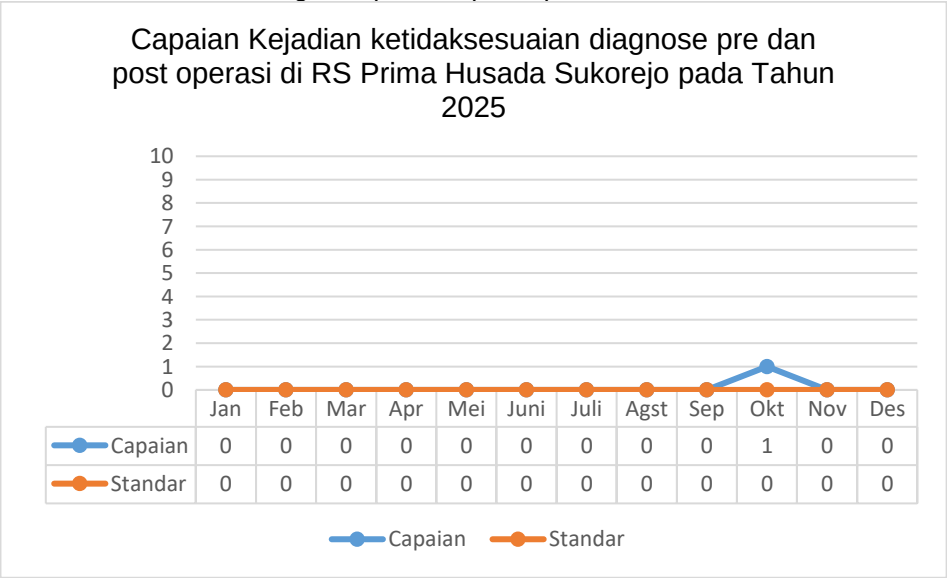


Gambar 3.49. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian kepuasan pasien dan keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik, dimana rata – rata capaian tahun 2025 yakni 93,52%. Capaian kepuasan tertinggi terjadi pada bulan April (97,87%), disusul oleh bulan Juni (96,30%) dan November (96,23%). Angka ini menunjukkan adanya kualitas layanan yang sangat optimal pada periode tersebut.

- 3. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi

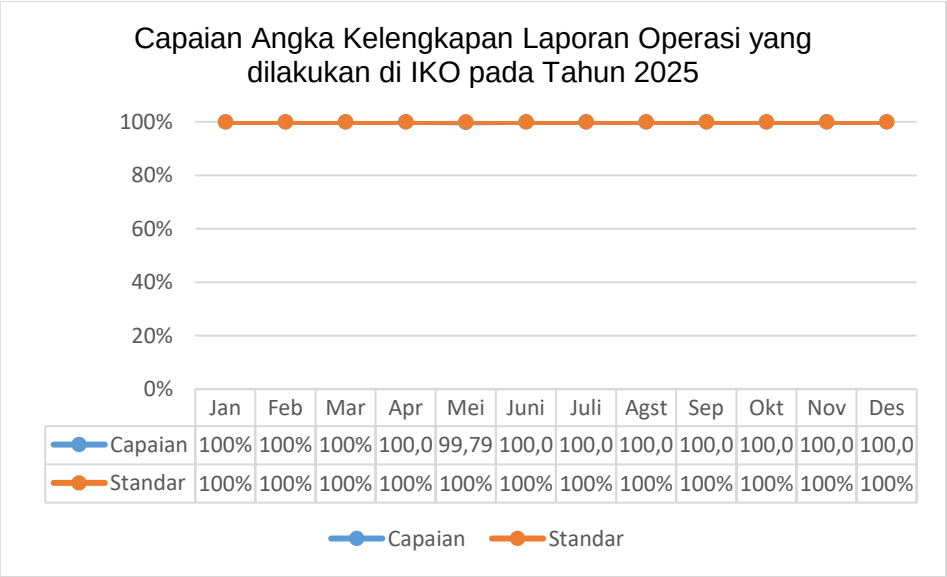


Gambar 3.33. Capaian Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 capaian kejadian ketidaksesuaian diagnose pre & post operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian.

- b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO

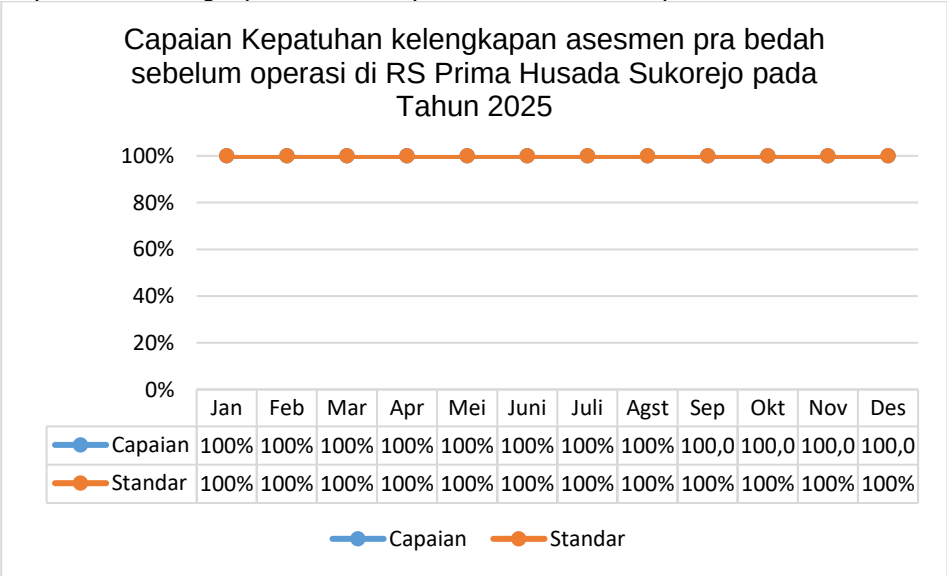


Gambar 3.34. Capaian Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang dilakukan di IKO di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 capaian angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100% sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

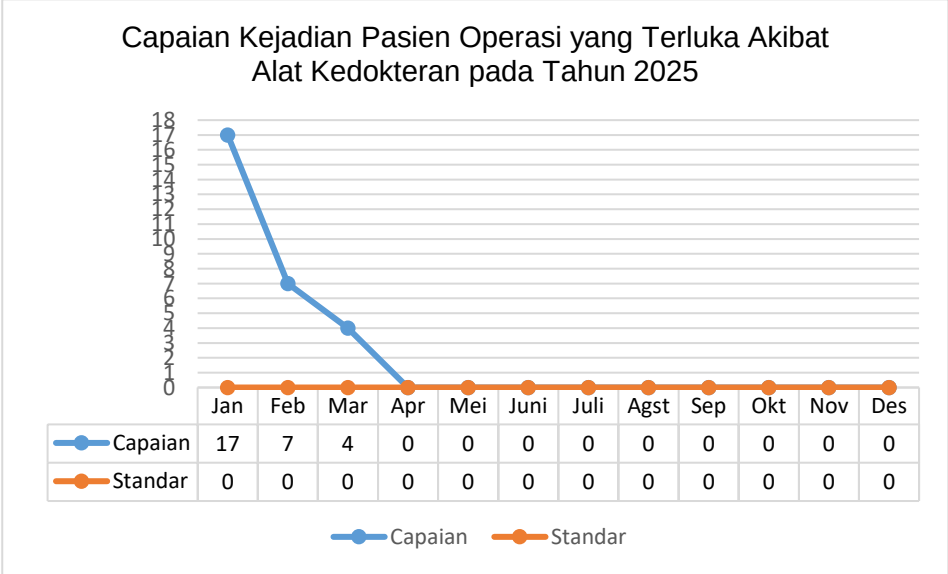


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Desember Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 2025 capaian kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prosedur asesmen pra bedah sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin yang terstandarisasi di ruang tindakan/pre-operatif.

4. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko
- a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran

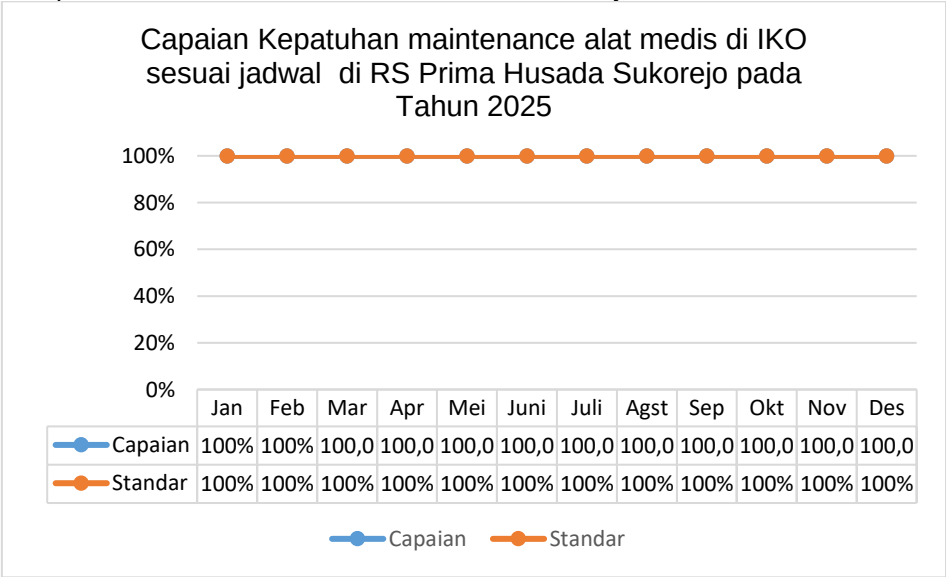


Gambar 3.36. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Pada bulan Maret 2025, telah dilakukan pergantian alat kedokteran, khususnya harum pen. Dampak positifnya pada Tahun 2025 yakni menurunnya risiko cedera pada pasien operasi, dan meningkatkan kinerja tim bedah dan sterilisasi karena alat sudah memenuhi standar.

- b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal



Gambar 3.37. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.16 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,55%	95,48%	85,00%	100%	100%	100%	97,81%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	58,57%	77,78%	83,78%	82,35%	80,49%	94,59%	87,80%	71,43%	75%	76,92%	81,82%	100%	≥ 85 %	80,88%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	91,86%	92,31%	95,56%	95,74%	92,16%	92,59%	100%	97,62%	94,74%	91,67%	98,11%	95,56%	≥ 76,61 %	94,83%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	98,65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	98,89%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR		95%	87,74%	97,33%	88,39%	98,67%	98,06%	95,48%	88,39%	95,48%	100%	100%	100%	94,96%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi yang dimusnahkan
3	Pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol													≥ 95%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,48%	96,77%	96,77%	100%	96,77%	100%	97,57%	PDSA
2	Kematian pasien < 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	18/1785	17/1768	9/1860	13/1945	20/1921	24/1200	11/1000	7/1000	13/1826	24/1942	17/1998	23/2000	≤ dua per seribu		PDSA
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	85%	99,29%	98,06%	96,00%	89,03%	88,39%	89,03%	87,10%	88,39%	93,55%	100%	100%	100%	92,82%	PDSA
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	87%	95,71%	97,42%	96,67%	96,01%	97,33%	98,06%	96,13%	97,86%	100%	100%	100%	100%	96,85%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Kelengkapan pengisian LOP	85%	90,71%	96,77%	97,33%	89,68%	87,74%	88,39%	96,77%	85,81%	100%	100%	100%	100%	93,18%	PDSA
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	84,66%	100%	100%	93,75%	90,32%	90%	100%	74,19%	90,32%	100%	100%	100%	100%	93,60%	PDSA
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit	70%	100%	100%	90,32%	0,9%	0,9%	93,55%	66,45%	90,32%	80%	66,67%	100%	100%	71,59%	PDSA
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	80%	100%	100%	90,32%	90,32%	90,32%	100%	100%	90,32%	93,55%	66,67%	96,77%	100%	91,52%	PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.22 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100,00 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	78,23 %	82,78 %	84,40 %	86,96 %	79,07 %	71,83 %	-	-	-	-	-	≥ 85 %	83,32%	PDSA

3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	61,67 %	69,17 %	67,50 %	58,33 %	-	67,83 %	-	76,92 %	73,33%	80,74%	42,19%	91,11%	100%	68,88%	PDSA
4	Kepuasan pasien	92,44 %	92,31 %	95,56 %	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	≥ 76,61%	95,08%	Dipertahankan
5	Waktu tunggu rawat jalan	71,25 %	68,24 %	59,17 %	74,78 %	70,14 %	79,70 %	64,29 %	58,46 %	60,81%	98,48%	85,19%	98,12%	≥ 80%	74,05%	PDSA
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	88,89 %	98,89 %	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	33,33%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				-	-	-							≤5%		Belum diisi
2	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				-	-	-							≥ 95%		Belum diisi
3	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				-	-	-							≥ 70%		Belum diisi

4	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				100%	100%	100%							≥ 95%		Dipertahankan
5	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor													≥ 90 %		Belum diisi
6	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis													≥ 75 %		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	13,45 %	13,87 %	1,94%	9,98%	9,68%	14,00 %	-	41,72 %	31,25%	25,07%	-	-	0%	17,88%	Belum diisi
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100,00%	Dipertahankan

	E-RM pasien rawat jalan															
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	100%	99,09 %	100%	100%	100%	100%	-	76,92 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	97,82%	PDSA
4.	Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien	93,33 %	100%	100%	100%	95,87 %	100%	-	-	100,00 %	100%	100%	100%	100%	98,92%	PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	78,89%	95,45%	94,55%	94,55%	94,55%	96,19%	95,38%	96,00%	79,17%	96,15%	96,67%	95,83%	100%	92,78%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	50%	71,34%	77,91%	69,03%	86,67%	52,50%	69,68%	73,11%	77,78%	83,67%	89,55%	≥ 85 %	75,10%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,56%	95,45%	95,45%	93,64%	95,45%	96,19%	96,92%	96,00%	96,67%	95,38%	95,83%	95,83%	100%	95,70%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	100%	85,71%	80%	100%	100%	-	91,67%	90%	100%	100%	≥ 76,61 %	95,22%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	45,56%	85,45%	86,36%	87,27%	84,55%	76,19%	79,23%	80,80%	81,67%	72,31%	79,17%	80,83%	≥ 80%	78,28%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80%		Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	33,33%	100%	98,04%	100%	100%	100%	97,14%	73,33%	91,67%	78,57%	96,77%	100%	100%	89,07%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	96,88%	95,24%	91,38%	94,37%	100%	96,30%	94,94%	96,43%	100%	93,06%	94,29%	100%	96,07%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 90%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.															
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 95%	100%	Dipertahankan
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan										-			≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara										-			≥ 95%		

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	yang sesuai dengan protokol															
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%			22,22%	25%	33,33%	0%	25%	17,65%	18,18%	6,25%	0,65%	37,50%	≥ 70%	16,48%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)													≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor													≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis													≥ 75 %		

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,72%	1,64%	1,19%	1,82%	1,33%	0,73%	1,60%	2,65%	1,54%	2,58%	2,00%	1,73%	≤ 0,24 %	1,71%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	5 kejadian	5 kejadian	2 kejadian	6 kejadian	3 kejadian	5 kejadian	7 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	1 kejadian	8 kejadian	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	93,33%	91,82%	95,45%	96,36%	94,55%	100%	96,15%	96,00%	95,83%	96,15%	95%	95%	100%	95,47%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	87,5%	100%	94,55%	93,64%	95,45%	100%	96%	96,80%	96,67%	95%	94,17%	92,50%	100%	95,19%	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	93,55%	98,57%	98,71%	99,33 %	99,35 %	99,33 %	98,71 %	100%	100,00 %	100%	96,00 %	96,13 %	100%	98,31 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	78,02%	77,91 %	73,12 %	80,85 %	58,93 %	69,60 %	71,21%	86,96 %	86,36 %	87,50 %	≥ 85 %	80,87 %	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,84%	92,86%	90,97%	95,33 %	95,48 %	95,33 %	96,13 %	96,13 %	93,55%	96,77 %	99,33 %	94,19 %	100%	95,08 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	-	90%	100%	100%	-	100%	80%	100%	100%	84%	93,33 %	≥ 76,61 %	94,73 %	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	76,13%	65,71%	64,52%	68,67 %	78,71 %	66,00 %	76,77 %	64,52 %	68,39%	68,39 %	47,33 %	54,19 %	≥ 80%	66,61 %	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada diagnosa tunggal	Tidak ada diagnosa tunggal	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80%	100%	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	98,77%	100%	100%	100%	81%	71,11 %	72%	100%	90%	100%	100%	92,74 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	92,26%	88,57%	85,81%	92,67 %	93,55 %	94,00 %	93,55 %	100%	96,77%	100%	99,33 %	97,42 %	100%	96,77 %	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi				-	-			-					100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.									0,65%				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin)													≥ 95%		

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium															
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan													≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol													≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%			16,67%		5%	0%	0%	0%	9,09%	3,23%	0,65%	0,65%	≥ 70%	3,92%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)													≥ 95%		

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor													≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis													≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,69%	0,27%	1,34%	1,40%	0,24%	0,25%	0,73%	0,27%	0,82%	1,94%	0,53%	0,98%	≤ 0,24 %	0,87%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	5 Kejadian	1 Kejadian	2 Kejadian	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	5 kejadian	3 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan	92,26%	75,71%	70,97%	90,67 %	91,61 %	94,00 %	87,10 %	100%	96,77%	100%	84,00 %	71,61 %	100%	87,89 %	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam															
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	93,55%	87,86%	80%	91,33 %	92,90 %	92,00 %	90,32 %	88,39 %	92,67%	92,90 %	80%	93,33 %	100%	89,60 %	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	97,42%	98,57 %	98,06%	99,33 %	98,06 %	98,67 %	98,71 %	98,71 %	98,67 %	99,35 %	98,67 %	99,35 %	100%	98,63 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	76,36%	80,77 %	88,41%	82,46 %	85,11 %	95,83 %	76,47 %	69,23 %	75,93 %	79,31 %	88,64 %	87,50 %	≥ 85 %	82,17 %	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,77%	97,86 %	96,13%	98,67 %	96,77 %	98,00 %	97,42 %	98,06 %	98,00 %	99,35 %	99,33 %	98,71 %	100%	97,92 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	95,45%	88,57 %	95,24%	100%	92,86 %	100%	100%	88,89 %	88,89 %	90%	90,91 %	100%	≥ 76,61 %	94,23 %	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	82,58%	82,14 %	90,32%	94,00 %	91,29 %	97,33 %	85,81 %	83,87 %	82,00 %	92,90 %	82,67 %	92,90 %	≥ 80%	88,15 %	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada diagnosa tunggal	99,29 %	Tidak ada diagnosa tunggal	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	≥ 80%	99,65 %	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	88,00%	100%	93,10%	95,15 %	100%	-	69,23 %	77,27 %	96,30 %	95,65 %	100%	82,26 %	100%	90,63 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	97,86 %	97,42%	96,13 %	97,42 %	99,33 %	97,42 %	98,06 %	98,67 %	98,71 %	99,33 %	98,71 %	100%	98,09 %	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi				-	-	-	-	-					100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.													≥ 90%		

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu $\leq$ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium													$\geq 95\%$		
5	Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $<7\%$													$\geq 70\%$		
7	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)													$\geq 95\%$		
8	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor													$\geq 90\%$		
9	Pasien hipertensi yang													$\geq 75\%$		

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0,61%	0%	0%	0,59%	0,32%	0%	0,65%	0%	1,02%	0,31%	≤ 0.24 %	0,29%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	1 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	1 kejadian	3 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	97,42%	97,14 %	96,77%	98%	96,77 %	98,67 %	98,06 %	98,06 %	98,00 %	98,06 %	98,00 %	98,71 %	100%	98,71 %	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																

1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	98,71%	98,00%	99,35%	97,33%	99,35%	96,13%	96,00%	96,77%	-	95,48%	100%	97,92%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,50%	44,44%	41,43%	86,96%	85,03%	71,05%	74,29%	69,52%	97,16%	78,05%	100 %	85,71%	≥ 85 %	76,76%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	99,35%	100%	100%	98,67%	90,32%	95,33%	96,77%	92,90%	94,19%	95,48%	-	100%	100%	96,64%	PDSA
4	Kepuasan pasien	92%	100%	100%	100%	78,26%	87,50%	85,71%	90,48%	83,33%	87,05%	-	67%	≥ 76,61 %	88,30%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	63,64%	44,29%	50,97%	35,33%	48,39%	53,33%	61,29%	58,06%	58,06%	38,71%	-	40,65%	≥ 80%	50,25%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80%	100%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	90%	96,77%	100%	100%	100%	76,79%	89,74%	61,90%	81,82%	100 %	100%	100%	91,42%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	72,08%	100%	99,35%	98,00%	98,71%	93,33%	93,55%	94,19%	92,90%	93,55%	-	82,58%	100%	92,57%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi

	obat sisa anastesi															
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.													≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau													≥ 95%		

	konfirmasi laboratorium															
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan													≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol													≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%			0%	33,33%	0%	88,89%	12,50%	1,94%	0,65%	8,38%	0%	0%	≥ 70%	14,57%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)													≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor													≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang													≥ 75 %		

	mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien $\leq$ 48 jam	0,35%	0%	1,53%	0,37%	1,36%	1,01%	0,63%	0,36%	0%	1,29%	-	0,67%	≤ 0.24 %	0,69%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	1 kejadian n	0 kejadian n	1 kejadian n	2 kejadian n	2 kejadian n	0 kejadian n	1 kejadian n	0 kejadian n	0 kejadian n	1 kejadian n	-	0 kejadian n	0 kejadian n	1 kejadian n	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian n	1 kejadian n	4 kejadian n	0 kejadian n	1 kejadian n	0 kejadian n	1 kejadian n	5 kejadian n	0 kejadian n	0 kejadian n	-	0 kejadian n	0 kejadian n	2 kejadian n	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP $\leq$ 24 Jam	66,23%	62,14%	62,58%	79,33%	42,58%	75,33%	82,58%	87,10%	94,84%	93,55%	-	98,06%	100%	76,76%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	96,67%	98,71%	98,00%	97,42%	98,06%	96,67%	96,78%	-	96,77%	100%	98,10%	PDSA

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,85 %	100%	99,80 %	100%	100%	100%	100%	99,97 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	44,44 %	-	75%	46,15 %	-	-	92,00 %	71,43 %	82,61 %	80%	76,00 %	≥ 85 %	74,18 %	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	0%	3,43%	1,08%	4,52%	1,37%	3,84%	3,68%	3,98%	2,36%	4,05%	3,17%	2,83%	≤ 5%	2,86%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	95,35 %	92,31 %	95,56 %	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	≥ 76,61 %	96,64 %	Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	-	0%	100%	0%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		Tidak ada pemberian MgSO4 di Ruang IKO
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	99,79 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat	17 kejadian	7 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	alat kedokteran															
9	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)	-	-	-										100%		Belum diisi
2.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari	-	-	-										100%		Belum diisi
3.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.81 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Bulan Desember Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada sisa obat anestesi
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0%	0 kejadian	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.82 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,77 %	96,35 %	94,56 %	93,57 %	96,13 %	97,84 %	97,95 %	96,09 %	96,13 %	94,44 %	95,97 %	100%	100%	95,98 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	80%	71,79 %	68,18 %	86,67 %	92,47 %	94,00 %	85,19 %	73,91 %	80,00 %	84,09 %	94,87 %	93,55 %	≥ 85 %	82,83 %	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	88,00 %	100%	97,22 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,66 %	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	89%	88%	100%	91,67 %	100%	100%	100%	92,31 %	100%	95%	80,95 %	53%	> 80%	94,27 %	Dipertahankan
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	85,29 %	85,98 %	94,12 %	88,57 %	88,99 %	92,73 %	93,50 %	95,15 %	93,50 %	90,63 %	81,55 %	82,88 %	≥ 80%	90,00 %	Dipertahankan
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	99,70 %	96,88 %	98,70 %	98,44 %	98,84 %	98,75 %	99,19 %	98,99 %	100%	99,02 %	100%	100%	≥ 80%	98,96 %	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada pasien yang barcode	100%	67%	≥ 76,61 %	97%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada	100%	85,71 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam															
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
10	Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
13	Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.86 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,07%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	100%	100%	100%	85,71%	100%	100%	100%	100%	95%	80,95%	82,35%	> 80%	96,51%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,28%	100%	100%	100%	100%	99,84%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien HPP di Ponok
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

	yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih															
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.87 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata- rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,53 %	100%	100%	98,65 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,74 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	72,73 %	89,02 %	95,70 %	88,79 %	93,55 %	96,81 %	87,10 %	91,30 %	84,31 %	83,04 %	94,67 %	95,10 %	≥ 85%	88,82	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	88,89 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,99 %	PDSA
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	80,88 %	77,05 %	89,74 %	60,81 %	65,82 %	93,41 %	92,08 %	97,65 %	84,54 %	68,57 %	76,60 %	75,00 %	≥ 80%	80,65 %	Dipertahankan

6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 80%		Tidak ada pasien dengan Diagnosa tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	96,55 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,69 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	5 kejadian	4 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	8 kejadian	2 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	12 kejadian	5 kejadian	4 kejadian	9 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	T-piece resuscitator/CP AP dalam waktu 2 menit															
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	100%	92,31 %	92,31 %	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

11. ICU
A. ICU

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100 %	100%	100%	100%	97,83 %	93,10 %	100%	100%	96,55 %	100%	100%	100%	100%	98,86 %	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100 %	100%	75%	75%	100%	65%	81,82 %	90,91 %	83,33 %	77,27 %	100%	81,25 %	≥ 85%	86,21 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	50%	70,97 %	53,85 %	53,57 %	50%	68,97 %	76,00 %	75,00 %	37,93 %	19,44 %	32,25 %	19,51 %	≥ 80%	53,45 %	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100 %	100%	79,17 %	45,45 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	84,06 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥ 95%	-	Tidak ada pasien ca mammae
Indikator Mutu Prioritas Unit																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,96%	0%	0%	3,23%	0%	2,44%	≤ 3 %	0,47%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	100 %	100 %	-	100%	100 %	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	75%	-	-	100%	-	-	-	100 %	100 %	-	≥ 85%	100 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	100 %	100 %	-	100%	100 %	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	-	-	50%	-	-	-	100%	0%	-	≥ 80%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	79,17%	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	Tidak ada pasien ICU Isolasi	Tidak ada pasien bronchopneumonia	Tidak ada pasien bronchopneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien Broncopneumonia
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	-	-	50%	-	-	-	100%	-	-	≥ 80%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	≥ 95%	100%	Dipertahankan

12. RADIOLOGI

Tabel 3.94 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum diisi	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	100%	-	77,78%	100%	100%	-	-	75%	70,83%	-	Belum diisi	≥ 85%	87,27%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	100%	100%	100%	100%	100%	99,35%	-	96,77%	100%	100%	Belum diisi	100%	99,57%	PDSA
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	60 %	-	66,67%	100%	100%	100%		0%	-	100%	-	Belum diisi	100%	75,24%	PDSA
5	Kepuasan pasien	-	-	-	-									≥ 76,61%		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	-	97,04%	91,61%	96%	94,84%	90,32%	95,48%	54,19%	96,77%	100%	100%	Belum diisi	100%	91,63%	PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45,81%	12,00%	6,67%	0%	Belum diisi	0%	6,45%	PDSA
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	-	0%	0%	0%	0%	0%	0,65%	52,90%	45,33%	0%	0%	Belum diisi	0%	9,89%	PDSA
4.	kejadian kesalahan	-	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	155 kejadian	20 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Belum diisi	0 kejadian	18 Kejadian	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	cetak hasil radiologi															

13. LABORATORIUM

Tabel 3.95 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
Indikator Mutu Nasional																	
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	93,75 %	88,51 %	-	-	-	74,19 %	70%	83,33 %	-	-	≥ 85%	72,10 %	PDSA	
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	83,33 %	55,56 %	52,38 %	84,62 %	-	-	-	-	80%	-	-	-	100%	80%	PDSA	
4	Kepuasan pasien													≥76,61 %			
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan	
Indikator Mutu Prioritas Unit																	
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan	
2	kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	99,97 %	100%	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA	

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0,04%	0,04%	0,07%	0%	0,05%	0%	0%	0,03%	0,03%	0,06%	0,08%	0%	0%	0,03%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan form permintaan laboratorium	3,70%	6,61%	6,06%	5,02%	5,25%	5,98%	4,43%	15,55%	34,86%	27,05%	20,34%	4,34%	0%	11,60%	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	< 0,01%	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.99 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	-	84,44%	86,96%	79,07%	-	0%	0%	-	-	-	≥ 85%	-	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	99,17%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	-	-	-	-						≥ 76,61%		Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-			100%	-	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Alat Pelindung Diri															
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.100 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,32%	100%	100%	100%	100%	100%	99,19%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	72,41%	-	88,10%	87,36%	100%	-	100%	76,13%	88,46%	91,80%	89,74%	≥ 85%	88,07%	PDSA
3	Kepatuhan Penggunaa n Alat Pelindung Diri	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahank an
4	Kepuasan pasien	95,35 %	92,31%	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	-	-	-	-	-	-	≥ 76,61 %	95,25%	Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formulariu m	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahank an
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan pemusnah an obat sisa anestesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		Tidak ada obat yang dimusnahka n
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	75%	66,67%	96,67%	83,85%	81,67%	88,00%	73,33%	85,38%	92,00%	89,63%	74,19%	78,52%	100%	82,08%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	75%	77,78%	86,40%	69,23%	75,83%	72,80%	79,29%	70%	74,40%	77,78%	68,39%	74,81%	100%	75,14%	PDSA
3	Kejadian kesalahan pemberian obat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	5 Kejadian	2 Kejadian	0 kejadian	6 kejadian	4 Kejadian	1 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	8 kejadian	18 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 Kejadian	0 Kejadian	3 Kejadian	6 kejadian	3 Kejadian	9 kejadian	0 Kejadian	3 kejadian	PDSA
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	3 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 Kejadian	PDSA

16. GIZI

Tabel 3.101 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	62,50%	78,26%	97,14%	84,72%	80,65%	96,30%	100%	79,49%	74,36%	75,21%	90,41%	91,67%	≥ 85%	84,23%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	83,33%	75,71%	81,16%	100%	80,65%	65,22%	100%	66,67%	81%	86,67%	93,51%	92,96%	100%	83,91%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	95%	88,10%	93,10%	87,5%	96,23%	90,74%	≥ 76,61%	93,52%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	19%	22%	14%	19%	19%	19%	18%	18%	18%	17%	17%	17%	≤ 20 %	18%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.102 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	95%	88,10%	93,10%	87,50%	96,23%	90,74%	76,61%	93,52 %	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	95,87%	92,56%	96,69%	91,74%	95,87%	94,83%	94,85%	96,18%	91,27%	88,24%	84,92%	96,18%	100 %	93,27%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Concent setelah	63,22%	64,29%	63,03%	53,97%	42,24%	30,43%	55,17%	67,21%	55,56%	42,86%	61,54%	60,87%	100 %	55,03%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	mendapatkan informasi yang jelas															
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	4 kejadian	4 kejadian	5 kejadian	6 kejadian	11 kejadian	9 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	6 kejadian	10 kejadian	6 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	6 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	68%	65%	72%	63%	57%	57%	74%	86%	95%	94%	96%	97%	100%	77,00%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	15,46%	15,46%	24,55%	28,13%	24,27%	28,71%	27%	30,11%	36,67%	32,98%	29,89%	37,33%	0%	27,55%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	96,76%	97,02%	97,40%	97,18%	96,84%	96,76%	97,15%	96,96%	96,76%	96,83%	96,83%	96,57%	100%	96,92%	PDSA
8	Kelengkapan General Concent	98,51%	97,79%	96,95%	98,58%	98,51%	99,25%	97,73%	96,49%	91,11%	100%	98,00%	98,06%	100%	97,58%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	6,45%	5%	1,94%	4,03%	3,87%	15,33%	21,29%	9,09%	66,15%	33,55%	34,67%	34,19%	100%	19,63%	PDSA
10	Ketepatan laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	dengan pihak eksternal															

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.103 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD 13,54 mg/l b. COD < 41,13 mg/l c. TSS < 22,4 mg/l d. PH 7,06	a.BOD 9,54 mg/l b. COD < 26,08 mg/l c. TSS < 5,86 mg/l d. PH 7,46	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD = 8,53 mg/l b. COD = 35,70 mg/l c. TSS = 5,72 mg/l d. PH =7,20	a.BOD = 14,75 mg/l b. COD =41,10 mg/l c. TSS = 9,88 mg/l d. PH =7,30	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD = 9,53 mg/l b. COD = 38,92 mg/l c. TSS = 5,72 mg/l d. PH =7,20	a.BOD = 9,28 mg/l b. COD =38,35 mg/l c. TSS = 5,6 mg/l d. PH 7,4	a. BOD = 15,22 mg/l b. COD = 50,59 mg/l c. TSS < 5,80 mg/l d. PH 7,10	a. BOD = 11,87 mg/l b. COD = 44,71 mg/l c. TSS < 5,60 mg/l d. PH 7,43	a. BOD = 17,80 mg/l b. COD = 56,92 mg/l c. TSS < 6,80 mg/l d. PH 7,85	. BOD = 8,70 mg/l b. COD = 24,41 mg/l c. TSS < 6 mg/l d. PH 7,32	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a.BOD = 11,33 mg/l b. COD = 42,62 mg/l c. TSS = 5,7 mg/l d. PH 7,2	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	44,11%	48,18%	61,82%	61,82%	66,15%	66,15%	66,15%	66,74%	66,59%	63,24%	100%	50,91%	1 Tahun

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

19. SDM

Tabel 3.104 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0%	45,26 %	6,67%	62,96 %	62,96 %	60,74 %	22,22 %	54,07 %	58,96 %	59,70 %	58,21 %	52,99 %	100 %	45,40 %	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5,31%	9,29%	≥ 60 %	9,29%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	1,31%	0,43%	0,43%	0,86%	1,52%	1,30%	0,88%	1,32%	1,09%	1,32%	0,44%	2,16%	≤10% / bulan	1,09%	Dipertahan kan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertahan kan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	19,11 %	10,64 %	7,28%	8,62%	10,85 %	12,99 %	9,43%	8,55%	10,89 %	17,54 %	15,04 %	15,12 %	0%	12,17 %	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GEL S/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	64,13 %	64,13 %	65,02 %	65,02 %	65,02 %	65,02 %	65,02 %	65,92 %	65,92 %	65,92 %	65,92 %	65,92 %	100%	65,92 %	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	69%						48,13%						≥ 80 %	58,57 %	semesteran
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahan kan

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.105 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			

1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	Belum diisi	Belum diisi	100 %	100%	PDSA
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariat	100%	100%	96,67%	100%	100%	100%	100%	100%	96,67%	100%	Belum diisi	Belum diisi	100%	99,33%	PDSA
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	96,55%	97,56%	100%	100%	97,06%	100%	80%	98,18%	100%	100%	Belum diisi	Belum diisi	100%	96,94%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum diisi	Belum diisi	100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.106 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.107 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.108 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
ATEM																
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	0,00%	100%	100%	100%	≤ 80%	89,58%	PDSA
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada alat medis kritikal
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	-	-	-	-	-	-	-	-	5,26%	-	-	-	100%	5,26%	Alat di Kalibrasi di Bulan September
IPSRS																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis $\leq$ 15 menit	100%	100%	100%	100%	70,59%	43,35%	48,63%	15,96%	6,94%	40%	30,39%	45,88%	100%	58,48%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset $\leq$ 10 detik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	50%	0,00%	100%	100%	100%	100%	83,33%	PDSA
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

24. LAUNDRY

Tabel 3.109 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan penggunaa n APD	70%	70%	70%	70%	0%	0%	70%	0%	0%	-	-	-	100%	23,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian linen yang hilang	2 kejadia n	11 kejadia n	14 kejadia n	0 kejadia n	0 kejadia n	0 kejadia n	1 kejadia n	0 kejadia n	0 kejadia n	3 kejadia n	0 kejadia n	0 kejadia n	0 kejadia n	1 kejadia n	PDSA
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	3 kejadia n	3 kejadia n	1 kejadia n	2 kejadia n	1 kejadia n	2 kejadia n	2 kejadia n	2 kejadia n	3 kejadia n	3 kejadia n	1 kejadia n	2 kejadia n	0 kejadia n	3 kejadia n	PDSA
3.	Ketepatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahanka n

	pemeliharaan alat – alat pencucian linen															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25. CSSD

Tabel 3.110 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar 135 derajat (merubah pedoman di 2025)	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	96,43%	100%	90,48%	90,48%	95,61%	97,19%	96,39%	95,93%	96,97%	98,24%	98,39%	96,83%	100%	96,43%	PDSA (IGD, Poli, IRNA 2A)

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertifikasi baik bersih dan kotor	98,67%	99,88%	99,23%	88,10%	95,20%	96,48%	96,99%	97,41%	98,48%	98,13%	98,39%	96,83%	100%	96,98%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan	99,56%	98,67%	98,46%	86,51%	95,93%	98,24%	96,99%	96,76%	96,97%	98,60%	97,52%	96,83%	100%	96,75%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan CSSD (kecuali cito)															
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.111 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	27,27%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	98,35%	99,44%	98,71%	100%	-	100%	65,80%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,34%	100%	100%	100%	100%	100%	99,95%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	sehari untuk pasien non infeksius															
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,66%	100%	100%	100%	100%	100%	99,97%	PDSA
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤ 3/4 Tempat sampah	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	97,33%	92,86%	100%	95,16%	100%	100%	96,70%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,89%	98,29%	100%	100%	100%	99,43%	PDSA

27. KEAMANAN

Tabel 3.112 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, pengunjung dan karyawan	0 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan	90,32%	100%	100%	100%	100%	98,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,10%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift															
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	96,07%	97,74%	100%	100%	100%	100%	99,25 %	98,56 %	100%	100%	100%	100%	99,30 %	PDSA
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	74 kejadian	139 kejadian	234 kejadian	566 kejadian	741 kejadian	642 kejadian	1071 kejadian	485 kejadian	321 kejadian	430 kejadian	686 kejadian	604 kejadian	0 kejadian	499 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	98,92%	99,88%	98,60%	100%	98,71%	99,89 %	98,60 %	95,05 %	95,22 %	92,15 %	98,89 %	85,81 %	100%	96,81 %	PDSA
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	80%	62,50%	60,43%	67,56%	83,23%	88,44 %	85,48 %	84,19 %	87,11 %	77,63 %	84,44 %	82,04 %	100%	78,59 %	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.113 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	-	95,12%	94,79%	93,20%	96,09%	93,10%	95,41%	94,81%	89,47%	91,47%	100%	Belum diisi	100%	94,35%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Belum diisi	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Belum diisi	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT ≤ (lihat SPO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum diisi	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.114 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%	76,39%	75,98%	74,81%	79,38%	89,47%	89,62%	≥ 85%	82,89%	PDSA
2.	Kepatuhan APD	89,64%	89,87%	84,84%	97,92%	98,07%	93,80%	92,01%	83,84%	83,55%	91,48%	97,28%	92,31%	≥ 100%	91,22%	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI																

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	61,60%	82,75%	81,80%	82,39%	96,86%	90%	90%	90%	82,80 %	83,08 %	86,40 %	90,00 %	60 %	84,81 %	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	3,55%	1,07%	3,87%	6,33%	75,85%	69,66 %	75,19 %	76,00 %	76,00 %	80,77 %	80,83 %	80,37 %	75 %	52,46 %	Dipertahankan
3.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0,89%	1,19%	0%	0%	0%	0%	0,55%	0%	0%	0%	0,25%	≤ 1,5%	0,24%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	52,46%	87,50%	97,14%	95%	100%	88%	90%	100%	86,96 %	92,86 %	100%	100%	100%	90,83 %	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	55,24%	63,69%	60,00%	79,50%	72,75%	86,09 %	90%	88,85 %	90%	85,60 %	88,33 %	88,20 %	100%	79,02 %	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	87,10%	83,00%	90,91%	97,31%	84,42%	90,91 %	94,11 %	94,11 %	90,71 %	96,15 %	98,30 %	98,60 %	100%	92,14 %	PDSA
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	47,13%	58,53%	59,26%	56,67%	75,85%	78,54 %	66,67 %	69,58 %	78,63 %	77,78 %	79,33 %	77,78 %	100%	68,81 %	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	27,78%	47,22%	55,88%	50%	44,12%	50%	47,06 %	47,06 %	88,89 %	83,33 %	81,25 %	83,33 %	100%	58,83 %	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.115 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	39,29 %	65,18 %	64,29 %	50,00 %	55,36 %	64,29 %	52,68 %	61,61 %	51,79 %	56,25 %	54,46 %	59,82 %	100%	56,25 %	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	95,65 %	97,62 %	53,93 %	86,98 %	100%	100%	85,71 %	51,79 %	100%	100%	100%	100%	89,31 %	PDSA
3.	Ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi	24,66 %	65,22 %	97,62 %	52,50 %	97,14 %	58,60 %	73,17 %	30,36 %	30,36 %	93,33 %	95,38 %	100%	100%	68,20 %	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	41,07 %	65,18 %	65,18 %	50%	55,36 %	64,29 %	52,68 %	61,61 %	58,04 %	56,25 %	57,14 %	59,82 %	100%	57,22 %	PDSA
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, SBAR)	100%	75%	87,76 %	96,88 %	97,67 %	100%	97,05 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,20 %	PDSA
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis	100%	100%	100%	41,67 %	100%	100%	100%	100%	100%	83,33 %	100%	100%	100%	93,75 %	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	RSPH (prognas dan geriatri)															

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.116 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS	94,55%	98,08%	95,39%	95,03%	96,81%	97,24%	93,00%	93,81%	96,57%	95,89%	97,67%	97,59%	80%	95,97%	Dipertahankan
2.	kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	98,95%	98,52%	98,40%	94,81%	99,10%	99,76%	99,60%	99,74%	99,57%	99,70%	99,44%	99,93%	100%	98,96%	PDSA
3.	Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam	90,63%	91,63%	94,62%	93,09%	96,42%	95,43%	95,54%	95,18%	96,12%	96,48%	96,79%	96,68%	100%	94,88%	PDSA
4.	kelengkapan berkas triage E-	84,66%	90,63%	84,33%	87,87%	90,12%	91,67%	93,91%	94,74%	95,03%	95,27%	95,28%	97,13%	100%	91,72%	PDSA

	RM pada pasien IGD															
5.	Kejadian berkas pending klaim pasien BPJS	260 kejadian	226 kejadian	262 kejadian	216 kejadian	188 kejadian	164 kejadian	161 kejadian	155 kejadian	135 kejadian	112 kejadian	107 kejadian	83 kejadian	0 kejadian	172 kejadian	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepuasan Pasien MCU	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	Belum diisi	≥ 76,61%	70,00%	PDSA
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40,83%	37,50%	Belum diisi	0%	4,08%	PDSA
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0%	0,93%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,06%	0,83%	0,83%	Belum diisi	10% / tahun	0,20%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			

1.	Respon time CSO <30 mnt (WA)	16,27%	15,96%	15,13%	16,15%	12,09%	11,96%	12,21%	10,93%	10,49%	10,60%	11,04%	12,10%	100%	12,91%	PDSA
2.	Ketepatan perubahan jadwal dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Adanya SE tentang Penyesuaian Kebijakan Sesuai HFIS Versi 6.0

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Tahun 2025

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepuasan Pasien	95,35 %	92,31 %	95,56%	97,87%	94,12%	96,30%	95%	88,10%	93,10%	87,50%	92,63%	90,74%	≥ 76,61%	93,52%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP																
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	90,07 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,48%	91,88%	45,83%	100%	86,02%	PDSA
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	90,07 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,48%	91,88%	45,83%	100%	86,02%	PDSA

35. TB di IRJA

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PDSA
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥ 90%	100%	PDSA

36. KEUANGAN

Tabel 3.122 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<5%	0%	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	laporan keuangan															
4	Jumlah piutang ≥ 60 hari	2,39%												0%		Belum ada capaian

37. TIM HIV

Tabel 3.123 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penualaran ke pasien HIV	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	≥ 90%	50%	PDSA

38. KB

Tabel 3.124 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	100%	100%	100%	88,96 %	100%	100%	100%	89,81 %	100%	100%	100%	98,23 %	Dipertahankan
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	8,90%	17,74 %	10,87 %	69,15 %	7,20 %	16,06 %	13,16 %	18,18 %	17,56 %	11,46 %	22,40 %	24,06 %	50%	19,73 %	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan	98,01 %	100%	100%	100%	100%	96,35 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,53 %	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	dan curretage mendapatkan KIE KB															
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	96,75 %	100%	100%	97,26 %	100%	88,96 %	86,86 %	96,80 %	89,73 %	100%	100%	100%	30%	96,36 %	Dipertahankan

39. STUNTING

Tabel 3.125 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	41,67%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Triwulanan PDSA

4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

40. IT - SIM RS

Tabel 3.126 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Bulan Desember Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%	100%	94,44%	100%	100%	100%	100%	96,76%	PDSA
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	83,33%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	100%	100%	100%	100%	96,59%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	58,14%	50%	46,15%	37,50%	11,54%	58,54%	54,76%	47,62%	53,85%	63,64%	100%	100%	100%	56,81%	PDSA

BAB IV
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KESELAMATAN PASIEN

4.1 Jumlah Ketidaksesuaian Diagnosis Praoperasi dan Pasca Operasi pada Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Operasi		Jumlah Ketidaksesuaian
		Elektif	Cito	
1	Januari	364	59	0
2	Februari	346	47	0
3	Maret	363	69	0
4	April	376	66	0
5	Mei	413	81	0
6	Juni	392	92	0
7	Juli	494	98	0
8	Agustus	414	63	0
9	September	381	112	0
10	Oktober	395	136	1
11	November	379	94	0
12	Desember	365	96	0

Kesimpulan:

Berdasarkan data jumlah ketidaksesuaian antara diagnosis praoperasi dan pascaoperasi pada Bulan Oktober tahun 2025, tercatat 1 kejadian yaitu

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Pengkajian Awal Medis Gawat Darurat	1. Di bagian Keluhan saat ini : “Nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari ini, nyeri memberat tadi pagi. Pasien mengeluh lemas 1 minggu ini, mual – mual sering demam naik turun 1 minggu ini. Sudah diperiksa ke klinik dan diarahkan langsung ke IGD” . Dalam anamnesa ini tidak mencakup BAB, BAK, siklus haid dan riwayat penyakit ginekologi sebelumnya (kurang lengkap) 2. Di bagian Riwayat Kesehatan ditulis (-) seharusnya jika memang tidak ada ditulis saja tidak ada 3. Di bagian Riwayat Penggunaan Obat ditulis (-) seharusnya ada tulisan riwayat penggunaan obat dikarenakan Pasien mengeluh lemas 1 minggu ini, mual – mual sering demam naik turun 1 minggu ini dan sudah diperiksa ke klinik	1. Pengkajian ulang alur pemeriksaan awal di IGD, khususnya untuk pasien Perempuan usia produktif. 2. Lakukan refreshment pelatihan assessment awal medis untuk seluruh dokter IGD 3. Lakukan audit medis berkala 4. Lakukan pengkajian skala nyeri (perubahan skala nyeri pada pasien) menggunakan lembar observasi

		4. TTV dalam kondisi normal tidak sesuai dengan kondisi saat ini	
	Pengkajian Awal Keperawatan	1. Isi dari pengkajian awal keperawatan sama dengan pengkajian awal Medis Gawat darurat dan ini tidak boleh. Perawat harus membuat pengkajian awal keperawatan sendiri. 2. Dalam pengkajian nyeri lokasi nyeri : perut (ini kurang lengkap) harusnya disebutkan perut yang dibagian mana 3. Lama nyeri : 1 (keterangan nilai 1 itu menggambarkan yang seperti apa, 1 menit 1 jam atau yang seperti apa, keterangan kurang jelas) 4. Skala nyeri : 8 dan faktor yang memperingan nyeri yakni hanya istirahat (ini tidak sesuai) 5. Skrining risiko nutrisi / Gizi pasien bernilai 0 (tidak ada) padahal dalam pengkajian awal medis sebelumnya pasien mengeluh mual jadi kurang jelas 6. Diagnosa Keperawatan yang dibahas hanya nyeri berdasarkan anamnesa medis saja, mual dan demam tidak tertuang di diagnosa keperawatan sehingga intervensi hanya nyeri saja 7. Intervensi hanya manajemen nyeri seharusnya menganut OTEK (Observasi, Terapeutik, Edukasi, dan Kolaborasi) sedangkan dalam intervensi hanya kolaborasi 8. Kondisi pasien saat pindah tidak berubah yang tandanya tidak diperiksa 9. Kondisi pasien saat pindah tercantum MRS jam MRS tidak ada. Tetapi jam ada dibagian dipulangkan dan meninggal ada padahal pasien tidak meninggal dan pulang (sistem Otomatis)	1. Review pengkajian awal keperawatan agar sesuai dengan OTEK 2. Aktifkan pengawasan oleh Kepala Ruangan IGD. 3. Pengawasan Kabid Keperawatan dan Komite Keperawatan diaktifkan secara berkala.
	SBAR	1. Jam pemberi laporan dan penerima pesan sama yaitu 16.06 ini tidak sesuai dengan actualnya	1. Aktifkan pengawasan terhadap penerapan dan dokumentasi SBAR antarshift.

		2. Recommendation ada “pasien minta usg dulu tapi tidak merubah rencana tindakan” seharusnya USG sudah diberikan tanpa pasien meminta terlebih dahulu	2. Koordinasi dengan IT programmer mengenai Jam pemberi laporan dan penerima pasien agar sesuai dengan actual.
	USG Abdomen	1. Belum ada PPK terkait Kista Ovarium 2. Tidak terlihat kista pada ovarium saat USG	1. Review PPK CP terkait Apendiksitis 2. Audit PPK CP terkait Apendiksitis 3. Buat PPK CP terkait Kista Ovarium 4. Pelatihan refreshment untuk dokter IGD oleh Dokter Bedah dan Dokter Obgyn tentang pendekatan nyeri perut bawah pada pasien perempuan usia reproduktif
	Tanggapan Komite Medis	1. Belum ada SPO Perubahan Kondisi Durante Op 2. Wanita usia subur ada keluhan nyeri perut sebelah kanan maka hasil USG nya tidak menutup hanya apendiksitis melainkan ada kecurigaan penyakit kista 3. Review kembali checklist pemeriksaan IGD terkait nyeri perut.	1. Pembuatan SPO Perubahan Kondisi Durante Op 2. Informed Consent dari keluarga diperkuat jika ditemukan perbedaan temuan saat operasi (perubahan keputusan durante operasi diperkuat) 3. KIE dari nakes saat pre op jika wanita usia subur ada keluhan nyeri perut sebelah kanan maka hasil USG nya tidak menutup hanya apendiksitis melainkan ada kecurigaan penyakit kista. 4. Koordinasi Checklist Pemeriksaan Awal Medis IGD terkait Abdominal Pain dari Dokter Dimas

4.2 Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Berdasarkan Kejadian Reaksi Transfusi

No	Bulan	Jumlah Transfusi	Jumlah Reaksi Transfusi
1	Januari	154	0
2	Februari	64	0
3	Maret	74	0
4	April	73	0
5	Mei	84	0
6	Juni	84	0

7	Juli	85	0
8	Agustus	70	0
9	September	75	0
10	Oktober	80	0
11	November	150	0
12	Desember	85	0

Kesimpulan:

Analisis:

- Tidak terdapat kejadian reaksi transfusi selama periode Januari hingga Desember
- Hal ini menunjukkan bahwa proses transfusi darah di fasilitas layanan telah dilakukan dengan baik, sesuai prosedur, dan minim risiko.
- Namun, tidak adanya laporan reaksi bukan berarti risiko tidak ada. Ada kemungkinan kejadian ringan tidak terdokumentasi atau tidak dikenali sebagai reaksi transfusi.

Rekomendasi:

- b. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi**
Lakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan tentang identifikasi dan pelaporan reaksi transfusi, termasuk yang ringan
- c. **Audit dan Monitoring Berkala**
Lakukan audit klinis berkala terhadap prosedur transfusi dan dokumentasi efek samping untuk memastikan kepatuhan.
- d. **Evaluasi Pre-Transfusi dan Monitoring Ketat Post-Transfusi**
Pastikan semua pasien yang mendapat transfusi dimonitor selama dan setelah transfusi sesuai standar.

4.3Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Berdasarkan Penyakit Infeksi

No	HAIs	Bulan Ke- (Persentase)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Infeksi Daerah Operasi	0%	0%	1,19%	0%	0%	0%	0%	0,55%	0%	0%	0%	0,25 %
2	Infeksi Saluran Kemih	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Phlebitis	1,39%	1,14%	2,41%	2,08%	3,49 %	3,46 %	2,27 %	2,88%	3%	3,73 %	2%	2,68 %
4	VAP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Analisis Data HAIs Tahun 2025:

1. Infeksi Daerah Operasi (IDO)

- Muncul 1,19% di bulan ke-3 setelah 0% di bulan sebelumnya.
- Pada bulan lainnya nol kejadian, menunjukkan bahwa secara umum pengendalian infeksi bedah sudah baik
- Insiden tunggal tersebut perlu ditelusuri penyebab spesifik, seperti:
 - a. Protokol sterilisasi alat
 - b. Teknik aseptik
 - c. Pengawasan pemakaian antibiotik perioperatif

2. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

- Tidak terdapat insiden selama 11 bulan, menandakan kemungkinan protokol pemasangan dan perawatan kateter telah dijalankan dengan baik.

3. Phlebitis

- Secara keseluruhan, tren flebitis meningkat dibandingkan awal tahun
- Bulan 10 menjadi titik kritis dengan persentase tertinggi (>3%).
- Merupakan kejadian yang paling konsisten muncul, perlu perhatian khusus terhadap prosedur pemasangan dan perawatan infus

4. Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)

- Tidak terdapat kasus, mengindikasikan prosedur perawatan pasien dengan ventilator kemungkinan besar berjalan dengan baik atau jumlah pasien dengan ventilator rendah.

Rekomendasi:

1. Infeksi Daerah Operasi (IDO)

- Tingkatkan pelatihan prosedur infus bagi perawat (teknik pemasangan, perawatan harian)
- Evaluasi durasi pemakaian kateter perifer — idealnya tidak lebih dari 72–96 jam.

2. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

- Meskipun 0% dalam data, pencegahan tetap penting agar tetap *zero-case*.
- Evaluasi harian kebutuhan kateter dan segera lepas jika tidak lagi diperlukan.

3. Phlebitis

- **Perbaiki Prosedur Pemasangan Infus**

Meningkatkan teknik pemasangan dan perawatan infus untuk mengurangi iritasi dan risiko infeksi

- **Penggunaan Kateter dengan Bahan yang Lebih Ramah**

Menggunakan kateter intravena dengan bahan yang lebih biokompatibel untuk mengurangi risiko peradangan

- **Rotasi Lokasi Infus**

Memastikan lokasi pemasangan infus dirotasi secara berkala untuk mencegah iritasi pada satu area tertentu

4. Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)

- Meskipun tidak ada kasus, pencegahan tetap sangat penting karena VAP memiliki risiko mortalitas tinggi
- Menjaga ventilator tetap bersih dan melakukan sanitasi secara rutin untuk mencegah kontaminasi

4.4 Jumlah Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang dilaporkan ke Komite PMKP Pada Tahun 2025

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
JANUARI						
1	Pasien Ny. Emi terlambat mendapatkan pemberian labu darah	IRNA 2B	KTD	1	Hijau	IS
2	Pasien Meninggal dikarenakan Diagnosa CVA infark yang NE Pump seharusnya habis dan distop di IGD masih dilanjutkan di IRNA 2A	IGD	Sentinel	1	Merah	RCA
3	Pasien Meninggal dikarenakan Pemberian Injeksi Milos Tn Bambang yang seharusnya diberikan ke Ny A	IGD	Sentinel	1	Merah	RCA
4	Penanganan resusitasi pada pasien anak yang tidak ada SPO	IGD	KTC	1	Hijau	IS
5	Kerusakan Sampel darah	Laboratorium	KPC	1	Biru	IS
6	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	4	Hijau	IS
FEBRUARI						
1	Kesalahan Farmasi dalam Pelayanan Resep Obat Pasien	Farmasi	KNC	3	Biru	IS
2	Kesalahan Pemberian Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Laboratorium	KPC	2	Hijau	IS
3	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	4	Hijau	IS
4	Linen tercampur duk klem	IKO	KPC	2	Hijau	IS
5	Linen tercampur under pad	IRNA 2A	KPC	1	Hijau	IS
MARET						
1	Harum Pen yang memercik di IKO	IKO	KTD	2	Hijau	IS
2	Kesalahan Farmasi dalam Pelayanan Resep Obat Pasien	IRNA 2A	KNC	4	Hijau	IS
		IRNA 2B	KNC	1	Hijau	IS
		IRNA 3A	KNC	2	Hijau	IS
3	Pasien Rawat Inap Belum Terinput Konsulan Dokter	IRNA 2B	KPC	1	Hijau	IS
4	Kesalahan Input Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura	IRNA 3B	KTD	2	Hijau	IS
5	Salah Ketik Laporan Trombosit	Laboratorium	KNC	1	Hijau	IS
6	Kejadian Foto Thorax Masuk ke RM Pasien Lain	IKO	KNC	1	Biru	IS
7	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	5	Hijau	IS
APRIL						
1	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	5	Hijau	IS
2	Kesalahan pemberian obat oleh perawat yang terdeteksi setelah dilakukan double crosscheck	IRNA 2A	KNC	1	Biru	IS
3	Kesalahan Farmasi dalam Pelayanan Resep Obat Pasien	IRNA 2A	KNC	1	Biru	IS
		IRNA 3A	KNC	1	Biru	IS
4	Obat salah diberikan tetapi tidak mengalami efek samping	IRNA 2A	KTC	1	Biru	IS

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
5	Linen Tercampur Benda Lain	IKO	KPC	2	Hijau	IS
MEI						
1	Rekam Medis Ganda	Pendaftaran	KPC	11	Hijau	IS
2	Kesalahan Farmasi dalam Pelayanan Resep Obat Pasien	IRNA 3A	KNC	4	Hijau	IS
		IRNA 3B	KNC	2	Hijau	IS
3	Kematian Bayi	Ponek, IKO, NICU	Sentinel	1	Merah	RCA
4	Insiden Kematian Pasien Saat Menunggu Hasil BGA dan Tindak Lanjut Intubasi	IGD	Sentinel	1	Merah	RCA
5	Ketidaksesuaian Diagnosis Operasi dengan Tindakan Bedah yang Dilakukan dalam Rekam Medis Pasien	IKO (DPJP)	KTC	1	Hijau	IS
6	Ketidakteitian Apoteker dalam Mengupdate DPO Pasien	FARMASI	KPC	1	Hijau	IS
7	Kegagalan Pemasangan Kateter dan Ketidaksesuaian Prosedur dengan SOP	IRNA 2B	KTD	1	Hijau	IS
JUNI						
1	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	9	Hijau	IS
2	Kesalahan Farmasi dalam Pelayanan Resep Obat Pasien	Farmasi	KNC	1	Hijau	IS
3	tidak disampaikan hasil laboratorium kepada DPJP (dr. Rossy) karena perawat terdistraksi oleh informasi nilai kritis dari lab.	IRNA 2B & Laboratorium	KNC	1	Hijau	IS
4	Pertukaran Hasil Laboratorium Antar Pasien Bernama Sama pada Ruangan Berbeda	Laboratorium	KNC	1	Hijau	IS
5	Linen tercampur 2 Duk klem	IKO	KPC	1	Hijau	IS
6	Linen tercampur underpad	IRNA 2B	KPC	1	Hijau	IS
JULI						
1	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	4	Hijau	IS
2	Linen tercampur underpad	IRNA 3A	KPC	1	Hijau	IS
3	Di temukan instrumen arteri klem pada linen IKO	IKO	KPC	1	Hijau	IS
4	Kesalahan input hasil lab	Laboratorium	KNC	1	Hijau	IS
5	Lupa Input Pengiriman PA ke SIMRS Setelah Tindakan Operasi Debridement dan Biopsi pada Pasien	IKO	KNC	1	Hijau	IS
6	Kesalahan Input Obat di SIMRS, tetapi pasien mendapatkan obat yang benar oleh farmasi	Poli Kandungan	KNC	1	Biru	IS
AGUSTUS						
1	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	4	Hijau	IS
2	Lupa Input Pengiriman PA ke SIMRS Setelah Tindakan Operasi Debridement dan Biopsi pada Pasien	IKO	KNC	1	Hijau	IS
3	Tidak tersedianya stok albumin di farmasi saat dibutuhkan untuk penanganan pasien	Farmasi	Sentinel	1	Merah	RCA

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
	dalam kondisi hemodinamik tidak stabil.					
4	Kematian Pasien Post Laparotomi Kista Ovarium akibat Perdarahan Tidak Tertangani Tepat Waktu	Maternitas	Sentinel	1	Merah	RCA
5	Hasil Pemeriksaan Pra-op tidak lengkap yakni ECG pada pasien dengan penyakit kompleks & multikomplikasi (DM, sepsis, AKI, hiperkalemia)	IGD	KTD	1	Merah	RCA
6	Linen tercampur kartu penunggu pasien	IRNA 3B	KPC	1	Biru	IS
7	Linen tercampur Duk klem	IKO	KPC	1	Hijau	IS
8	Kesalahan penempelan etiket tidak sesuai dengan cairan yang disiapkan	Farmasi	KNC	4	Hijau	IS
SEPTEMBER						
1	kesalahan input hasil lab di SIMRS	Laboratorium	KPC	1	Hijau	IS
2	Salah Pasien saat Foto Thorax	IRNA 3B	KTC	1	Biru	IS
3	Kesalahan Pengisian Data Assessmen Awal Medis IGD	IGD	KNC	1	Biru	IS
4	Foto Thorax Pasien tertukar	Radiologi	KTC	1	Hijau	IS
5	Gagalnya Pengambilan Sampel Awal yang mengakibatkan perbedaan hasil lab	IRNA 2A	KTC	1	Biru	IS
6	Obat Pulang Pasien Tidak Diserahkan oleh Farmasi	Farmasi	KTD	1	Hijau	IS
7	Adanya Benda Asing pada Menu Kwetiaw Pasien	Dapur & Gizi	KTC	1	Biru	IS
8	Ketidaksesuaian Prosedur Anestesi dimana anestesi dilakukan oleh perawat bukan dokter	IKO	KTC	1	Biru	IS
9	Komunikasi Tidak Efektif antar Unit dalam menyampaikan Update Klinis & Hasil Konsul	IGD, IRNA 2A	KNC	1	Biru	IS
10	Pasien Tidak Terpasang Gelang Identitas mulai dari IGD, IKO sampai IRNA 3A	IGD, IKO, IRNA 3A	KTC	1	Biru	IS
11	Kesalahan Input Data DPJP pada Surat Kontrol Pasien	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
OKTOBER						
1.	Terjadi pembuatan dua atau lebih rekam medis untuk pasien yang sama	Pendaftaran	KPC	10	Hijau	IS
2.	Kesalahan Input Hasil Lab di SIMRS	Laboratorium	KPC	2	Hijau	IS
3.	Keterlambatan pemberian gentamicyn salep mata	IRNA 2B	KTC	1	Hijau	IS

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
	karena obat terbawa perawat sampai pulang					
4.	Tidak dimasukkannya cefotaxime dalam 24 jam pada pasien karena handover tidak dilakukan dengan benar	IRNA 2A	KTC	1	Hijau	IS
5.	Diskrepansi diagnose pra bedah (apendiksitis) dan pasca bedah (kista ovarium)	IKO	KTD	1	Kuning	RCA
NOVEMBER						
1	Terjadi pembuatan dua atau lebih rekam medis untuk pasien yang sama	Pendaftaran	KPC	6	Hijau	IS
2	Kesalahan Pemberian Obat (<i>Medication Error</i>) di IRNA 3A: Tertukar Kaen 3B dengan Kaen MG3	Farmasi	KNC	1	Hijau	IS
3	Pemulangan Pasien Lebih Awal (<i>Premature Discharge</i>) Tidak Sesuai <i>Advice</i> DPJP	IRNA 3B	KTD	1	Hijau	IS
4	Pasien tidak mendapatkan foto thorax sampai pasien pulang	IRNA 2A	KTD	1	Kuning	RCA
5	Tertukarnya <i>Advice</i> Terapi Pasien Lain (An. Ibrahim) ke Neonatus Hiperbilirubinemia (An. Lyora), Termasuk Pemberian Injeksi Santagesik, Ondansetron, dan Penyiapan Infus Ceftriaxone	Neonatologi	KTD	1	Hijau	IS
6	Tidak konfirmasi cara bayar pasien dengan abortus inkomplit ke DPJP sehingga ada perubahan status dari pasien rawat inap ke <i>one day care</i>	IGD	KTC	1	Biru	IS
7	Kesalahan pengisian situation pada SBAR Pasien oleh Dokter IGD	IGD	KPC	1	Biru	IS
8	Kegagalan Komunikasi dan Dokumentasi Klinis Terhadap Morbiditas pada Kasus Tn. Kakung dengan Operasi 3x dalam 1 bulan	IKO, IGD, IRNA, MOD-MPP, Gizi	KTD	1	Kuning	RCA
9	AC pada depo farmasi tidak berfungsi Berpotensi merusak efektivitas obat/sediaan	AC Depo Farmasi	KPC	1	Biru	IS

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
	farmasi, menyebabkan kegagalan terapi.					
10	Ubin di Poli Gigi Mumbul yang mengakibatkan resiko jatuh	Poli Gigi	KPC	1	Biru	IS
11	Handrail bed ICU Isolasi Rusak	ICU	KPC	1	Biru	IS
12	Lantai Basah di Radiologi akibat AC Bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	Radiologi	KPC	1	Biru	IS
13	Plavon Nurse station irja berjamur mengakibatkan risiko infeksi pernapasan (spora jamur) dan potensi ambruk	Nurse Station IRJA	KPC	1	Biru	IS
14	Plavon poli urologi berjamur mengakibatkan risiko infeksi pernapasan (spora jamur)	Poli Urologi	KPC	1	Biru	IS
15	Lampu di diruang pengolahan dapur kedap kedip	Dapur	KPC	1	Biru	IS
16	Saluran pembuangan AC di ruang Gizi yang pecah	Gizi	KPC	1	Biru	IS
17	Lampu di laboratorium yang mati	Laboratorium	KPC	1	Biru	IS
18	AC pada Kamar B3B9 bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 3B	KPC	1	Biru	IS
19	AC pada Kamar D3B bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 3B	KPC	1	Biru	IS
20	AC pada Kamar B. 2A. 5 AC bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 2A	KPC	1	Biru	IS
21	AC Central Farmasi Bocor Menetes dan Dispenser Farmasi rusak	Farmasi	KPC	1	Biru	IS
22	AC di Bed 4 Bocor menggenang di seluruh ruang ICU yang mengakibatkan resiko jatuh	ICU	KPC	1	Biru	IS
23	Tembok ruang Dahlia 2B.1.2 roboh	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
24	Adanya lubang di asbes ruang penyimpanan bahan kering dapur dibuat jalan tikus	Dapur	KPC	1	Biru	IS

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
25	Stop Kontak di kamar Bougenvillee 2.3 rusak	Maternitas	KPC	1	Biru	IS
26	Stop Kontak di kamar B2C1 terlepas	Maternitas	KPC	1	Biru	IS
27	AC pada Kamar B3B11 Bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 3B	KPC	1	Biru	IS
28	AC pada Kamar Dahlia Bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
29	Stop Kontak di kamar Dahlia 4,6,7 tidak bisa digunakan sehabis tersambar petir	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
30	2 Lampu di diruang pengolahan dapur kedap kedip	Dapur	KPC	1	Biru	IS
31	Handrail bed Dahlia 8 Rusak	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
32	Adanya kabel di poli mata yang berantakan yang mengakibatkan resiko jatuh	Poli Mata	KPC	1	Biru	IS
33	AC pada CT Scan bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	Radiologi	KPC	1	Biru	IS
34	AC pada Kamar Bougenville bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 3B	KPC	1	Biru	IS
35	AC pada Kamar Anggrek 3A.2 bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	IRNA 3A	KPC	1	Biru	IS
36	AC pada ruang tengah perin bocor yang mengakibatkan resiko jatuh	Perinatologi	KPC	1	Biru	IS
37	Cuvis di Perina Mati	Perinatologi	KPC	1	Biru	IS
38	D 2A 12 roda bed rusak	IRNA 2A	KPC	1	Biru	IS
39	AC di perina ada yang bocor, sama ada yang error 1 yang mengakibatkan resiko jatuh	Perinatologi	KPC	1	Biru	IS
40	Komunikasi tidak efektif dimana pasien	IRNA 2B	KNC	1	Biru	IS
DESEMBER						
1	ILO	IGD, Maternitas, IKO	KTD	1	Hijau	IS
2	Pasien Tidak Mendapat Terapi Sesuai Advice DPJP	IGD, IRNA 3A	KTD	1	Hijau	IS

No	Insiden	Unit Penyebab	Jenis Insiden	Jumlah Insiden	Grading Insiden	Ket.
3	Rekam medis ganda	Pendaftaran	KPC	4	Hijau	IS
4	Infus standar rusak: Berisiko botol infus jatuh atau posisi aliran infus tidak stabil	IRNA 2A	KPC	1	Biru	IS
5	Syring pump 2b rusak (penjepit patah): Sangat berisiko jika dosis obat tidak terjaga karena botol/sprit tidak terjepit sempurna	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
6	Manset Tensi pada Monitor Bocor: Menyebabkan hasil observasi tidak akurat, berpotensi salah diagnosa/tindakan	IRNA 2B	KPC	1	Biru	IS
7	2 mesin memert (sterilisator) tidak optimal: Risiko alat yang digunakan ke pasien tidak steril sempurna (Infeksi Nosokomial).	CSSD	KPC	1	Biru	IS
8	Gergaji gips tidak bisa menyala: Menghambat tindakan medis darurat pada pasien ortopedi.	Poli Orthopedi	KPC	1	Biru	IS
9	AC pra-operasi bocor: Tetesan air di area steril dapat memicu kontaminasi atau lantai licin.	IKO	KPC	1	Biru	IS
10	AC OKA 2 tidak dingin: Mengganggu suhu standar ruang operasi (risiko pertumbuhan bakteri dan ketidaknyamanan tim bedah).	IKO	KPC	1	Biru	IS

40

Ket:

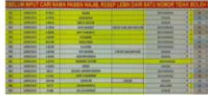
***IS: Investigasi Sederhana**

***RCA: Root cause Analysis**

1. Tindak lanjut dari Insiden Keselamatan Pasien Bulan September 2025

No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	Kesalahan input hasil lab di SIMRS	Konfirmasi ulang hasil lab yang benar dari petugas laboratorium	Double crosscek hasil lab sebelum input data di SIMRS
2	Salah Pasien saat Foto Thorax	1. Verifikasi ulang identitas pasien menggunakan tiga identitas (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam	1. Penguatan SPO Verifikasi Identifikasi Pasien dengan Petugas yang membawa pasien ke radiologi harus menyebutkan identitas lengkap pasien di depan

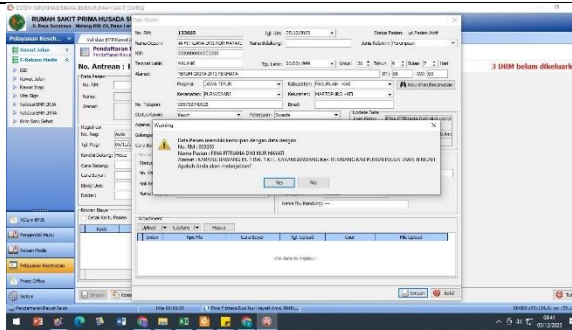
No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
		medis) pada kedua pasien 2. Pengaduan maaf langsung kepada keluarga pasien , penjelasan bahwa tidak ada dampak medis yang merugikan 3. Membatalkan hasil CXR pasien yang salah , dan melakukan CXR ulang untuk pasien yang benar (Daviano) .	petugas radiologi.
3	Kesalahan Pengisian Data Assessmen Awal Medis IGD	Konfirmasi kepada dokter yang menginput (dr. Nejoa) untuk melakukan koreksi asesmen awal medis pasien di E-RM (Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik)	1. Penguatan SPO Pengisian Asesmen Awal Medis IGD a. Setiap dokter wajib memverifikasi identitas pasien (3 benar) sebelum melakukan input asesmen atau tindakan. b. Dilarang melakukan input menggunakan billing rekan sejawat atau ID user lain 2. Supervisi Harian Kepala IGD
4	Foto Thorax Pasien tertukar	1. Unit radiologi menarik hasil foto thorax kedua pasien untuk menghindari penggunaan hasil yang tidak sesuai.	1. Penguatan SPO Verifikasi Identitas Pasien di Radiologi a. Petugas radiologi wajib melakukan verifikasi 2 benar pasien sebelum mengambil tindakan: nama dan tanggal lahir 2. Kelengkapan SPO di Unit Radiologi untuk staff baru 3. Supervisi oleh Kepala Radiologi ditingkatkan
5	Gagalnya Pengambilan Sampel Awal yang mengakibatkan perbedaan hasil lab	1. Pengambilan Ulang Sampel Darah 2. Verifikasi Hasil Lab Awal dan Ulang	Penerapan <i>Pemeriksaan Ganda</i> Sebelum Pengiriman Sampel: Setiap sampel harus diperiksa oleh petugas kedua untuk memastikan volume, label, dan kondisi fisik sampel.
6	Obat Pulang Pasien Tidak Diserahkan oleh Farmasi	1. Farmasi melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh resep pasien Ny. Nurul Hikmah (baik resep awal maupun tambahan) untuk memastikan kesesuaian antara input eRM, lembar resep fisik, dan spreadsheet. 2. Edukasi dan Komunikasi Ulang ke Pasien: a. Apoteker	1. Farmasi wajib menggabungkan semua resep pasien (awal + tambahan) dalam satu bundel resep sebelum disiapkan dan KIE 2. Dilakukan pemeriksaan akhir oleh petugas farmasi yang berbeda (double check).

No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
		melakukan re-KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasien untuk memastikan pasien memahami terapi obat yang benar (penghentian metformin dan kelanjutan insulin).	     
7	Adanya Benda Asing pada Menu Kwetiaw Pasien	1. Penarikan dan Penggantian Menu Terkontaminasi 2. Melakukan KIE dan permintaan maaf langsung kepada keluarga pasien serta memastikan makanan pengganti aman dan layak dikonsumsi 3. MOD (Dewi) mendampingi proses klarifikasi dan memastikan kepuasan pihak pasien terhadap penanganan kejadian.	Menegakkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di area dapur gizi untuk menjaga kebersihan dan Kenyamanan kerja.
8	Ketidaksesuaian Prosedur Anestesi dimana anestesi dilakukan oleh perawat bukan dokter	Membuat <i>berita acara klarifikasi</i> dan menyerahkan hasilnya ke Komite Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP).	1. Penguatan Budaya Keselamatan Pasien : Lakukan <i>pengarahan pra-operasi</i> wajib (time out) dengan memastikan seluruh waktu mengetahui dan hadir sesuai peran masing-masing (operator, anestesi, perawat, sirkuler). 2. Pembinaan dan Tindak Disiplin Bila Terulang : Jika ditemukan pelanggaran prosedur serupa di kemudian hari, dilakukan pelatihan dan, bila perlu, rekomendasi disiplin profesi oleh Komite Etik dan Disiplin Profesi Rumah Sakit.
9	Komunikasi Tidak Efektif antar Unit dalam menyampaikan Update Klinis & Hasil Konsul	Petugas ruangan wajib segera mengkonfirmasi hasil <i>jawaban konsul</i> dokter spesialis (dalam hal ini dr. Fendy Sp.BS) ke dokter pengirim konsul (dr. Aan Sp.N) dengan bukti dokumentasi (chat WA resmi, E-RM, atau form	1. Penguatan Koordinasi IGD – IRNA yakni dengan Menulis perawat dan dokter jaga ruangan memahami bahwa hasil konsul wajib diteruskan ke DPJP utama sebelum tindakan/keputusan lanjutan 2. Setiap pasien yang dirawat lebih dari 1 dokter wajib

No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
		komunikasi antar profesi)	melakukan komunikasi ke dr lainya terkait rencana asuhan medis yang akan diberikan
10	Pasien Tidak Terpasang Gelang Identitas mulai dari IGD, IKO sampai IRNA 3A	Segera mencetak dan memasang gelang identitas pasien sesuai data yang valid dari bagian pendaftaran.	Kepala ruangan/koordinator jaga wajib memonitor langsung pelaksanaan time out & serah terima sampai terbentuknya budaya disiplin.
11	Kesalahan Input Data DPJP pada Surat Kontrol Pasien	Perawat mengubah DPJP yang salah dari dr. Adit menjadi dr. Aji sesuai saran awal.	1. <i>Double Cross Check</i> wajib dilakukan oleh dua perawat berbeda (satu menginput, satu memverifikasi) sebelum pasien pulang. 2. Menambahkan prosedur checklist pada form pasien KRS oleh perawat yang memulangkan kemudian di verifikasi oleh katim/karu pada SPO terkait Pelayanan Asuhan Pasien BPJS

2. Tindak lanjut dari Insiden Keselamatan Pasien Bulan Oktober 2025

No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terjadi pembuatan dua atau lebih rekam medis untuk pasien yang sama	Segera identifikasi semua nomor Rekam Medis (RM) duplikat yang dibuat dan lakukan penggabungan data (<i>merging</i>) ke dalam satu RM yang benar oleh petugas rekam medis	1. Review SPO Pendaftaran 2. Kolaborasi dengan programmer untuk memunculkan notifikasi saat dilakukan pendaftaran dengan nama dan tanggal lahir yang sama
2.	Kesalahan Input Hasil Lab di SIMRS	Koreksi Data: Lakukan koreksi data hasil lab yang salah di SIMRS dan informasikan hasilnya (verbal & tertulis) kepada DPJP dan perawat yang merawat	1. Review SPO input hasil laboratorium 2. Pengaktifan double crosscheck antar petugas laborat
3.	Keterlambatan pemberian gentamicyn salep mata karena obat terbawa perawat sampai pulang	Amankan Obat: Segera hubungi perawat yang bersangkutan untuk mengembalikan obat dan pastikan obat telah diberikan kepada pasien	1. Review SPO Handover 2. Sosialisasi SPO Handover baru 3. Sosialisasi terkait PPJA dalam pembagian tim dan supervisi oleh kapid pelayanan
4.	Tidak dimasukkannya cefotaxime dalam 24 jam pada pasien karena handover tidak dilakukan dengan benar	Kaji dan Beri Obat: Segera kaji kondisi pasien (bersama DPJP) akibat tertundanya obat, dan berikan dosis <i>cefotaxime</i> yang terlewat sesuai instruksi DPJP	1. Review SPO Handover 2. Sosialisasi SPO Handover baru 3. Sosialisasi terkait PPJA dalam pembagian tim dan supervisi oleh kapid

No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
			
2	Kejadian Nyaris Cedera (KNC) Pemberian Obat: Tertukar Cairan Infus Kaen 3B dengan Kaen MG3 di IRNA 3A.	1. Perawat mengamankan cairan Kaen MG3 yang salah untuk barang bukti dan menukarkan kembali. 2. Melaporkan insiden ini sebagai KNC ke kepala ruang dan Komite PMKP	1. Mensosialisasikan SPO <i>dispensing</i> dan distribusi obat, khususnya untuk obat <i>High Alert</i>, dengan penekanan pada pencatatan verifikasi ganda yang harus ditandatangani oleh kedua petugas farmasi
3	Pemulangan Pasien Lebih Awal (Premature Discharge) Tidak Sesuai <i>Advice</i> DPJP	1. Konfirmasi dengan Dokter Penanggungjawab Pasien atas pemulangan pasien. 2. Monitoring rawat jalan terkait perkembangan kondisi pasien	1. Sosialisasi terkait proses hand over antar petugas 2. Koordinasi dengan Programmer IT terkait kualitas ERM dalam SIMRS
4	Pasien tidak mendapatkan foto thorax sampai pasien pulang	1. Konfirmasi ke Dokter Penanggungjawab pasien atas advice foto thorax ulang	1. Semua staff yang melakukan handover wajib tau kondisi pasiennya, dan wajib dilakukan komunikasi efektif 2. Buat SPO atau review Hand over dari IRJA-IGD dan SPO Hand Over dari IRJA-IRNA dan lakukan sosialisasi ke seluruh staff IRJA dengan waktu 2x24 jam 3. Staff melakukan sosialisasi prosedur konsultasi dokter keseluruhan staff IRNA 2A dengan waktu 2x24 jam dan akan dilakukan oleh supervise oleh Kabid 4. Staff melakukan sosialisasi NEWSS ke staff IRNA 2A dengan memberikan teori dan soal kasus dengan waktu 2x24 jam dan akan dilakukan oleh supervise oleh Kabid
5	Tertukarnya <i>Advice</i> Terapi Pasien Lain (An. Ibrahim) ke Neonatus Hiperbilirubinemia (An. Lyora), Termasuk Pemberian Injeksi Santagesik,	1. Stabilisasi pasien dengan menghentikan pemberian obat (melepas infus di pasien lyora) 2. Konfirmasi ke Dokter Irawan atas insiden tersebut	1. Perawat wajib melakukan verifikasi 2 identitas pasien 2. Pelatihan <i>Medication Error</i> pada Bulan Desember 2025

N o	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
	Ondansetron, dan Penyiapan Infus Ceftriaxone		
6	Tidak konfirmasi cara bayar pasien dengan abortus inkomplit ke DPJP sehingga ada perubahan status dari pasien rawat inap ke <i>one day care</i>	1. Mengkonfirmasi ke Dokter Obgyn mengenai cara bayar pasien 2. Segera merubah billing pasien dan menghapus inputan asuhan pasien rawat inap	1. Staff melakukan sosialisasi prosedur konsultasi dokter keseluruh staff IRNA 2A dengan waktu 2x24 jam dan akan dilakukan oleh supervise oleh Kabid 2. Sosialisasi SPO pendaftaran pasien, menekankan bahwa status Rawat Inap/ODC harus dikonfirmasi oleh DPJP
7	Kesalahan pengisian situation pada SBAR Pasien oleh Dokter IGD	1. Menginformasikan ke Dokter IGD agar segera memperbaiki bagian situation di form SBAR 2. Dokter IGD segera mengganti pengisian situation di form SBAR	1. Lakukan <i>refreshment training</i> atau <i>role-play</i> (simulasi) SBAR untuk semua Dokter IGD dan Dokter Jaga, menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan elemen S (Situation).
8	Kegagalan Komunikasi dan Dokumentasi Klinis Terhadap Morbiditas pada Kasus Tn. Kakung dengan Operasi 3x dalam 1 bulan	1. Audit kasus bersama tim manajemen	1. Pengkajian awal keperawatan IGD pada operasi pertama a. Koordinasi dengan programmer untuk perubahan penulisan GCS dengan format GCS : E...V...M b. Lakukan pengkajian ulang terkait diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan bisa muncul beberapa seperti pola nafas tidak efektif, hipertermi, vomiting, resiko syok, dan defisit nutrisi. Pengambilan diagnosa keperawatan sesuaikan dengan prioritas klinis pasien c. Lakukan pengkajian pada pasien meliputi keluhan pasien saat ini, riwayat pengobatan, riwayat penyakit terdahulu, riwayat operasi sebelumnya. Pengkajian wajib dilakukan penulisan sesuai dengan kondisi pasien pada saat masuk rawat inap d. Penulisan dosis dan rute wajib disesuaikan dengan penggunaan. Supervisi Ka. IGD dan Kabid (by name) e. Koordinasi dengan programmer untuk mengunci hasil pemeriksaan pengkajian awal medis (IGD, Penyakit dalam, bedah umum dll) dan pengkajian awal keperawatan. Pengkajian wajib dilakukan sesuai kondisi pasien pada saat dilakukan pemeriksaan awal di IGD (triase) dan

No	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
			di rawat inap pada saat pasien dilakukan transfer unit f. Lakukan diklat / role play pengisian skrining gizi pada perawat IGD g. Pengkajian pasien wajib meliputi RPO pasien termasuk penggunaan antibiotik dan lakukan penulisan pada form ERM yang tersedia. Koordinasikan dengan dokter jaga, DPJP serta farmasi terkait penggunaan obat-obatan pasien sebelumnya 2. Penggunaan antibiotik a. Dokter IGD, perawat serta apoteker wajib melakukan pengkajian ulang kepada pasien terkait penggunaan obat-obatan sebelumnya dan saling berkoordinasi dengan PPJA b. Penggunaan antibiotik oleh SPF penyakit dalam sudah sesuai dengan kondisi klinis pasien. c. Penggunaan antibiotik pre-op (profilaksis) disesuaikan dengan panduan PPRA RS yang terbaru. Bila pasien membuka lumen maka penggunaan antibiotik empiris. Koordinasi dengan tim PPRA. d. Penggunaan double antibiotik wajib dilakukan pemantauan oleh tim PPRA atau apoteker ruangan yang berdinan 3. Pengkajian awal medis Penyakit dalam dan Bedah umum a. Dokter wajib melakukan pengkajian ulang pada pasien pada saat dilakukan visite dan dilakukan penulisan Kembali di keluhan utama pasien b. Penulisan wajib dilakukan jenis pemeriksaan bila ada c. Penandaan wajib jelas disertai dengan kondisi pasien 4. Catatan perkembangan pasien terintegrasi a. Setiap pengkajian nyeri wajib mencantumkan PQRST di data subjektif b. Penulisan subjektif pasien diawali dengan data sebelumnya (sudah teratasi apa belum) c. Lakukan pencatatan perkembangan pasien pasca operasi. Lakukan edukasi kepada pasien pola gizi pasien pasca operasi dan pada saat pasien KRS d. Review ulang pedoman rekam medis terkait penggunaan singkatan. Apabila belum tersedia singkatan baru yang berada di ERM

N o	Insiden	Yang segera dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
			maka lakukan penambahan dan lakukan sosialisasi singkatan yang digunakan di RS 5. Edukasi : a. MOD/MPP wajib melakukan pengisian form A dan B serta form <i>discharge planning</i> pada pasien kasus bedah b. Review SPO pengisian form A dan B serta form <i>discharge planning</i>